GUÍA METODOLÓGICA

para el desarrollo de **Talleres Educativos de Salud Sexual** con Padres y Madres de Adolescentes

Dirigida al personal de salud



PERÚ Ministerio de Salud

GUÍA METODOLÓGICA

para el desarrollo de **Talleres Educativos de Salud Sexual** con Padres y Madres de Adolescentes

Dirigida al personal de salud

Catalogación hecha por la Biblioteca del Ministerio de Salud

Guía metodológica para el desarrollo de talleres educativos de salud sexual con padres y madres de adolescentes, dirigida al personal de salud / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Promoción de la Salud - Lima: Ministerio de Salud; 2026.

196 p. ilus.

SALUD SEXUAL / PERSONAL DE SALUD / ADOLESCENTE / SEXUALIDAD / RESPONSABILIDAD PARENTAL / EDUCACIÓN

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2026-08564

Guía Metodológica para el Desarrollo de Talleres Educativos de Salud Sexual con Padres y Madres de Adolescentes, dirigida al Personal de Salud

Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Promoción de la Salud. (MINSA / DGIESP / DPROM)

Responsables de la elaboración:

Janet Pesantes Sangay	DGIESP / DPROM
Dorina Vereau Rodríguez	Consultora independiente

Revisores:

Janet Pesantes Sangay	DGIESP / DPROM
Dalia Ponce Tejada	DGIESP / DPROM

Diseño y diagramación:

Roody Torres Luján	Editora EISA S.R.L.

© MINSA, julio, 2026

Ministerio de Salud
Av. Salaverry 801, Lima 11-Perú
Teléf.: (51-1) 315 6600
https://www.gob.pe/minsa/
webmaster@minsa.gob.pe

1a Edición, julio 2026

Versión digital disponible: https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/7990.pdf

La elaboración y publicación de este documento contó con la asistencia técnica y financiera del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco del proyecto "Liberando su potencial, Avanzamos todas" apoyado por el gobierno de Canadá.

Los contenidos de esta publicación no reflejan necesariamente el punto de vista oficial del UNFPA ni del Gobierno de Canadá.

PERÚ | Ministerio de Salud

JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO
Ministro de Salud

HENRY ALFONSO REBAZA IPARRAGUIRRE
Viceministro de Salud Pública

LUIS MELCHOR LORO CHERO
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

JULIO CÉSAR NIÑO BAZALAR
Secretario general

CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA
Director General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

MAX BENDEZU JAIME
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud

Colaboradores

Patricia Bravo Chávez	MINSA / DSARE
Sonia Rodriguez Soto	MINSA / DSARE
María Elena Yumbato Pinto	MINSA / DVICI
Ruth Espinoza Villafuerte	MINSA / DSAME
Raquel Zamata Chiri	MINSA / DSAME
Nency Virrueta Jiménez	MINSA / DPROM
Néstor Rejas Tataje	MINSA / DPROM
Dalia Ponce Tejada	MINSA / DPROM
Cristina Bravo Peña	DIRIS LIMA CENTRO / C.S. MAGDALENA
Dionicia Rivera Tocto	DIRIS LIMA CENTRO / C.S BREÑA
Clorinda Lachira Sandoval	DIRIS LIMA CENTRO / C.S MAX ARIAS SCHREIBER
Jackelin Rosas Sánchez	DIRIS LIMA CENTRO / C.S SANTA ROSA
Madeleny Pezo Ruiz	DIRIS LIMA CENTRO / C.S HUASCAR II
Jessica Jackeline Caballero Marín	DIRIS LIMA CENTRO / C.S. HUASCAR XV
Enrique Vera Bermúdez	DIRIS LIMA CENTRO / C.S SAN HILARION
Mery Helen Cardenas Oscanoa	DIRIS LIMA CENTRO / C.S JOSE CARLOS MARIATEGUI
Angelica Maria Rodriguez Juárez	DIRIS LIMA CENTRO / CS SS JUAN PABLO II
Julia Guillen Leon	DIRIS LIMA CENTRO / C.S JAIME ZUBIETA
Alessandra Romina Arenas Arteaga	DIRIS LIMA CENTRO / HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gina Giovanna Orellana Morales	DIRIS LIMA CENTRO / C.S. CAMPOY
Kira Soto Noria	DIRIS LIMA CENTRO / C.S. SAN FERNANDO
Carmen Rosa Vílchez Yllatopa	DIRIS LIMA CENTRO / C.S SAN FERNANDO
Maria Elena Esquivel Vera	DIRIS LIMA CENTRO
Charito Laura Olascuaga Camacho	DIRIS LIMA CENTRO
Jessica Milagros Ramos Vargas Machuca	PIURA / IPRESS SAN PEDRO
Maria Diana Leguía Torres	PIURA / IPRESS CASTILLA
Sara Lorena Gómez Meneses	PIURA / IPRESS CASTLLLA
Tatiana Garcia Valladolid	PIURA / IPRESS CATACAOS
Lourdes Annabella Montero Purizaca	PIURA / IPRESS LA ARENA

Giovanna Bella Vásquez Valladares	PIURA / IPRESS LA ARENA
Carmen Amelia Querevalu Querevalu	PIURA / IPRESS LA UNION
Ruby Noelia Bayona Pasco	PIURA / IPRESS LA UNION
Diana Elizabeth Romero Gonzales	PIURA / IPRESS TAMBOGRANDE
Cynthia Marilyn Zapata Rufino	PIURA / IPRESS TAMBOGRANDE
Judith Marlene Loly Carlos	PIURA / IPRESS SANTA JULIA
Cristina Del Carmen Rodríguez Jiménez	PIURA / IPRESS HUANCABMBA
Direla Milagros Torres Milagros	PIURA / IPRESS KM 50
Maria Edith Quispe Montenegro	PIURA / IPRESS KM 50
Carla Yoselyn Jaramillo Navarro	PIURA / IPRESS JUAN VALER SANDOVAL
Mary Ynés Campos Zapata	PIURA / IPRESS COMUNIDAD SALUDABLE
Carmen Antonieta Tesén Urbano	PIURA / IPRESS COMUNIDAD SALUDABLE
Ana maria Saavedra Gonzales	PIURA / IPRESS BELLAVISTA
Zarela Emperatriz Larrea Ricco	PIURA / IPRESS SECHURA
Ivonne Maribel Medina Colan	DIRESA PIURA
Diana Liz Janampa Quispe	AYACUCHO / RED DE SALUD SAN MIGUEL
Yelina Mary Rojas Egas	AYACUCHO / RED DE SALUD SAN MIGUEL
Giuliana Pocomucha Poma	AYACUCHO / RED DE SALUD SAN MIGUEL
Caroline Yance Rondinel	AYACUCHO / RED DE SALUD HUANTA
Gina Mitma Salvatierra	AYACUCHO / RED DE SALUD HUANTA
Jafsiba Tamna Osorio Atao	AYACUCHO / RED DE SALUD CENTRO
Maristela Huallanca Romisoncco	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Esther Mitma Huamán	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Chaska Yanela Challco Quispe	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Hilda Bautista Vega	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Isabel Bautista Pérez	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
David Quintana Marquina	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Mirian Jayo Huancahuari	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Senia Mejía Gálvez	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Marlene Yupanqui Coras	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Blanca Huaytalla Cuba	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Claudia Mendoza Pauca	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Edy Liliana Andia Quispe	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Yeny Medina Bautista	AYACUCHO / RED DE SALUD HUAMANGA
Darío Mallqui Najarro	DIRESA AYACUCHO
Miguel Fabricio Figueroa Guevara	DIRESA AYACUCHO
Brunel Oré Avendaño	DIRESA AYACUCHO
Maritza Huamanchao Paquiyauri	DIRESA AYACUCHO

Tabla de Contenido

Presentación. 9

I. ¿Cuál es la finalidad de la guía? 11

II. ¿Cuál es el objetivo de la guía? 11

III. ¿A quién está dirigida? 11

IV. ¿De qué trata esta guía? y ¿en qué espacios se desarrolla? 11

V. ¿Cuáles son los enfoques de la guía? 12

VI. ¿Cómo está organizada la guía? 12

VII. ¿Qué debemos tomar en cuenta para implementar la guía? 17

VIII. ¿Cuál es la metodología? 20

IX. Símbolos utilizados en la estructura de la guía. 21

X. Desarrollo de las sesiones 22

Eje 1: Acompañando el plan de vida de nuestros adolescentes: el rol de las madres y de los padres. 25

Sesión 1: Madres y padres aliados en la construcción del plan de vida 27

Eje 2: Comprendiendo los cambios de la adolescencia y el rol de la familia en la construcción de la identidad 43

Sesión 2: Construcción positiva de la identidad y la autoestima. 45

Sesión 3: Adolescencia: comprendiendo los cambios y manifestaciones de la sexualidad en esta etapa de la vida 61

Eje 3: Comprendiendo las dimensiones de la sexualidad para saber orientar a nuestros hijos adolescentes 83

Sesión 4: Mirando de manera integral la sexualidad 85

Sesión: 5: Mitos y verdades sobre sexualidad e importancia de educar desde el hogar 99

Eje 4: Acompañando a nuestros hijos adolescentes en la construccion de vínculos basados en el respeto y la igualdad 109

Sesión 6: Previniendo la violencia de género, con amor y respeto desde el hogar 111

Sesión 7: Acompañando a nuestros hijos en el enamoramiento 131

Sesión 8: Detectando riesgos a tiempo en relaciones con los amigos. 147

Eje 5: Hablando sobre salud sexual y reproductiva con nuestros hijos adolescentes. 161

Sesión 9: Herramientas para comunicarnos mejor en familia 163

Sesión 10: Acompañando a nuestros adolescentes para prevenir situaciones que ponen en riesgo su bienestar 177

Referencias bibliográficas 193

Anexos 195

Presentación

La adolescencia es una etapa decisiva en la vida de toda persona, marcada por profundos cambios físicos, emocionales y sociales. En este proceso, la familia cumple un papel central, especialmente padres y madres, quienes son los principales referentes en la formación de valores, actitudes y comportamientos. La educación sexual cuando es acompañada desde el hogar con apertura, confianza y orientación adecuada, contribuye al desarrollo de adolescentes más seguros, responsables y capaces de tomar decisiones saludables.

Conscientes de que muchas veces los padres y madres requieren apoyo para cumplir este rol, el personal de salud se convierte en un aliado estratégico. Por ello, esta guía ha sido elaborada con el propósito de brindar al personal de salud herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan fortalecer el rol que desarrollan las madres, padres y cuidadores de adolescentes en la educación sexual de sus hijos.

La guía ofrece temas de interés y técnicas sencillas para facilitar procesos de formación de adultos, para promover el diálogo, el análisis y la reflexión, el uso del pensamiento crítico para cuestionar factores sociales y culturales, como los mitos, estereotipos de género que influyen la sexualidad y para fortalecer desde la empatía, la capacidad de los padres y las madres para acompañar[1] a sus adolescentes en la vivencia de una sexualidad informada y responsable y alcanzar su desarrollo pleno y sus proyectos de vida.

La guía está estructurada en 5 ejes y 10 sesiones. Los ejes son: Eje 1 Acompañando el plan de vida de nuestros adolescentes: el rol de padres y madres, Eje 2 Comprendiendo los cambios propios de la adolescencia y el rol de la familia en la construcción de la identidad, Eje 3 Comprendiendo las dimensiones de la sexualidad para saber orientar a nuestros hijos adolescentes, Eje 4 Acompañando a nuestros hijos adolescentes en la construcción de vínculos basados en el respeto y la igualdad, y el Eje 5 Hablando sobre salud sexual y reproductiva con los adolescentes

Invitamos al personal de salud a hacer uso de esta guía como un recurso de apoyo en su labor cotidiana, con la convicción de que los padres, las madres y las familias en general, orientados y fortalecidos en su rol en el ámbito de la educación sexual, son clave para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de sus hijos adolescentes.

1 Acompañar a los y las adolescentes implica escucharlos, reconocer sus capacidades y apoyar sus decisiones de manera respetuosa". (UNICEF, Adolescencia: una etapa clave del desarrollo humano, 2019)



Guía Metodológica para el desarrollo de Talleres Educativos de Salud Sexual con Padres y Madres de Adolescentes

I. ¿Cuál es la finalidad de la guía?

Fortalecer el rol de las madres, padres y cuidadores de adolescentes en la educación de la sexualidad de sus hijos adolescentes.

II. ¿Cuál es el objetivo de la guía?

Brindar orientaciones técnicas y metodológicas al personal de salud para el desarrollo de talleres educativos sobre educación sexual dirigidos a padres, madres y cuidadores de adolescentes.

III. ¿A quién está dirigida?

El usuario de esta guía es el personal de salud capacitado que desarrolla actividades educativas dirigidas a padres, madres y cuidadores de adolescentes; y, es un material de referencia para los gobiernos locales y organizaciones que realizan acciones de promoción de la salud en la misma población objetivo.

IV. ¿De qué trata esta guía? y ¿en qué espacios se desarrolla?

Esta guía es una herramienta metodológica que contiene sesiones educativas estructuradas, para trabajar con padres, madres y cuidadores[2] de adolescentes en diferentes temas vinculados a la educación sexual durante la adolescencia. Con su implementación tendrán la oportunidad de informarse y aprender sobre

2 En el trabajo con niños y adolescentes, "cuidadores" se refiere a los adultos significativos que tienen a su cargo su protección, orientación y acompañamiento cotidiano, sean padres biológicos, tutores o familiares (UNICEF, 2021)

cómo orientar a sus hijos[3] en sexualidad, y a empoderarlos para que tomen decisiones autónomas, informadas y responsables sobre su cuerpo y sus relaciones interpersonales, contribuyendo a una vivencia sana y responsable de la misma, previniendo riesgos para su salud sexual y reproductiva, compatible al desarrollo de su plan de vida, en el marco de todos sus derechos.

La guía metodológica se desarrolla en espacios comunitarios como: locales comunales, organizaciones sociales de base que reúnen a mujeres o familias, Centros de Desarrollo Juvenil – CDJ, instituciones educativas, entre otros. Estas actividades pueden ser promovidas por gobiernos regionales, locales, organizaciones sociales, iglesias u otras instituciones interesadas, en coordinación con el personal de salud.

V. ¿Cuáles son los enfoques de la guía?

Son cuatro los enfoques principales: enfoque en derechos humanos, enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, enfoque de interculturalidad, y el enfoque de curso de vida, los que se transversalizan a lo largo de la guía.

Enfoque en derechos, implica contribuir a sensibilizar a los padres de familia sobre los derechos humanos, particularmente reconocer y apoyar los derechos sexuales y reproductivos de sus hijos adolescentes garantizando su bienestar y proyecto de vida.

Enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, - busca equilibrar las relaciones entre hombres y mujeres, sobre la base del derecho a la igualdad, la dignidad, el libre desarrollo, el bienestar y la autonomía. Asimismo, impide la discriminación en todas las esferas de la vida pública y privada y promueve la plena igualdad de oportunidades, reconociendo las particularidades que los distinguen y complementan[4].

Enfoque de curso de vida, implica el reconocimiento de que las personas atraviesan distintas etapas de desarrollo —desde la niñez hasta la adultez—, y que en cada una de ellas se presentan necesidades, capacidades y desafíos específicos con relación a la educación sexual y que requiere que los contenidos y mensajes se apliquen, adaptando de manera progresiva a la edad y contexto de cada grupo etario.

Enfoque intercultural, implica promover el diálogo, la apertura y la comprensión de la diversidad cultural, el respeto por los conocimientos, las creencias y las costumbres de los distintos contextos de procedencia de padres y madres.

La aplicación metodológica de la presente guía, debe considerar la pertinencia cultural, valorando la identidad individual y colectiva enriquecida a través del diálogo de saberes entre el personal de salud y los padres, madres y cuidadores.

VI. ¿Cómo está organizada la guía?

La guía está organizada en 5 ejes temáticos, cada uno de ellos establece competencias y capacidades que se espera alcanzar. Se desarrollan 10 sesiones, los contenidos, el número y nombre de las sesiones educativas sobre educación de la sexualidad, se presentan de manera organizada en la siguiente tabla:

3 En el desarrollo de la presente guía, el término hijo incluye a ambos sexos. Ley 32003.
4 Ley 32535, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Ejes, competencias, capacidades, contenidos y sesiones



COMPETENCIA GENERAL: Acompaña de manera informada, reflexiva y respetuosa el desarrollo integral de sus hijos adolescentes, promoviendo decisiones responsables, fortaleciendo su identidad y autoestima, orientando sobre sexualidad desde un enfoque integral y previniendo situaciones de riesgo como el embarazo no intencionado y la violencia contra las mujeres mediante una comunicación abierta y vínculos basados en el respeto y la igualdad.

EJE	COMPETENCIA	CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN	TIEMPO
1 Acompañando el plan de vida de nuestros hijos adolescentes: El rol de las madres y de los padres.	Reconoce la importancia de su participación e influencia y responsabilidad en el proyecto de vida de su hijo adolescente.	Favorece en sus hijos la toma de decisiones responsable.	Toma de decisiones. Proyecto de vida.	**1 Madres y padres aliados en la construcción del plan de vida.**	90 minutos
		Reconoce la importancia de su rol en el proyecto de vida de su hijo adolescente	Metas realistas y objetivos alcanzables Importancia de la responsabilidad y la motivación en el logro del proyecto de vida. Rol de padres y madres.		
2 Comprendiendo los cambios propios de la adolescencia y el rol de la familia en la construcción de la identidad de nuestros hijos adolescentes.	Comprende cómo se construye la identidad y su vínculo con la autoestima, analizando la importancia de la formación positiva de la identidad de sus hijos adolescentes, asumiendo su rol como referentes en la educación sexual	Comprende cómo se construye la identidad y su relación con la autoestima	La construcción de la identidad en la adolescencia (Relaciones sociales, la retroalimentación de los demás, la cultura, y la autoimagen, la aceptación del propio cuerpo).	**2 Construcción positiva de la identidad y la autoestima.**	90 minutos
			La autoestima: pilares y componentes y cómo impactan en la identidad en la adolescencia		
		Comprende la importancia de la formación positiva de la identidad en la adolescencia y valora su rol como padres y madres.	La formación positiva de la identidad Rol de los padres, madres y/o cuidadores.		

EJE	COMPETENCIA	CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN	TIEMPO
2 Comprendiendo los cambios propios de la adolescencia y el rol de la familia en la construcción de la identidad de nuestros hijos adolescentes.	Reconoce y comprende los cambios físicos, emocionales y sociales que viven sus hijos adolescentes, valorando la educación en salud y el acompañamiento familiar durante el desarrollo adolescente basado en el respeto y la comunicación	Reconoce los cambios físicos, emocionales y sociales de la adolescencia y las expresiones de la sexualidad en esta etapa, en el contexto social y cultural actual.	Los cambios físicos, emocionales y sociales durante la adolescencia en el contexto social actual y en la diversidad cultural.	**3 Adolescencia: comprendiendo los cambios y manifestaciones de la sexualidad en esta etapa de la vida.**	90 minutos
			Las expresiones de la sexualidad adolescente: La primera menstruación, la polución nocturna, la masturbación, el enamoramiento, el inicio sexual, la abstinencia.		
		Comprende la importancia de la educación en salud e higiene menstrual.	Bienestar físico, mental y social durante el ciclo menstrual, acceso a productos de higiene, privacidad, estigma y discriminación asociados a la menstruación.		
		Reconoce la importancia de acompañar el desarrollo de sus hijos adolescentes.	Rol de la familia en el desarrollo de sus hijos adolescentes.		
3 Comprendiendo las dimensiones de la sexualidad para orientar a nuestros hijos adolescentes.	Reconoce la sexualidad como una dimensión integral de la vida, relacionándola con su contexto sociocultural y promoviendo una educación sexual basada en el respeto y la información científica	Comprende la sexualidad como dimensión integral de la vida y cómo se relaciona con otros aspectos del contexto socio cultural.	Sexualidad como dimensión integral (biológica, psicológica, social y ética) y cómo se relaciona con otros aspectos del contexto sociocultural.	**4 "Mirando de manera integral la sexualidad**	90 minutos
		Analiza críticamente los mitos y creencias sobre la sexualidad	Derribando mitos y creencias sobre la sexualidad y la educación sexual.	**5 "Mitos y verdades sobre la sexualidad e importancia de educar en este ámbito desde el hogar".**	90 minutos
		Reconoce la importancia de la educación sexual	Importancia de la educación sexual desde el hogar.		

EJE	COMPETENCIA	CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN	TIEMPO
4 **Acompañando a nuestros hijos adolescentes en la construcción de vínculos basados en el respeto y la igualdad.**	Reflexiona sobre la violencia basada en género y la importancia de prevenirla, acompañando de manera comprensiva el proceso de enamoramiento de sus hijos adolescentes e identificando señales de alerta y cómo y dónde buscar ayuda.	Reflexiona sobre la violencia basada en género y toma conciencia sobre la importancia de prevenirla.	Comprendiendo qué es la violencia basada en género (VBG): Estereotipos y roles de género, el machismo.	**6** **Previniendo la violencia de género, con amor y respeto desde el hogar.**	90 minutos
			Consecuencias de la violencia de género en los adolescentes y la importancia de la dinámica familiar en su prevención. Violencia sexual: tipos		
		Acompaña el proceso de enamoramiento de su hijo adolescente, y conoce cómo actuar frente a señales de alerta de situaciones de violencia	El enamoramiento como manifestación natural del proceso de desarrollo psicológico y sexual en la adolescencia.	**7** **Acompañando a nuestros hijos en el enamora-miento**	90 minutos
			Cómo hablar con nuestros hijos sobre sus propios límites y el respeto a los demás. Autonomía corporal y consentimiento.		
			Diferencia entre relaciones afectivas sanas y relaciones nocivas y cómo alertar a nuestros hijos adolescentes.		
		Reconoce señales de alerta en las relaciones sociales (con amigos), el rol de los padres y dónde acudir en caso de necesitar ayuda.	Los amigos y su influencia Señales de alerta en las amistades presenciales (aislamiento, exclusión)	**8** **Detectando riesgos a tiempo en las relaciones con los amigos.**	90 minutos
			Señales de alerta en redes sociales (Ciberacoso, Grooming, Sexting)		
			Rol de los padres y madres y dónde buscar ayuda. - rutas de acceso a orientación y atención integral.		

EJE	COMPETENCIA	CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN	TIEMPO
5 **Hablando sobre salud sexual y reproductiva con nuestros hijos adolescentes.**	Fortalece la comunicación con sus hijos adolescentes, abordando con apertura y respeto temas relacionados con la sexualidad, reconociendo los beneficios de los métodos anticonceptivos y valorando su rol en la prevención del EA y las ITS.	Conoce cómo comunicarse mejor con su hijo adolescente.	La comunicación con los hijos adolescentes, barreras intergeneracionales y estrategias para superarlas.	**9** **Herramientas para comunicarnos mejor en familia.**	90 minutos
			Técnicas de comunicación asertiva, escucha activa, afrontamiento de la presión social. El respeto a su privacidad.		
		Dialoga con sus hijas adolescentes sobre las situaciones difíciles asociadas a la vivencia de la sexualidad	El embarazo en la adolescencia, las ITS y el VH, las uniones y matrimonios tempranos y la violencia sexual	**10** **Acompañando a nuestros hijos adolescentes para prevenir situaciones que ponen en riesgo su bienestar**	90 minutos
			Reflexiona sobre las causas y consecuencias del EA y las ITS y otras situaciones difíciles, y los factores contextuales y socioculturales.		
		Reconoce los beneficios de la metodología anticonceptiva en los adolescentes que han iniciado su actividad sexual, Valora su rol en la prevención del EA y las ITS y en dónde encontrar ayuda	Beneficios de los métodos anticonceptivos. Derribando mitos sobre los métodos anticonceptivos.		
			Rol de padres y madres en la prevención del EA y las ITS Dónde encontrar ayuda.		

VII. ¿Qué debemos tomar en cuenta para implementar la guía?

7.1. Consideraciones para el desarrollo de las sesiones

- Las sesiones educativas descritas en la presente guía deben desarrollarse en su integridad. No obstante, atendiendo al contexto operativo y a las necesidades de cada grupo, los equipos regionales podrán priorizar un conjunto mínimo de ocho (08) sesiones para su implementación.
- Cada establecimiento de salud deberá ofertar un programa de sesiones de Educación Sexual dirigido a padres, madres y cuidadores de adolescentes, utilizando sus propios mecanismos de difusión y/u otros canales institucionales de la DIRIS, DIRESA/GERESA
- Las sesiones deben programarse con frecuencia semanal, en los horarios de mayor disponibilidad de padres, madres y cuidadores de adolescentes.
- Se recomienda solicitar a los participantes un compromiso escrito de asistencia a la totalidad de las sesiones.
- Los establecimientos de salud en coordinación con los gobiernos locales, podrán ofrecer una constancia de reconocimiento para quienes cumplan con todas las sesiones programadas. Asimismo, se entregará a cada participante una cartilla de asistencia, la cual será sellada en cada sesión.
- Cada sesión educativa debe contar con un máximo de 20 participantes, con una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos por sesión.
- Los ambientes destinados a las sesiones deben garantizar condiciones adecuadas: capacidad para albergar cómodamente al grupo, ventilación, iluminación y mobiliario básico (sillas, mesas, pizarra).
- La implementación de las sesiones estará a cargo de facilitadores capacitados en el uso de la guía, idealmente conformando un equipo mixto (hombre y mujer).
- Las sesiones educativas no son expositivas. Su enfoque es participativo, orientado a la reflexión de padres, madres y cuidadores, lo cual exige habilidades de comunicación, escucha activa y empatía por parte de las y los facilitadores.
- Dado que algunos temas pueden resultar sensibles, se requiere que los facilitadores brinden un acompañamiento cuidadoso, validación y contención emocional a los participantes y, cuando corresponda, realicen las derivaciones a los servicios pertinentes.

7.2. Adecuación y/o adaptación de acuerdo al ámbito regional, local o comunal

Las sesiones deben ser adaptadas al contexto sociocultural de cada región, incorporando expresiones, imágenes, ejemplos y elementos culturales pertinentes que faciliten una interacción más cercana con la realidad local.

- Para participantes con limitado nivel de alfabetización, se deben realizar adaptaciones metodológicas que favorezcan la reflexión y la apropiación de las ideas centrales de cada tema mediante recursos visuales, dinámicas y estrategias de educación popular.

- La guía presenta alternativas básicas para la adaptación intercultural; sin embargo, estas deben ser evaluadas, contextualizadas y ajustadas por los equipos de salud de cada región, quienes son los que poseen el conocimiento directo de las características socioculturales y comunicacionales de la población a la que atienden.

7.3. Perfil de los facilitadores:

- Los facilitadores deben ser profesionales de salud con sólida formación en los temas que aborda la guía: adolescencia, salud sexual y reproductiva, educación sexual y promoción de la salud sexual con las familias y adolescentes.
- Los facilitadores deben estar capacitados en el uso de la guía metodológica y en habilidades de comunicación para la facilitación de talleres.
- Los facilitadores deben tener amplio conocimiento de la realidad local y experiencia de trabajo con personas adultas de poblaciones diversas.
- Deben poseer habilidades de comunicación, capacidad de escucha, empatía, habilidades para la contención emocional, y una actitud amable y respetuosa frente a opiniones diferentes.
- Deben ser profesionales responsables, dinámicos, proactivos, con capacidad de trabajar en equipo, y con capacidad de adaptación.

7.4. Recomendaciones a los facilitadores para los diversos momentos del taller:

Antes de cada taller

- Revise la guía, sus contenidos, las ideas centrales y las técnicas metodológicas que usará.
- Tome en cuenta el contexto cultural (zona urbana o rural, indígena, andina, amazónica o afroperuana) para asegurar que los recursos y los mensajes sean culturalmente pertinentes.
- Adapte las dinámicas, los materiales educativos, como las fichas de trabajo, los casos o las historias para analizar y cualquier otro recurso, a las características de la población con la que trabaja.
- Prepare con antelación los materiales y los equipos que se requieren para cada sesión.
- Acondicione el ambiente donde se realizarán los talleres.
- Asegure que los ambientes para el desarrollo de las sesiones sean amplios, ventilados, y cuenten con sillas movibles y mesas.
- Tome en cuenta que algunas madres pueden asistir con hijos pequeños. En esos casos, coordine con el gobierno local para disponer de un espacio seguro y adecuado donde los menores puedan permanecer y entretenerse durante la sesión.

Durante el taller

- Reciba con entusiasmo y calidez a los participantes.

- En el primer taller, lleve a cabo la sesión de apertura, tal como se describe en el apartado correspondiente.
- Escuche con atención a los participantes sin emitir juicio de valor.
- Brinde las consignas con claridad, monitoree que se entiendan y que las cumplan.
- Propicie la participación de todos los asistentes.
- Use un lenguaje apropiado a las características del grupo y a la realidad local.
- Use las ideas centrales cuando se necesiten: durante la etapa inicial, la actividad de desarrollo o durante el cierre.
- Durante los trabajos grupales, motive a los padres y madres a dar su opinión
- Durante las reflexiones grupales, disponga a todos en círculo para que puedan mirarse y escucharse.
- Repregunte amablemente cuando no haya obtenido una respuesta completa a alguna de las preguntas.
- Regule el uso de la palabra, cuidando que todos tengan la posibilidad de hablar y que nadie haga uso excesivo de su derecho a hablar.
- Mantenga el buen ánimo y una actitud positiva incluso si algunos temas generan resistencia entre los participantes, sea empático y de validación cognitiva.
- Refuerce o complemente con algunas ideas centrales para consolidar el aprendizaje y la motivación para el cambio de actitudes y prácticas.
- Preste atención al comportamiento de los participantes, para identificar si alguno se ha sentido aludido, emocionalmente movilizado por los contenidos, o desee hablar o requiera más información.
- Brinde información sobre los servicios de salud donde puede ser atendido en caso lo necesite.



Después del taller

- Evalúe de forma breve cada taller, por ejemplo, con emoticones, tiro al blanco o con solo una palabra, para conocer el grado de satisfacción con las sesiones. En la sección anexos se desarrollan algunas de estas técnicas.
- Informe sobre la existencia de establecimientos de salud u otros servicios de la comunidad para adolescentes y sus familias.

VIII. ¿Cuál es la metodología?

Las sesiones educativas serán desarrolladas siguiendo una secuencia metodológica con técnicas activas, que ponen al participante en el centro del proceso "aprender haciendo", donde la acción y la experiencia son la base para adquirir el conocimiento.

Los momentos metodológicos en cada sesión son:

a) **Inicio:** En este momento se motiva y se introduce el tema. También se recogen experiencias previas y saberes que son la base sobre la cual se construye el nuevo saber.

b) **Desarrollo:** Es el momento de la construcción de aprendizajes, para el cuestionamiento del saber previo, mediante el análisis crítico individual y grupal. Aquí se comparten diversas percepciones e información.

c) **Cierre:** Es el momento de aplicar los aprendizajes y generar los compromisos de cambio hacia actitudes favorables a lograr una mejor comunicación con sus hijos. Se reflexiona sobre el aprendizaje y la transferencia del mismo, aplicándolo a nuevas situaciones, como tareas o problemas de la vida cotidiana.



Las sesiones educativas no son expositivas, es decir no son charlas donde el personal de salud habla de un tema en particular; las sesiones son dialogadas y participativas. Además, se emplea metodología activa y lúdica, por ello se les denomina talleres.

IX. Símbolos utilizados en la estructura de la guía

A lo largo de la guía encontrará diversos símbolos que destacan sus secciones y actividades clave vinculadas con el desarrollo de las sesiones.

EJE TEMÁTICO



Información teórica
Es exclusivamente para el facilitador. Para que se prepare sobre los temas.

SESIÓN



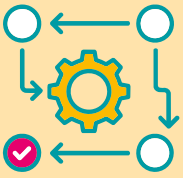
Objetivo de la sesión.



Tiempo de duración de la sesión.



Materiales a usar en la sesión.



Secuencia metodológica de la sesión: aquí se desarrollan las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre.



Recursos de apoyo
Son materiales educativos para uso del facilitador y para el trabajo de las y los participantes.



Ideas centrales que el facilitador debe transmitir a los participantes.

X. Desarrollo de las sesiones

Sesión de Apertura



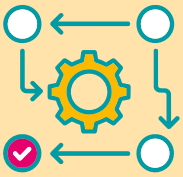
OBJETIVO:
Presentar la finalidad, objetivo, sesiones y metodología de trabajo.



TIEMPO:
30 minutos.



MATERIALES:
- PPT o un papelógrafo con los finalidad, objetivo, sesiones, metodología y reglas de convivencia.
- Ovillo de lana.



SECUENCIA METODOLÓGICA

1. Bienvenida

Para dar inicio a los talleres dirigidos a padres, madres y cuidadores de adolescentes, diríjase al grupo de manera cordial y brinde una cálida bienvenida. Agradezca su presencia, reconozca el tiempo que dedican y la motivación que los ha llevado a participar en estas sesiones.

Preséntese indicando su nombre, profesión y centro de trabajo, y mencione que será la persona encargada de facilitar las sesiones (mencione su nombre). Permita que también se presente el co-facilitador.

Exprese su entusiasmo por la oportunidad de compartir este espacio de reflexión y aprendizaje sobre un tema tan valioso como es la educación sexual de sus hijos adolescentes.

2. Explicación del objetivo

Con el apoyo de una presentación en PowerPoint o papelógrafo señale cuál es el objetivo de estos talleres:

- Fortalecer el rol de madres, padres y cuidadores en la educación sexual de sus hijos adolescentes.

Explique que el propósito final de este programa es:

- Que las madres y padres sean capaces de ofrecer un entorno de confianza a sus hijos y orientarlos a través de un diálogo abierto y respetuoso para que tomen decisiones informadas sobre su sexualidad.

3. Explicación de las sesiones

Explique cómo están organizadas las sesiones: cuántas serán, con qué frecuencia se realizarán y qué temas se abordarán en cada una.

4. Explicación de la metodología

- Comente que se trata de sesiones en las cuales se desarrollarán diversas actividades; y, en donde la participación activa de parte de ellos es muy importante.
- En cada sesión se harán actividades para pensar, reflexionar y aprender juntos sobre distintos temas de la sexualidad.
- Explique también que aprenderán y practicarán algunas herramientas para fortalecer la comunicación y la confianza con sus hijos.
- Finalmente, invite a que formulen preguntas y responda con amabilidad, de manera breve y entusiasta.

5. Presentación de los participantes

- Indique que realizarán un breve ejercicio de presentación. Cada participante dirá su nombre, su edad, con quiénes vive, los nombres y edades de sus hijos, y qué actividad le gusta hacer en sus ratos libres.
- Pida que formen un círculo. Una persona tomará la punta de un ovillo de lana y se presentará, luego, sin soltar la punta, lanzará el ovillo a otro participante, y así sucesivamente hasta que todos se hayan presentado.
- El co-facilitador iniciará la dinámica.
- Al finalizar, pregunte: ¿Qué se ha formado?
- Explique que esta red representa a un grupo de personas unidas por un mismo propósito: ser madres, padres y cuidadores comprometidos con acompañar a sus hijos en su desarrollo y educación sexual.
- Agradezca la participación de todos y todas.

6. Reglas de convivencia

Comente que este es un espacio seguro para hablar, compartir y aprender juntos. Destaque que cada opinión, duda o experiencia que compartan es valiosa y que estas sesiones están pensadas para escucharlos y dialogar.

Explique que, para lograr un ambiente de confianza y respeto, es importante establecer algunas reglas y con los aportes del grupo se pueden organizar las reglas de convivencia.

Con el apoyo de una PPT o papelógrafo, muestre las siguientes reglas de convivencia:

- Nos tratamos con amabilidad y respeto
- Escuchamos sin juzgar
- Todos tenemos derecho a participar
- Todas las dudas y preguntas son bienvenidas
- Lo que se comparte aquí, no se comenta fuera del grupo.
- Mantendremos los celulares apagados.

Pregunte si desean agregar alguna otra regla y de ser pertinente, añádala a la lista.

7. El mural de los compromisos

Para cerrar, comente que en cada sesión se contará con un "Mural de los compromisos", donde padres, madres y cuidadores podrán colocar una tarjeta con el compromiso personal que decidan asumir a partir de lo aprendido.

Si el compromiso escrito no fuera conveniente para todos (por ejemplo, en casos en que algún participante no sepa escribir), puede adaptarse invitándolos a dejar un dibujo que exprese su deseo de mejorar o de hacer un cambio, o simplemente su firma o nombre como señal de participación y compromiso.



Eje 1

Acompañando el plan de vida de nuestros adolescentes: el rol de las madres y de los padres.



Competencia: Reconoce la importancia de su participación e influencia y responsabilidad en el proyecto de vida de su hijo adolescente.

CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN
Favorece, en sus hijos, la toma de decisiones responsable.	▪ Toma de decisiones. ▪ Técnicas para la toma de decisiones. ▪ Proyecto de vida.	**1** **Madres, padres y cuidadores aliados en la construcción del plan de vida**
Reconocer la importancia de su rol en el proyecto de vida de su hijo adolescente	▪ Metas realistas y objetivos alcanzables. ▪ Importancia de la responsabilidad y la motivación en el logro del proyecto de vida.	

Sesión 1

Madres y padres aliados en la construcción del plan de vida



I. LO QUE DEBO SABER PARA DESARROLLAR LA SESIÓN

1.1. TOMA DE DECISIONES

A. Toma de decisiones en la adolescencia[5]



La **toma de decisiones** es la capacidad de elegir de manera autónoma y responsable entre distintas opciones, buscando el bienestar propio y colectivo. Esta habilidad es clave para actuar con conciencia, ética y responsabilidad en la vida diaria.

En la **adolescencia,** fortalecer esta capacidad es fundamental, ya que los jóvenes enfrentan decisiones importantes en lo personal, académico y social, en una etapa marcada por la búsqueda de autonomía y la construcción de su identidad.

Es también un periodo de **vulnerabilidad frente a influencias externas** y presión de pares, lo que puede llevar a conductas de riesgo. Esto ocurre porque el cerebro adolescente aún está en desarrollo, Telzer (2017), especialmente las áreas relacionadas con el control de impulsos y la planificación. Sin embargo, esta etapa también ofrece un gran potencial para aprender a decidir con empatía, responsabilidad y visión de futuro.

Fomentar la toma de decisiones fortalece el **sentido de autonomía y confianza personal**. Cuando los adolescentes creen en su capacidad para influir positivamente en su vida, se sienten más motivados a fijarse metas, esforzarse por alcanzarlas y construir relaciones sanas.

Para apoyar el proceso de toma de decisiones, Keelin, Schoemaker y Spetzler (2009) desarrollaron un modelo para la toma de decisiones que consta de seis elementos, este modelo proporciona una guía estructurada para analizar y tomar decisiones responsables, considerando tanto los aspectos racionales como los emocionales. Estos elementos son:

a. **Delimitar la situación:** Definir claramente qué hay que decidir y qué se quiere lograr.
b. **Prioridades y valores:** Ordenar lo que es más importante (seguridad, metas, ética, etc).
c. **Explorar alternativas:** Buscar y listar distintas opciones, aunque parezcan pequeñas.
d. **Buscar información relevante:** Consultar fuentes confiables y recordar experiencias pasadas.
e. **Pensamiento claro y socioemocional:** Analizar la situación desde distintos puntos de vista, reconocer emociones y usar la autorregulación para elegir con criterio.

5 Adaptado de UNICEF México (2024) Manual de toma de decisiones.

f. **Seguimiento:** Después de decidir, es clave comprometerse a cumplir la decisión tomada, planificando el esfuerzo, tiempo y recursos necesarios. Esto ayuda a mantener claridad y fortalecer el compromiso con la decisión tomada.

Para un adolescente, pedir apoyo a una persona de confianza o a un profesional es una forma de tomar decisiones más seguras y conscientes.

B. Técnicas para analizar y tomar decisiones

Algunas técnicas sencillas que los padres, madres y cuidadores pueden implementar con sus adolescentes se presentan a continuación:

a) Árbol de decisiones

- Favorece el análisis crítico y la visualización de riesgos/beneficios.
- Se plantea un dilema (ej.: "tener relaciones coitales", "¿Usar o no preservativo?").
- Se dibuja un árbol y en cada rama del árbol se anota las posibles decisiones y sus consecuencias a corto y largo plazo.

b) Cómic o storyboard de decisiones

- Estimula la creatividad y el pensamiento crítico.
- Se pide crear una historieta corta donde un personaje debe decidir sobre un tema (ej. consentimiento sexual).
- Plantea las alternativas que el personaje podría tomar y sus consecuencias.

c) Simulación con lentes de futuro

- Ayuda a reflexionar en la dimensión a largo plazo de la toma de decisiones.
- Plantea una situación: "tener relaciones sexuales". Imaginar "qué pasaría en mi vida dentro de 1 mes, 1 año o 5 años" según la decisión tomada.

1.2. PLAN DE VIDA:



El plan de vida es un proceso paralelo al desarrollo de la identidad, ambos se nutren mutuamente. El plan de vida responde a la pregunta "¿Hacia dónde voy?" e implica planificar metas a corto, mediano y largo plazo, considerando recursos, oportunidades y desafíos. Este proceso ayuda a los adolescentes a definir su identidad, fortalecer su motivación y proyectar su papel en la sociedad.

Su desarrollo depende del contexto familiar, educativo y social. Se fortalece cuando hay confianza, apoyo y respeto, y cuando madres y padres acompañan las metas de sus hijos sin imponer, reconociendo sus capacidades y deseos (UNICEF). También se potencia con educación integral en sexualidad, servicios de salud amigables y espacios de participación (UNFPA).

Definir un plan de vida debe basarse en los intereses y sueños personales, no en los roles de género. Tanto hombres como mujeres adolescentes tienen derecho a elegir libremente su futuro.

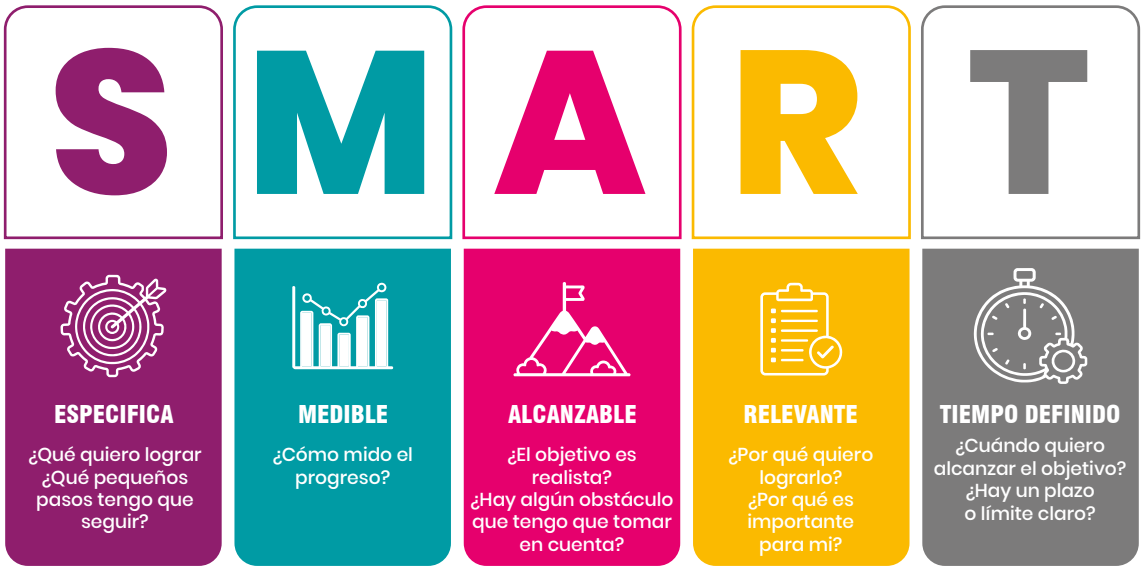
Es importante destacar que, en varias regiones del país, las adolescentes continúan enfrentando limitaciones en su derecho a desarrollarse plenamente. Muchas veces cuentan con menor confianza en sus capacidades y se ven condicionadas por expectativas reducidas, centradas únicamente en la unión temprana y la maternidad. Estas situaciones disminuyen su autonomía y restringen la construcción de un proyecto de vida propio.

Un plan de vida integral considera las áreas personal, escolar, familiar, laboral y afectiva, promoviendo la toma de decisiones responsables, el autocuidado y la prevención de riesgos.

A. Metas realistas y objetivos alcanzables en el proyecto de vida de hijos adolescentes

Un aspecto central del proyecto de vida es saber formular metas y objetivos claros, en ese sentido la formula SMART resulta útil. La técnica SMART significa

- **S (Specific/ Específica):** La meta debe estar claramente definida.
- **M (Measurable/Medible):** Debe tener un indicador para verificar el avance o cumplimiento.
- **A (Achievable/Alcanzable):** Debe ser posible según recursos y capacidades.
- **R (Relevant /Relevante):** Debe ser significativa para el proyecto de vida y coherente con sus valores.
- **T (Time-bound / Tiempo):** Debe tener un plazo definido para lograrse.



Ejemplo de Meta SMART aplicado al Plan de Vida de un adolescente en el área de las relaciones afectivas y sexual sería: "Tener mi primer hijo a los 27 años, cuidando desde ahora mi salud sexual y reproductiva, comprometiéndome a buscar información sobre métodos anticonceptivos y visitando los EESS para recibir consejería, las veces que lo necesite"

B. La importancia de la responsabilidad y motivación en el Plan de vida

Para que un plan de vida resulte exitoso, este debe sustentarse en los resultados del autoconocimiento; proceso que permite identificar fortalezas (en qué y para qué soy bueno) así como en el compromiso y motivación sostenida al logro de metas a lo largo del tiempo.

En este tema del plan de vida resulta clave citar a la psiquiatra Maryan Rojas Estapé y su propuesta de la "Fórmula del Éxito". Para Rojas Estapé, el éxito no se mide únicamente en logros materiales, dinero o prestigio social, sino en lograr un equilibrio interno que permita vivir con sentido, paz y bienestar emocional.

El éxito, aplicado al plan de vida, no sería fruto del azar, sino de una combinación de factores que se pueden trabajar y entrenar:

a) **Aprendizaje continuo:** El conocimiento es básico, y estar abierto a mejorar, a aprender y adaptarse a los cambios.

b) **Actitud positiva:** Se refiere a cómo interpretamos la realidad y enfrentamos los retos.

c) **Autoconfianza y motivación:** Creer en uno mismo y mantener la energía en el proceso.

d) **Compromiso, hábitos y disciplina:** Constancia en las acciones diarias, dedicarle tiempo y enfocarse en lo realmente importante.

e) **Relaciones y comunicación:** Generar sinergias positivas con los demás.

f) **Claridad de objetivos:** Definir qué se quiere lograr y trazar un plan con metas concretas.

La fórmula del éxito es:



Video recomendado para el personal de salud:

https://www.youtube.com/watch?v=S_0l-EqwknU

C. Rol de padres y madres y cuidadores

La responsabilidad de madres, padres y cuidadores no consiste en decidir por sus hijos, sino en **acompañarlos en el descubrimiento de quiénes son y hacia dónde quieren ir**. Ofrecer dentro del hogar espacios de comunicación, apoyo, participación familiar y oportunidades de desarrollo, favorece que los adolescentes construyan proyectos de vida libres, responsables y coherentes con sus aspiraciones y derechos.

Algunas responsabilidades concretas de los padres y madres y cuidadores con relación al plan de vida de su hijo serían:

- **Escuchar y dialogar sin juzgar:** Crear momentos para que su hijo comparta sueños, dudas y preocupaciones.
- **Brindar información confiable:** Orientar sobre estudios, trabajo, salud y oportunidades reales en su comunidad.
- **Apoyar nuevas experiencias:** Facilitar talleres, prácticas o actividades que ayuden a descubrir intereses y habilidades.
- **Fomentar la autonomía:** Esta debe ser una autonomía progresiva, delegando decisiones acordes a la edad y acompañar sin invadir.
- **Ayudar a definir metas y pasos:** Conversar sobre lo que quiere lograr y cómo avanzar de manera concreta.
- **Mantener expectativas realistas:** Evitar imponer un único camino y ser flexible ante cambios o nuevas metas.
- **Conectar con servicios y apoyos:** Acompañar el acceso a salud, orientación vocacional, apoyo emocional, becas u otros.
- **Ser un modelo positivo:** Mostrar con el propio ejemplo responsabilidad, esfuerzo y buen manejo de las emociones y recursos.



II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



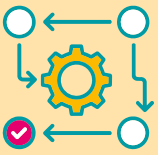
OBJETIVO:
- Favorecer la toma de decisiones responsable en sus hijos adolescentes.
- Reconocer la importancia de su rol en el proyecto de vida de su hijo adolescente.



TIEMPO:
30 minutos.



MATERIALES:
- Plumones
- Recurso N° 1 Imagen de los dos caminos.
- Recurso N° 2 Imagen tronco y el pescador.
- Recurso N° 3 Matriz del tronco y el pescador.
- Recurso N° 4 Modelo de árbol.
- Tarjetas de diferentes colores.
- Tarjetas en forma de hojas.
- "Mural de los compromisos" Elaborado en papelógrafo.



SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el **objetivo y los temas** que abordarán en la sesión, resaltando que las **actividades requieren su participación activa** para enriquecer el diálogo y el aprendizaje.

Actividad 1. "Dos caminos" (15 minutos)

Muestre la imagen de los dos caminos (Recurso Nº1) y pida a los padres y madres y cuidadores que recuerden una decisión importante o difícil de su adolescencia (por ejemplo, decidir sobre estudios o trabajo, decidir con quién estar, decidir formar familia, etc.). Brinde un minuto para este momento.

Solicite que, imaginariamente, coloquen al centro de los dos caminos esa decisión difícil o importante de su adolescencia que han recordado y piensen ¿cuál fue el camino que eligieron?

Luego pregunte:

- *¿Cómo se sintieron en ese momento?*
- *¿Qué emociones surgieron? (inseguridad, miedo, duda, presión).*
- *¿Qué hicieron para tomar la decisión?*
- *¿Quién les apoyó a tomar la decisión?*
- *¿Cuál es el rol de los padres en las decisiones de sus hijos?*

Escuchamos y validamos sus intervenciones. Esté atento a las respuestas diferenciadas de las mujeres y varones.

Explicamos que siempre tomamos decisiones, pero que hay decisiones que son más difíciles que otras y estas pueden afectar toda la vida. Por ejemplo: ¿Tener relaciones coitales? ¿Casarse o unirse con otra persona?

Refuerce que para las mujeres adolescentes las decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva son difíciles. Para las mujeres, tener relaciones sexuales, quedar embarazada, unirse a una pareja, y usar métodos anticonceptivos, no siempre son decisiones personales, pueden ser producto de la presión, el control, el miedo o incluso violencia. Estas situaciones vulneran sus derechos y pueden afectar su vida en el presente y en el futuro.

Refuerce: ante una decisión difícil, debemos enseñar a nuestros hijos a pensar ¿qué hacer? ¿cómo actuar?, buscar orientación o ayuda, para que la decisión que se tome sea una "decisión razonable e informada"

Señale que, en la sesión abordarán la importancia de tomar decisiones, el plan de vida y la importancia de apoyar el proyecto de vida de sus hijos

Para ello, invite a realizar la siguiente actividad.

DESARROLLO:

Actividad 2. "El tronco y el pescador" (20 minutos)

Para ayudar a comprender de manera sencilla la importancia de saber tomar decisiones, usaremos el recurso "El tronco y el pescador"

Muestre la foto del tronco y la foto del pescador en su bote (Recurso 2) y pregunte:

- ¿Qué pasa con el tronco? (Rpta esperada: se lo lleva la corriente)
- ¿Qué pasa con el pescador? (Rpta esperada: tiene control sobre su bote y sabe a dónde quiere llegar)

Comparte:

- El tronco en el río no decide nada, el agua lo lleva para donde quiere, a veces lo empuja fuerte, a veces lo hace chocar contra piedras, a veces se queda atorado. El tronco solo se deja llevar.
- El pescador sí decide, él mira el río, piensa a dónde quiere llegar, elige dónde pararse y dónde lanzar su red. Puede que el agua esté movida, pero él actúa con un propósito.

ADAPTACIÓN

El facilitador lee las situaciones planteadas en la matriz "El tronco y el pescador" y pregunta a los padres y madres, frente a cada situación: ¿Cómo sería actuar cómo tronco y cómo sería actuar como pescador?

Explique que, "en la vida diaria, a veces somos como el tronco, nos dejamos llevar por la corriente. Pero también podemos ser como el pescador, tomamos control en base a nuestros objetivos". *Por ejemplo:*

- *"Nuestro hijo llega tarde, no le decimos nada, porque "así no más es", "los hijos de mis vecinos también llegan tarde". Esto es actuar como tronco.*
- *Nuestro hijo llega tarde, y yo quiero que mi hijo sea responsable, entonces* ***pienso antes de actuar****: en vez de gritar, respiro y le explico la norma; mantengo el horario porque* ***ese es mi objetivo****. Ahí sí* ***tomo el control****, como el pescador que decide dónde pararse y qué hacer.*

Explique que este ejercicio permite identificar dos tipos de conducta relacionadas con la toma de decisiones:

- Seguir la corriente (dejarnos llevar como el tronco, no hacer nada)
- Pausar y decidir a dónde ir (como el pescador de la imagen, que controla su lancha)

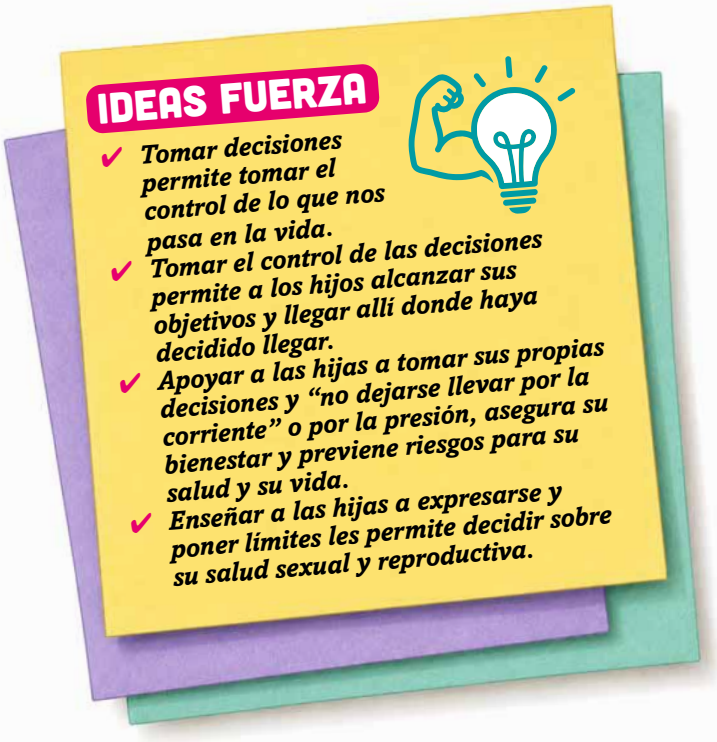
Aclare que seguir la corriente es también tomar una decisión ya que no decidir en aspectos importantes de la vida tiene consecuencias en el bienestar y el futuro.

Agregue que, debido a las costumbres o creencias de cómo deben ser las mujeres y los hombres, muchas adolescentes mujeres terminan "dejándose llevar", como un tronco en el río, porque desde niñas se les enseña a ser sumisas, complacer, quedarse calladas, cuidar y no "quedar mal", y eso hace más difícil que puedan decir "No", poner límites o expresar lo que realmente sienten y necesitan.

A continuación, explique que van a ejercitarse en esta técnica para que la aprendan y puedan enseñarla a sus hijos.

- Muestre la matriz "El tronco y el pescador" (Recurso 3) que contiene diversas situaciones frente a las cuales se puede actuar cómo tronco o como pescador.
- Luego, forme 3 grupos y entregue copia de la matriz a cada grupo.
- En grupos analizan y desarrollan las situaciones planteadas en la matriz del tronco y el pescador.
- En plenaria comparten sus trabajos.

Felicite y agradezca y complemente con las ideas fuerza.



Explique que otro tema importante a conversar es sobre apoyar los sueños o las metas de los hijos, es decir su plan de vida.

Para dialogar sobre este tema lo harán mediante un ejercicio.

Actividad 3. "Acompañar los sueños" (25 minutos)

Solicite que se sienten en círculo, y entregue a cada participante o muestre el listado de preguntas siguiente:

Preguntas de reflexión

- ¿Recuerdas cuál era tu mayor sueño cuando eras adolescentes?
- ¿Qué querías llegar a ser? ¿lo lograste? ¿por qué no?
- ¿Sabes qué quiere ser tu hijo adolescente? ¿a qué se va a dedicar?
- ¿Cuáles son las cualidades de tu hijo(a)? ¿para qué es bueno? Escribe o menciona en 5 cualidades, atributos o características.
- ¿Qué podría impedir que tu hijo(a) alcance su sueño?
- ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo(a) a alcanzar sus sueños?

Explique que deben leer y responder a cada pregunta. No es necesario que escriban sus respuestas, solo que piensen en silencio sus respuestas.

Luego del tiempo prudencial dirija una reflexión grupal, leyendo en voz alta las preguntas, una a una.

Facilite para que dos o tres participantes de manera voluntaria compartan sus respuestas a una de las preguntas, otros dos o tres participantes compartan sus respuestas a la segunda pregunta y así de manera sucesiva.

Felicite y agradezca la participación.

Sea empático y brinde contención si los participantes narran historias en sentido distinto al que deseamos (por ejemplo: no haber recibido apoyo de sus padres, sueños truncos, etc.)

Realice una última reflexión general preguntando:

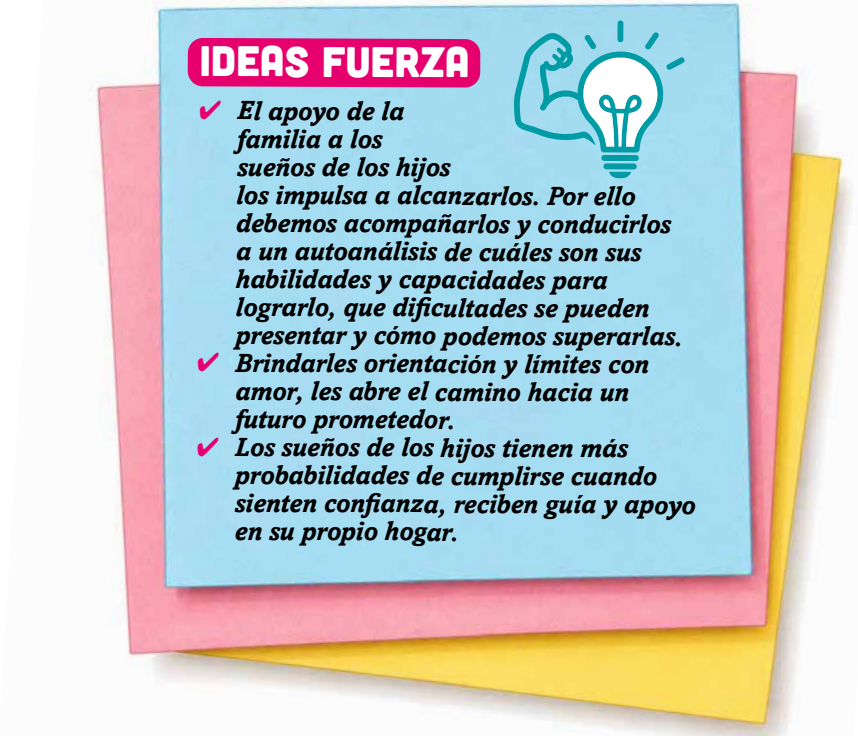
- *A partir de esta reflexión sobre sus sueños y los sueños de sus hijos ¿Por qué es importante que los padres y madres apoyemos el plan de vida de los hijos?*

Escuche sus respuestas, valide, agradezca y llegue a conclusiones con la participación de los padres y madres.

ADAPTACIÓN

Narrar la historia de realización personal de un notable de su comunidad. Analizando los factores personales y del entorno que le ayudaron a cumplir con sus sueños.

Complemente con lo siguiente:



Para finalizar invite a realizar una última actividad para que los padres puedan apoyar los sueños de los hijos y que estos se cumplan.

Actividad 4. "El árbol de los sueños" (20 minutos)

Reparta a cada padre o madre un papelógrafo y solicite que dibujen un árbol, muestre como ejemplo el recurso Nº 4).

Solicite que en la copa del árbol escriban una meta o un sueño que tiene su hijo (por ejemplo: quiere ser ingeniero, ser un deportista, tener su propio negocio, etc.).

Si el padre o madre dice que "no sabe qué quiere ser su hijo", pregunte qué le gustaría que fuera el sueño o meta para su hijo.

Indique que en el tronco coloquen las habilidades personales o fortalezas de sus hijos (cosas que su hijo hace bien) que son importantes para alcanzar esas metas o sueños. Por ejemplo: es responsable, tiene paciencia, es curioso, creativo, habla muy bien, es bueno jugando fútbol, aprende rápido, se esfuerza, etc.

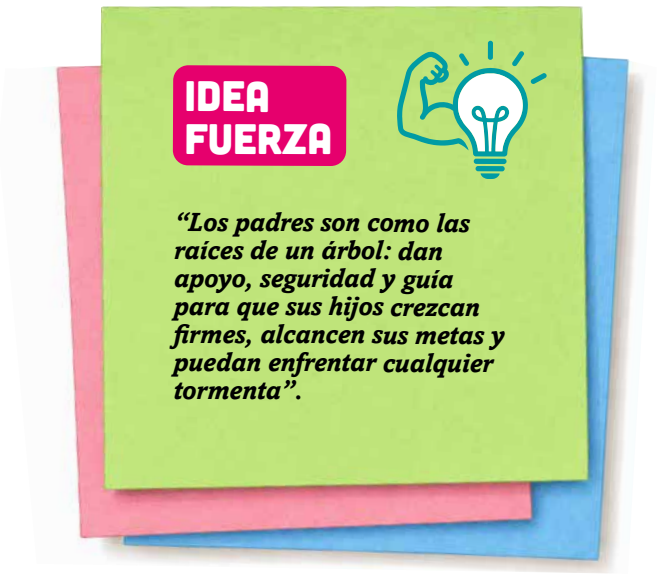
Indique que en las raíces escriban lo qué necesita su hijo por parte de su familia para seguir manteniendo sus cualidades y fortalezas para alcanzar su sueño. Por ejemplo: el apoyo de sus padres y personas de confianza, amor, comprensión, enseñarle valores como responsabilidad, perseverancia, etc.

Luego, solicite que coloquen sus dibujos en la pared.

ADAPTACIÓN

Con la ayuda del co-facilitador, preste ayuda a los padres, madres y cuidadores no letrados, para escribir en el árbol los sueños, en el tronco las cualidades y en las raíces los aportes de la familia para que cumpla su sueño

Agradezca y felicite el trabajo de los padres y madres y cierre la actividad con la siguiente idea:



CIERRE:

Actividad 5. ¡Eureka! (10 minutos)

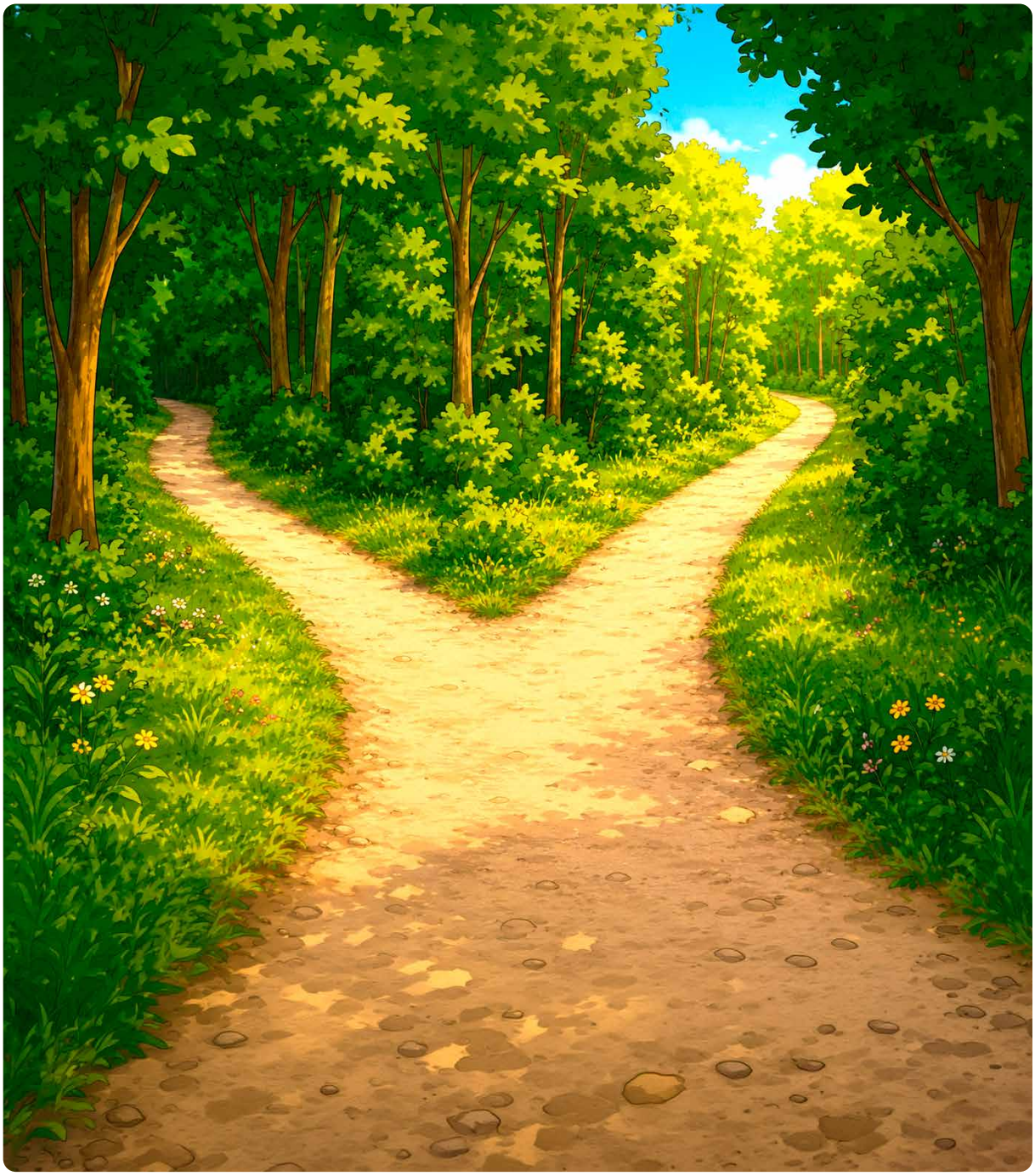
Compromiso personal: Cada participante escribe un compromiso personal para apoyar a sus hijos en la construcción de su proyecto de vida.

Apoyar los sueños de los hijos, ayudándoles a plantearse metas realistas fortalece la confianza, la comunicación y el vínculo familiar.

Recursos

Recurso 1

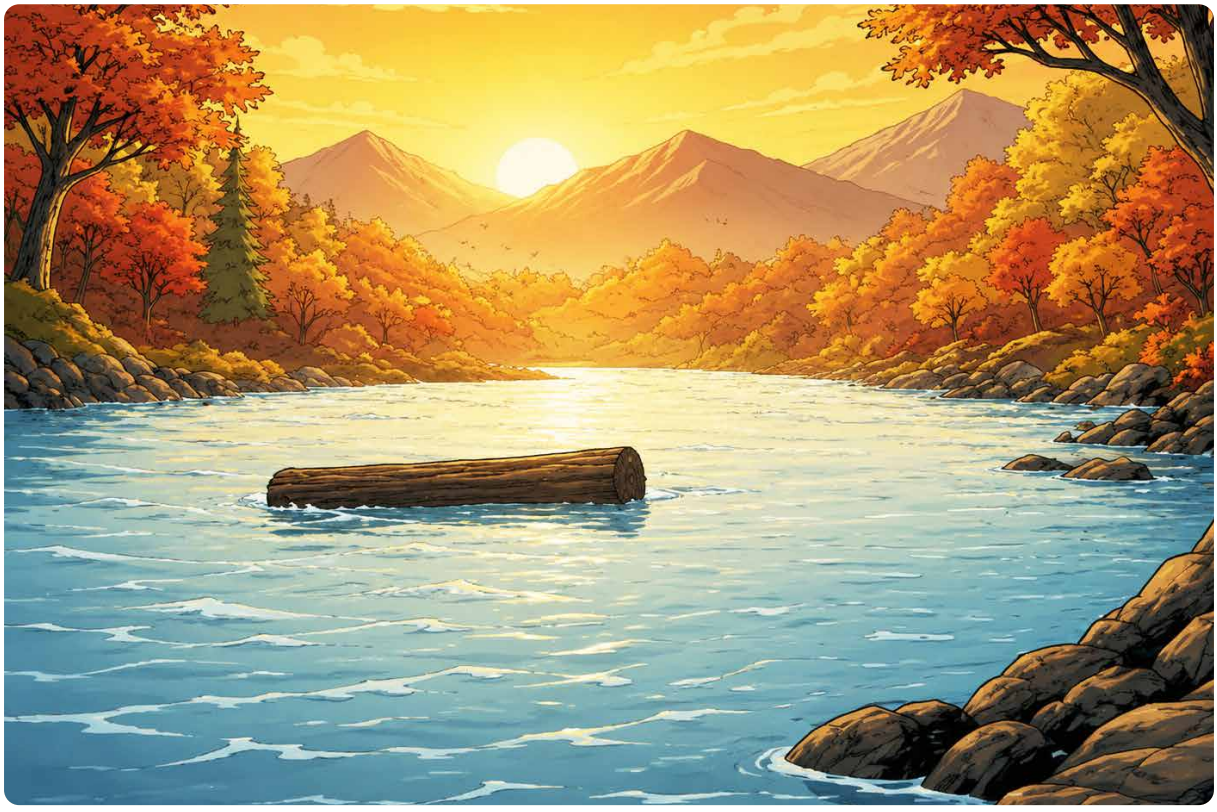
IMAGEN DE DOS CAMINOS



Recurso 2

IMAGEN DEL TRONCO Y EL PESCADOR





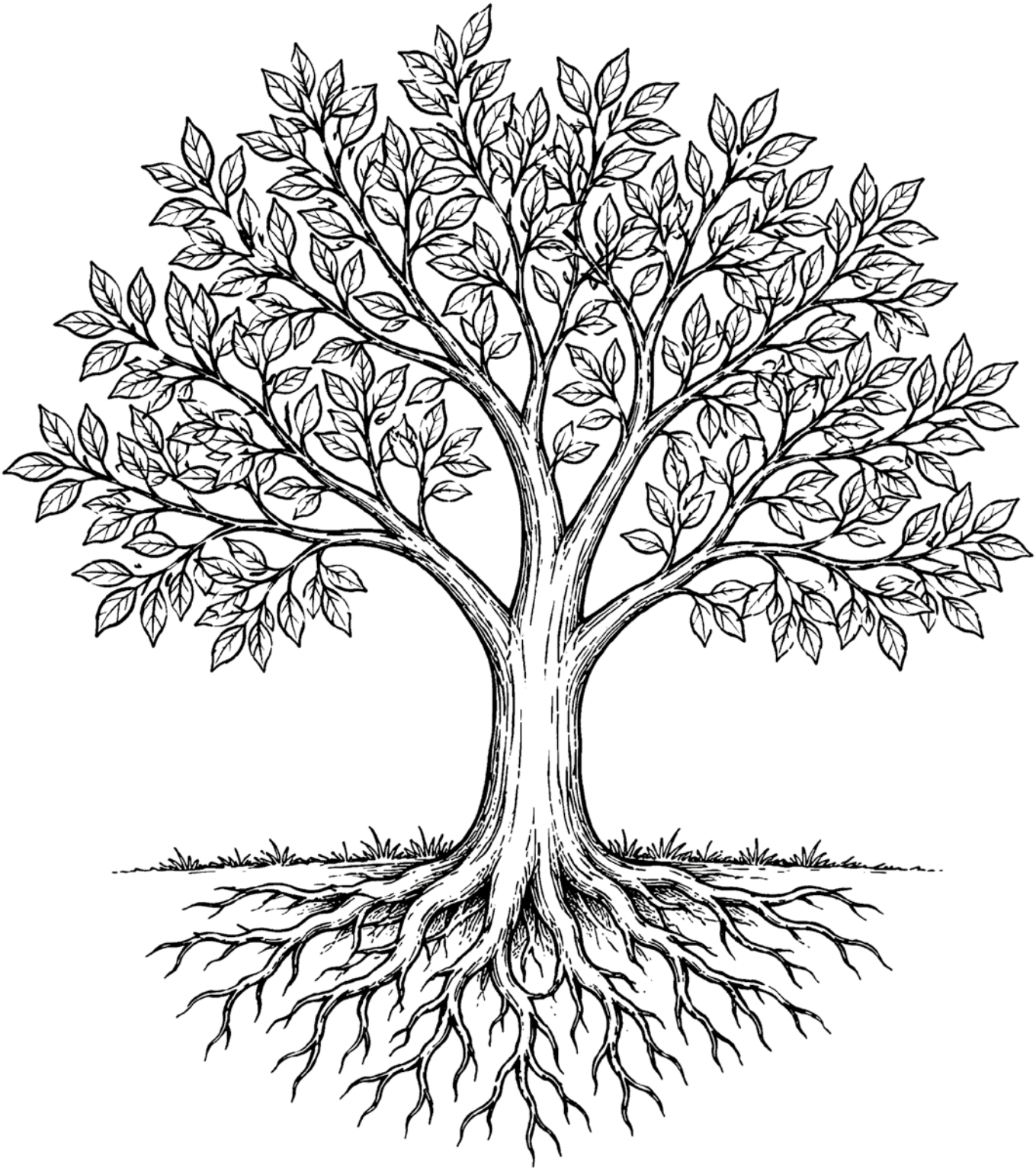
Recurso 3

MATRIZ DEL TRONCO Y EL PESCADOR

Situación	¿Qué haría tu hijo si actuara como tronco?	¿Qué haría tu hijo si actuara como pescador?	¿Cuál le conviene? ¿por qué?
Un grupo de compañeros de tu hijo se pone de acuerdo para no ingresar al colegio	*Hacerles caso y no entrar al colegio*	*Decirles que el sí entrará al colegio*	
El grupo de amigos de tu hijo se pone de acuerdo para comprar licor			
Los compañeros se burlan e insultan a la chica nueva de la clase			
El enamorado(a) insiste a tu hija(o) que deben tener relaciones sexuales			
Un hombre mayor le pide a tu hija casarse, formar una familia			
Alguien que conoció en internet le pide a tu hija que le envíe fotos íntimas			

Recurso 4

MODELO DE ÁRBOL



Eje 2

Comprendiendo los cambios de la adolescencia y el rol de la familia en la construcción de la identidad



Competencia: Comprende y reconoce cómo se construye la identidad y los cambios físicos, emocionales y sociales que viven sus hijos adolescentes, valorando la formación positiva, la educación en salud y el acompañamiento familiar durante el desarrollo adolescente basado en el respeto y la comunicación.

CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN
Comprende cómo se construye la identidad y su relación con la autoestima	▪ La construcción de la identidad en la adolescencia (Relaciones sociales, la retroalimentación de los demás, la cultura, y la autoimagen, la aceptación del propio cuerpo) ▪ La autoestima: pilares y componentes y cómo impactan en la identidad en la adolescencia.	**2** Construcción positiva de la identidad y de la autoestima
Comprende la importancia de la formación positiva de la identidad en la adolescencia y valora su rol como padres y madres	▪ La formación positiva de la identidad. ▪ Rol de los padres, madres y/o cuidadores	
Reconoce los cambios físicos, emocionales y sociales de la adolescencia y las expresiones de la sexualidad en esta etapa, en el contexto social y cultural actual.	▪ Los cambios físicos, emocionales y sociales durante la adolescencia en el contexto social actual y en la diversidad cultural. ▪ Las expresiones de la sexualidad adolescente: La primera menstruación, la polución nocturna, la masturbación, el enamoramiento, el inicio sexual consentido, la abstinencia.	**3** Adolescencia: comprendiendo los cambios y manifestaciones de la sexualidad en esta etapa de la vida.
Comprende la importancia de la educación en salud e higiene menstrual.	▪ Bienestar físico, mental y social durante el ciclo menstrual, acceso a productos de higiene, privacidad, estigma y discriminación asociados a la menstruación.	
Reconoce la importancia de acompañar el desarrollo de sus hijos adolescentes.	▪ Rol de la familia en el desarrollo sexual de sus hijos adolescentes.	

Sesión 2

Construcción positiva de la identidad y la autoestima.



I. LO QUE DEBO SABER PARA DESARROLLAR LA SESIÓN

1.1. IDENTIDAD

Cuando los hijos entran en la adolescencia, toma especial relevancia la participación de los padres en la formación de su identidad. Este proceso no ocurre de un día para otro; se va construyendo poco a poco, integrando los cambios que viven en el cuerpo, en la mente y en sus relaciones sociales.

Erikson (1968) define la **identidad** como *"la percepción interna de continuidad y coherencia en el tiempo y en diferentes situaciones; es el sentido de quién soy y hacia dónde voy"*.

La identidad es el conjunto de características, valores y experiencias que definen a una persona, creando un sentido de sí misma coherente y continuo en el tiempo. Es un proceso dinámico de autoconcepto, que incluye la comprensión de quiénes somos, nuestras metas y cómo nos relacionamos con el mundo. La identidad se construye a través de la interacción de factores personales y sociales.

Son cuatro los procesos que confluyen para el desarrollo de la identidad en la adolescencia, estos son:

a) **La integración y aceptación de su imagen**: Los cambios físicos de la pubertad no solo transforman el cuerpo del adolescente, también influyen en cómo se sienten y en la imagen que tienen de sí mismos, es decir de su autovaloración y autoestima. La integración y aceptación de su imagen y sus nuevas características es relevante para el logro de su identidad personal.

b) **La consolidación de su identidad de género y su orientación afectiva:** Preguntarse quiénes son, cómo quieren mostrarse ante la sociedad y por quién se sienten atraídos afectivamente forma parte natural del autodescubrimiento en esta etapa. No es motivo de alarma, sino un proceso sano que requiere respeto y apertura **para que se sientan seguros de ser quienes son.**

c) **La exploración de sus intereses y aspiraciones vocacionales:** Estos pueden cambiar con frecuencia producto de la exploración que les corresponde experimentar con diversas opciones, y es normal que se produzcan estas fluctuaciones de intereses. Lo importante es animarlos a experimentar, probar cosas nuevas siempre que no implique riesgos para el adolescente y reforzar su confianza para tomar decisiones en el futuro.

d) **Lograr autonomía:** Es una parte esencial del logro de la identidad en la adolescencia**,** implica que el adolescente aprende a tomar decisiones propias**,** basadas en sus valores, intereses y metas, y no en lo que dicen otras personas del grupo social al que pertenece. La autonomía busca independizar su pensamiento y conducta**,** desarrolla criterio propio y asume responsabilidades**.** Esta capacidad de decidir por sí mismo fortalece su **autoestima**, le permite **definir quién es** y **qué quiere ser**, consolidando así su identidad personal.

Es necesario recordar a los padres y madres y cuidadores que el logro de la autonomía es progresivo, que implica que los hijos, conforme van creciendo, van aprendiendo poco a poco a tomar sus propias decisiones y a cuidar de sí mismos. Sin embargo, los padres, madres y cuidadores deben acompañar este proceso poniendo límites, adaptando a la edad y madurez del adolescente.

1.2. FACTORES AMBIENTALES Y CONTEXTUALES (EXTRÍNSECOS) QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD[6]

a) Familia

- La familia debe ser el primer espacio seguro de socialización y un referente fundamental para la construcción de valores, creencias y expectativas.
- Las prácticas de crianza democrática, el apoyo emocional y la comunicación abierta favorecen una identidad positiva, mientras que la sobreprotección, el control rígido o la violencia interfieren en este proceso.
- En el contexto peruano, las relaciones familiares suelen estar marcadas por estructuras jerárquicas y patrones tradicionales de género, que pueden influir en las opciones personales y vocacionales de los adolescentes.

b) Grupo de pares

- En la adolescencia, el grupo de amigos se convierte en un espacio clave para la exploración de roles, la validación social y la construcción de autonomía.
- Las relaciones de pares ofrecen oportunidades de pertenencia, experimentación y desarrollo de habilidades sociales.

c) Escuela

- El entorno educativo proporciona experiencias de aprendizaje y reconocimiento que fortalecen la autoestima y la autoeficacia.
- Las escuelas que promueven la participación estudiantil, la inclusión y la educación socioemocional contribuyen positivamente al desarrollo identitario.

d) Contexto sociocultural y comunitario

- Las normas sociales, los valores culturales, los roles de género y las oportunidades económicas del entorno influyen en cómo los adolescentes se perciben y proyectan hacia el futuro.
- En contextos latinoamericanos y peruanos, las desigualdades de género, la pobreza y la discriminación étnico-cultural pueden limitar el ejercicio de la autonomía y el desarrollo pleno de la identidad.

e) Medios de comunicación y redes sociales

- Las redes sociales inciden en la construcción de la autoimagen y en la comparación social.
- Si bien pueden favorecer la expresión y la pertenencia a comunidades diversas, también pueden generar presiones por cumplir con estándares idealizados.

6 Berzonsky, M. D., & Cieciuch, J. (2023). *Identity development in cultural context. Journal of Adolescence, 95*, 101–115. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2022.12.006

f) Contexto socioeconómico

- Las condiciones materiales, el acceso a educación, salud y espacios recreativos son determinantes.
- La inseguridad económica puede restringir las posibilidades de exploración vocacional y de logro de metas personales.

1.3. IDENTIDAD EN LA ERA DIGITAL

En las redes sociales, los adolescentes experimentan con su imagen, ensayan roles, se comparan, y van desarrollando una identidad, a través de la retroalimentación de sus pares y de otras personas, lo cual impacta en la formación de su identidad y **en su autoestima**.

En la siguiente tabla se presentan aspectos clave del uso de la tecnología en el desarrollo de la identidad.

Aspectos claves	Influencia en la identidad adolescente
Exploración y expresión de la identidad	Las redes sociales facilitan la exploración de roles, intereses y valores personales, pero también pueden generar presión por validación externa[7].
Comparación social y autoimagen	La exposición a imágenes idealizadas y estilos de vida en redes sociales influye en la autoestima, el autoconcepto y la satisfacción corporal[8].
Identidad digital y reputación online	La construcción del "yo digital" implica gestionar la imagen pública y las interacciones virtuales; experiencias negativas (como el ciberacoso) afectan la autoconfianza[9].
Pertenencia y comunidades virtuales	Las plataformas digitales permiten el sentido de pertenencia a comunidades diversas, fortaleciendo la identidad, especialmente en grupos minoritarios[10].
Autonomía y toma de decisiones	El acceso a información amplía la autonomía, pero también exige pensamiento crítico y habilidades[11] digitales para evitar desinformación y riesgos.
Equidad digital y contexto socioeconómico	Las brechas en el acceso y conectividad limitan la participación digital.

Enseñarles a reflexionar sobre lo que encuentran en las redes sociales o sobre lo que publican es una estrategia muy valiosa. Poner límites claros respecto al tiempo de conexión y fomentar actividades fuera de la pantalla ayuda a equilibrar su vida digital con experiencias reales. No se recomienda las redes sociales a menores de 14 años.

7 Valkenburg, P. M., & Piotrowski, J. T. (2022). Plugged In: How Media Attract and Affect Youth. Yale University Press.
8 Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2021). Social media and body image concerns: Current research and future directions. Current Opinion in Psychology, 45, 101293
9 Livingstone, S., & Third, A. (2023). Children and Young People's Rights in the Digital Age. Routledge.
10 Van Eldik, A., Kneer, J., & Jansz, J. (2019). Urban & Online: Social Media Use among Adolescents and Sense of Belonging to a Super-Diverse City.
11 Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2022). Digital by Default: Children's Rights and Digital Technologies. UNICEF Innocenti.

1.4. IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL

a) **Identidad de género:** La identidad de género es la conciencia interna que cada persona tiene de sí, de quién es. Incluye las creencias que se aprenden, los valores atribuidos a cada género y la valoración que cada persona hace hacia su propio género. Hace referencia a los valores, comportamientos y cualidades que una cultura asocia o considera apropiados para hombres y mujeres[12] .

b) **Orientación sexual[13]:** La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva, erótica o emocional hacia otras personas, y esta puede ser:

- **Heterosexual:** atracción hacia personas del sexo opuesto.
- **Homosexual:** atracción hacia personas del mismo sexo.
- **Bisexual:** atracción hacia ambos sexos.

Desde el punto de vista psicológico, el desarrollo de la identidad de género empieza en los primeros años de vida, cuando las niñas y los niños comienzan a reconocerse como tales, se refuerza alrededor de los 6 o 7 años y se consolida en la adolescencia, aunque podría incluso transformarse con el tiempo.

Es común que los adolescentes exploren y se hagan preguntas sobre su identidad sexual y descubran su orientación sexual.

Cualquiera que esta sea, lo más importante es que el adolescente se sienta aceptado y acompañado. Escucharlo sin juzgar, mantener el diálogo abierto y demostrarle cariño ayudará a fortalecer su autoestima y su confianza.

Es muy relevante saber que tener una identidad de género distinta al sexo asignado al nacer, o sentir atracción por alguien del propio sexo, forma parte de la diversidad humana y no representa una enfermedad.

Asimismo, debemos remarcar que todas las personas independientemente de la identidad u orientación sexual merecen respeto, y es responsabilidad como adultos prevenir la discriminación y la violencia.

Si en algún momento el adolescente o su padre o madre se sintiera inseguro o confundido, es recomendable que reciba una orientación especializada.

1.5. FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD FORTALECIDA[14]

En la búsqueda de su identidad, el adolescente va a explorar diversas opciones de amistades, de pasatiempos, y cambiarán rápido de opinión; esto no significa que estén confundidos, sino que están probando para descubrir lo que realmente encaja con ellos o les gusta. Posteriormente, llegará el "compromiso" al elegir entre las opciones y hacer que esta elección sea más estable.

Ambos pasos son necesarios. Si los adolescentes son presionados demasiado pronto, a elegir, por ejemplo, una carrera, o dedicarse a un determinado deporte, o son obligados a hacer alguna actividad con la que siente que no encaja, los estaremos llevando a desarrollar "identidades prestadas"; y vendrá luego la insatisfacción, el arrepentimiento y el tiempo perdido.

12 MIDIS 2018 Conceptos Fundamentales Sobre El Enfoque De Género Para Abordar Políticas Públicas
13 RDE N°133-2022 MIMP-AURORA-DE.
14 Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), Handbook of Adolescent Psychology (pp. 159–187). New York: Wiley.

La identidad fortalecida surgirá cuando el adolescente se sienta reconocido, valorado, sienta que tiene propósito y se sienta unido a su familia y comunidad. Y esto se logra cuando padres y madres:

- Alimentan la autoestima, brindándoles reconocimiento desde la infancia
- Brindan afecto, escucha y orientación.
- Brindan oportunidades para aprender a desarrollar nuevas habilidades y aptitudes.
- Respetan sus opiniones, gustos y preferencias, considerando que estos no impliquen riesgos en su integridad física y/o mental
- Brindan espacios seguros para que se **expresen sin miedo a la crítica o al juicio.**
- Apoyan para que desarrollen un sentido de **propósito y plan de vida**, vinculado con valores personales y sociales.
- Las investigaciones señalan que los adolescentes que crecen en hogares con aceptación, calidez y comunicación abierta desarrollan una identidad más sólida**,** mayor autoestima y mejor capacidad para tomar decisiones saludables. (Meeus, 2011; Schwartz et al., 2013). (Kroger, 2015; Luyckx et al., 2013).

Acompañar con paciencia y empatía, validar sus emociones e intereses, y ofrecer orientación sin imponer, les permite sentirse comprendidos y valorados. Cuando madres y padres reconocen sus logros y los apoyan en sus dudas, fortalecen su confianza y resiliencia. Así, la familia se convierte en un espacio seguro, desde donde los adolescentes pueden crecer con autenticidad y proyectarse al mundo con seguridad.

1.6. AUTOESTIMA E IDENTIDAD[15]

La **autoestima** es el valor que cada persona le da a su ser en su totalidad: integrando lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. En otras palabras, responde a la pregunta: *¿me siento a gusto conmigo mismo? o ¿me cuesta aceptarme tal como soy?*

La autoestima es el resultado final del autoconcepto y la autoaceptación, se construye y se refuerza a lo largo de la vida, sobre la base de tres sólidos cimientos, como son:

- **La familia**, donde se aprende valores, normas y formas de relacionarse.
- **El amor y la aprobación** de las personas significativas del entorno, como padres, madres, docentes o cuidadores que van reflejando como son los hijos.
- **El logro de metas y objetivos**, que alimenta el bienestar y proyecta hacia el éxito.

El **autoconcepto** es la forma en que una persona se percibe y valora a sí misma: sus cualidades, habilidades, intereses y manera de relacionarse. Durante la **adolescencia**, este concepto se transforma, ya que los cambios físicos y emocionales llevan a explorar quiénes son, qué quieren y cuáles son sus valores, aspectos esenciales en la **construcción de la identidad**.

15 Adaptado de DPROM (2022) Módulo educativo "Desarrollando capacidades para la promoción de una salud sexual".

La **autoaceptación** implica reconocerse con fortalezas y limitaciones, es clave para que los adolescentes se sientan amados, valorados y capaces. Contar con apoyo y aceptación de su entorno fortalece su autoestima y los ayuda a enfrentar con seguridad los retos de esta etapa.

Asimismo, **reconocer los logros personales** y recibir retroalimentación positiva fortalece la confianza, mientras que la falta de apoyo o las experiencias repetidas de fracaso pueden afectar su autoestima y generar inseguridad.

1.7. ESTRATEGIAS DE APOYO DESDE LA FAMILIA

- **Resaltar lo valioso en cada adolescente.** Ayudarles a reconocer sus fortalezas, incluso aquellas que ellos mismos no perciben.
- **Brindar afecto y calidez.** Sentirse querido, respetado y valorado impacta directamente en la construcción de una identidad positiva.
- **Brindarles oportunidad para desarrollar otras capacidades** y su yo potencial.
- **Evitar comparaciones.** Reforzar que cada adolescente es único, con un valor propio, más allá de los modelos que ofrecen la sociedad, el entorno y los medios.
- **Escuchar activamente y validar sus emociones.** Mostrarles que lo que sienten es importante y que cuentan con un espacio seguro para expresarse.
- **Promover relaciones positivas.** El diálogo, el respeto, la negociación y el compromiso con adultos significativos son claves para un buen desarrollo socioemocional.
- **Fomentar el logro de metas alcanzables.** Reconocer verbalmente los esfuerzos y éxitos refuerza su sentido de capacidad y les motiva a seguir avanzando.



II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



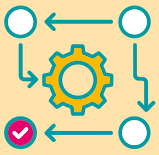
OBJETIVOS:
- Comprender cómo se forma la identidad personal y su relación con la autoestima.
- Reflexionar sobre la importancia de la formación positiva de la identidad y valorar su rol como padre o madre.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Papelógrafo
- Plumones
- Hojas en blanco / hojas con silueta de persona
- Tarjetas en forma de hojas
- Recurso N° 1: formato "La persona más importante para mí"
- Recurso N° 2: Casos
- "Mural de los compromisos" Elaborado en papelógrafo



SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el objetivo y los temas que abordarán en la sesión, resaltando que las actividades requieren su participación activa para enriquecer el diálogo y el aprendizaje.

Invíteles a participar en la siguiente actividad.

Actividad 1. "La persona más importante para mí" (5 minutos)

Primera parte:

Inicie la actividad preguntando de manera cálida

- *¿Quién fue la persona más importante para Usted o su persona favorita en la adolescencia?*

  Explique que puede ser alguien de la vida real o algún personaje que admira.

  Vuelva a repetir o parafrasear la pregunta.

  Deles un tiempo para pensar.

  Solicite voluntarios que quieran compartir su respuesta a la pregunta ¿Quién fue la persona más importante en la adolescencia? y repregunte ¿Por qué fue su persona más importante?

  Después de escucharlos, diga: "La mayoría de personas tenemos alguien que fue importante para nosotros, por su forma de ser, por su comportamiento, por sus valores, y eso es muy bueno".

  En esta actividad nos daremos cuenta sobre cómo estas personas importantes influyen en la formación de nuestro carácter, nuestra forma de ser y comportarnos.

  Para ello, invite a continuar con la siguiente actividad.

Segunda parte:

Reparta hojas con el formato mostrado en el Recurso Nº 1 y lapiceros

Solicite que escriban el nombre de la persona más importante en el lado izquierdo de la hoja y su propio nombre en el lado derecho.

Indique que, debajo del nombre de la persona más importante, describan cómo es o era esa persona (características, cualidades, habilidades, costumbres, cómo era y se comportaba esa persona) qué la hacía tan especial ante sus ojos.

Luego indique que debajo de su propio nombre describan cómo son, sus características, cualidades, habilidades, etc.)

Cuando hayan terminado, pregunte si alguno desea compartir su trabajo.

ADAPTACIÓN

En lugar de escribir, los participantes contestan de manera verbal las preguntas en el plenario.

La adaptación de la dinámica seria:

Actividad 1 "Lo que recibí y lo que tengo"

Pregunta 1: "Lo que recibí"

Diga: "Piensen en una persona muy importante para ustedes, alguien que les enseñó algo bueno o les dio cariño".

Ahora, quien quiera compartir, diga en una frase: *"Esa persona importante en mi vida me dio… (cariño, paciencia, consejo, apoyo, trabajo, tranquilidad, ejemplo)"*

Pregunta 2: "Lo que tengo yo"

Luego diga: "Ahora pensemos en nosotros mismos.

Cada uno va a decir una cosa buena que tiene.

"Yo tengo… (fortaleza, paciencia, alegría, responsabilidad, bondad)' ".

Concluya: *"Todas y todos hemos recibido algo bueno de alguien especial, y también tenemos cosas buenas dentro de nosotros. Esto es parte de quienes somos".*

Luego de escucharlos pregunte:

"Ya que hemos hablado de esa persona tan importante y también de ustedes mismos, ¿creen que se parecen en algo? ¿Tienen alguna cualidad o forma de ser parecida a esa persona?"

Finalmente señale que...

La forma como son y cómo se comportan las personas, forma parte de su **identidad personal**. **Cada persona es única**, pero puede verse influenciada por personas importantes de su vida.

> **La identidad personal es el conjunto de características, valores y experiencias de una persona, que se forman desde los primeros años de vida, en interacción con la familia, la escuela, el vecindario y el contexto en el que vive.**

Continue, explicando que, durante la adolescencia, las personas iniciamos un proceso de reflexión sobre uno mismo, en el que surgen preguntas: ¿quién soy ahora? ¿me gusta cómo me veo? ¿quién me atrae? Y ¿qué quiero lograr en la vida? Este proceso, implica tener que asumir decisiones propias. Responder estas preguntas en esta etapa es fundamental para la definición de la **identidad**.

ADAPTACIÓN

Para población no letrada, brinde una explicación sencilla sobre el proceso de construcción de la identidad, apoyándose en imágenes como las siguientes:

1. La imagen de un/a adolescente en actitud reflexiva, con signos de interrogación alrededor, que represente la pregunta: "¿Quién soy?".
2. La imagen de una adolescente mirándose al espejo y expresando satisfacción con su apariencia, que simbolice la aceptación de su imagen corporal.
3. La imagen de una adolescente pensando si estudiar arquitectura o veterinaria, que ilustre la elección de una carrera u oficio.
4. La imagen de un adolescente mostrando que siente atracción por alguien, con figuras de otros adolescentes, mujeres y varones, que represente la atracción afectiva o sexual.

Finalmente pregunte. ¿Será que, en la definición de nuestra identidad, sólo influyen nuestras personas importantes? ¿Habrá otras personas o cosas que influyen en cómo somos?

Señale que, para responder a esas preguntas, lo harán con un ejercicio práctico, trabajando en grupos.

Actividad 2. "Esto puede pasar" (25 minutos)

Forme grupos de 5 a 6 personas, según la cantidad de participantes.

Entregue a cada grupo un caso (Recurso N ° 2).

Explique que cada grupo leerá el caso y responderá algunas preguntas planteadas. Luego, un representante del grupo expone al plenario las respuestas.

Esté atento a las respuestas de los padres y madres de familia, y de ser necesario re pregunte para asegurar que se cumpla el objetivo de la reflexión; que los padres identifiquen que hay otros factores externos que influyen la formación de la identidad. Así mismo, esté atento a las respuestas concretas sobre las acciones que puede hacer un padre o madre frente a cada situación.

ADAPTACIÓN

Se sugiere que en lugar de que los participantes lean, el co-facilitador narre los casos, los cuales puede acompañar con imágenes.

Cuando todos los grupos hayan respondido las preguntas sobre el caso, agradezca y felicite.

Luego, conduzca una reflexión final con las siguientes preguntas:

- *¿De qué nos damos cuenta?*
- *¿Quiénes más pueden influir en la identidad o forma de ser de nuestros hijos?*
- *¿Qué podemos hacer en las familias para formar de manera positiva la identidad de nuestros hijos?*

Integre los aportes destacando **la importancia de fortalecer la autoestima** en los hijos y el rol del hogar como espacio seguro para el desarrollo de la identidad.

Complemente con las siguientes ideas:



A continuación, invite a realizar un ejercicio que les ayudará a comprender la importancia de estimular la autoestima de sus hijos.

Actividad 3. "Reflejando a mi hijo" (25 minutos)

Distribuya una hoja y un lápiz a cada padre o madre, y solicite que dibujen la silueta de su hijo o su hija adolescente (también se le podría dar una silueta ya hecha).

Adaptación

La dinámica se puede realizar de manera oral.

Solicite que escriban en la silueta:

- *¿Qué cualidades tiene su hijo adolescente? ¿cómo es? (por ejemplo. Es colaborador, ayuda en la casa, etc.) o ¿qué es lo que sabe hacer? o ¿hace bien? (por ejemplo, dibuja muy bonito)*

Facilite para que, de manera voluntaria, compartan lo que han escrito sobre sus hijos.

Felicite, agradezca y pregunte:

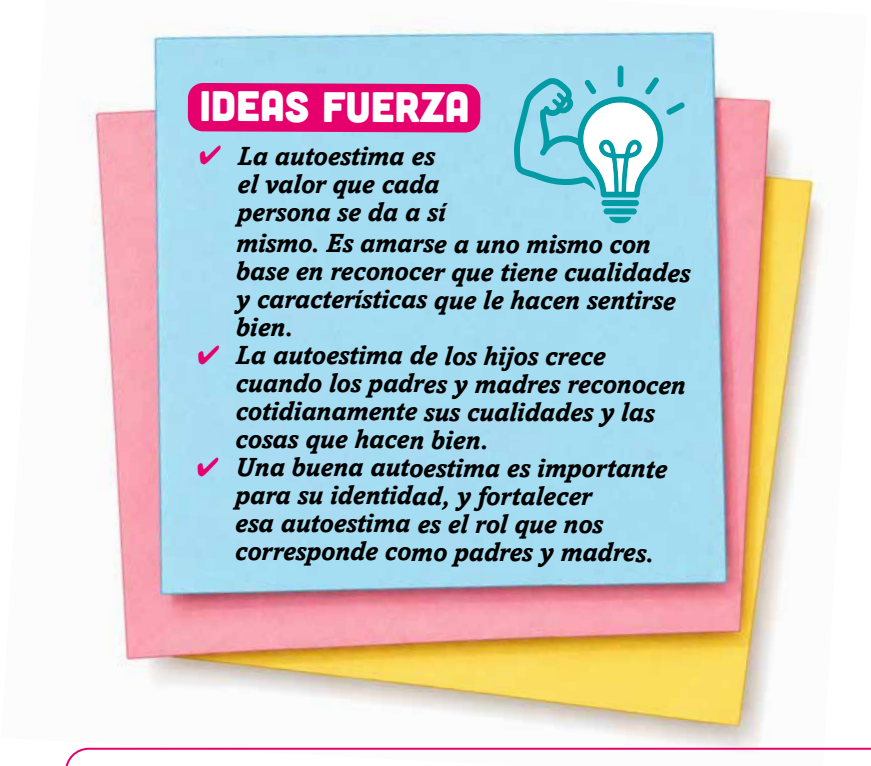
- *¿Cuán a menudo felicitan a su hijo por sus cualidades positivas o sus buenas acciones?*
- *¿Cuando hablo con mi hijo, me centro en lo positivo, o suelo recordarle las cosas malas que hace?*
- *¿Aquello que le digo a mi hijo, cómo le afecta?*

Permita respuestas voluntarias.

Finalmente pregunte:

- *¿Por qué es importante reconocer las cosas buenas de nuestros hijos? (respuesta esperada: se sienten bien, así aprenden a valorarse, a tener autoestima)*
- *¿Qué entendemos por autoestima?*
- *¿Cuál es el rol del padre y la madre en el desarrollo de la autoestima?*

Con la ayuda del co-facilitador recoge las ideas en un papelógrafo y complemente con las siguientes ***ideas fuerza:***



Muestre **las estrategias de apoyo para el desarrollo de la identidad y los pilares para la formación de la identidad** en una lámina de PPT o en un papelógrafo, y explíquelas según el marco teórico, adaptándolas a la comprensión del grupo.

- Brindar ejemplo y transmitir valores
- Brindar afecto y calidez en el trato
- Resaltar lo valioso en cada adolescente
- Evitar comparaciones con otras personas
- Escuchar, sin juzgar y mostrar comprensión por sus emociones
- Fomentar que se relacione con quienes tienen cosas en común (valores)
- Fomentar el logro de sus metas y sueños
- Brindar oportunidad para desarrollar otras capacidades

Adaptación

Presentar las principales estrategias de apoyo para el desarrollo de la identidad, mediante imágenes.

Consulte si tienen alguna pregunta o comentario, escuche responda y finalice la sesión con la actividad de cierre.

CIERRE

Actividad 4. Momento creativo (20 minutos)

a) Aplicación práctica:

Formando grupos, cada grupo hace un arte o manualidad de palabras que permiten la construcción positiva de la identidad. (Por ejemplo, palabras como: amor, reconocimiento, respeto, afecto, entre otras)

b) Compromiso personal:

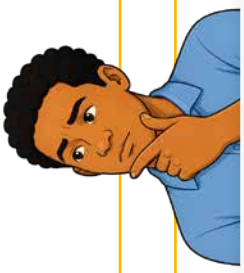
- Cada padre/madre recibe una tarjeta.
- Se les pide escribir un compromiso personal que pondrá en práctica durante la semana para acompañar mejor el desarrollo de la identidad de su hijo(a) (ej.: escuchar más, preguntar con interés genuino, reconocer logros pequeños, conversar sobre redes sociales, respetar gustos).
- Luego, se pega cada tarjeta en el Mural de compromisos.
- Queda como símbolo colectivo del compromiso asumido.

> "Acompañar con respeto, paciencia y amor es el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos en su camino de descubrir quiénes son".

Recursos

Recurso 1

Formato "La persona más importante para mí"



Yo

Nombre:

La persona más importante para mí

Nombre:

Recurso 2

CASOS

Caso 1 Eugenia y la chica nueva de la clase



Eugenia tiene 14 años, vive en Piura, y es la única mujer de 4 hermanos, es una chica tranquila, no tiene muchos amigos en la escuela. Su madre dice que ella para mirándose en el espejo, que no sabe obedecer. Eugenia antes practicaba vóley, pero últimamente lo dejó. Una nueva alumna ha venido a su escuela, aunque no son amigas, Eugenia pasa mucho tiempo del recreo observándola. La nueva alumna le parece muy linda, le gusta el color de su piel y su pelo largo, y además que a pesar de que es nueva ha hecho muchos amigos.

Eugenia le ha pedido a su mamá que le compre cremas para cuidar su piel y se ha dejado crecer el cabello y lo lleva suelto. Sus compañeros la observan rara, y le dicen que se ve fea con el cabello suelto.

- ¿Cómo es Eugenia? ¿cómo se siente? ¿por qué?
- ¿Qué está influenciando en el comportamiento de Eugenia?
- Si fueras los padres de Eugenia ¿cómo la ayudarían?

Caso 2 Diego y el fútbol



Diego tiene 16 años, vive en Ayacucho solo con la mamá y la abuela. La mamá dice que no sabe qué hacer, pues "le da de todo" pero él no estudia y no colabora, ni siquiera con limpiar su cuarto. Diego no conoce a su papá y la mamá prefiere no hablar de él. Diego disfruta mucho jugar fútbol, y es un buen jugador, pero no entiende a sus amigos cuando estos quieren jugar vóley, ya que según Diego "no es deporte de hombres". Algunos de sus amigos lo apoyan, otros lo critican, pero a Diego no le importa.

- ¿Cómo es Diego? ¿Qué piensa de los chicos que no son como él?
- ¿Qué puede estar influyendo en la forma de ser de Diego?
- Si fueras la madre de Diego, ¿cómo lo ayudarías?

Caso 2 Javier quiere ser "chef"



Javier tiene 17 años y vive en Huancavelica. Está por terminar la secundaria, es un estudiante responsable y lo que más le gusta es la cocina; incluso destaca en los talleres de gastronomía. Su sueño es ser chef.

Pero en su familia todos los hombres son ingenieros o militares. Su papá, un hombre de carácter fuerte, le repite que "la cocina es cosa de mujeres", y sus hermanos apoyan esa idea. La mamá no discute, pero acompaña en silencio: le enseña recetas, le consigue ingredientes y prueba todo lo que él prepara.

En casa, las conversaciones sobre su futuro suelen ser muy tensas. Javier se siente confundido: por un lado, quiere complacer a su padre; por otro, siente que estaría traicionándose si abandona lo que realmente le apasiona: cocinar

- ¿Cómo es Javier? ¿cómo se siente? ¿por qué?
- ¿Qué puede pasar si Javier decide complacer a su papá?
- ¿Cómo podría su padre apoyarlo?

Respuestas esperadas a los casos

Caso 1: Eugenia y la chica nueva de la clase

Cada persona es diferente, cada una tiene sus rasgos físicos, y eso no hace a la persona mejor ni peor que otra. Somos diversos y debemos aceptarnos como somos. En lugar de querer imitar debemos esforzarnos por ser mejor persona cada día.

Caso 2: Diego y el fútbol

Los hombres no tienen por qué ser todos iguales, ni gustarle los mismos deportes o las mismas cosas. Jugar el futbol no te hace más hombre.

Todo adolescente tiene derecho a expresar su identidad y a que le respete.

Caso 3: Javier quiere ser "chef"

Su padre debe entender que no existen carreras exclusivamente de hombres o de mujeres, que un hombre debe estudiar una determinada carrera supuestamente de hombres, es una creencia en la sociedad, hoy en día, hombres y mujeres pueden estudiar lo que quieran ser.

Los adolescentes tienen derecho a expresar su identidad y a desarrollar su potencial como personas.

Sesión 3

Adolescencia: comprendiendo los cambios y manifestaciones de la sexualidad en esta etapa de la vida



I. LO QUE DEBO SABER PARA DESARROLLAR LA SESIÓN

1.1. LA ADOLESCENCIA

La adolescencia, definida por la OMS como el período comprendido entre los 10 y los 19 años, y por el MINSA como el periodo comprendido entre los 12 a los 17 años, 11 meses y 29 días, es una etapa de rápidos y profundos cambios de orden biológico, cognitivo, emocional y social. Es decir, su desarrollo es multidimensional, porque abarca varios aspectos que se relacionan entre sí.

Los cambios de naturaleza física son los primeros en manifestarse, incluyendo el surgimiento de la capacidad reproductiva; etapa a la que se le conoce como pubertad. En paralelo, otros cambios relacionados con funciones cerebrales complejas y la toma de decisiones pueden continuar incluso en la etapa siguiente. Durante esta transición, se espera que los adolescentes sean capaces de lograr actuar con autonomía y consolidar su identidad personal, procesos que deben ser acompañados por los adultos que los cuidan.

1.2. CAMBIOS FÍSICOS

Los cambios físicos se inician con la pubertad, aproximadamente a partir de los 9 años, pero puede variar de acuerdo al contexto socio económico de cada persona. La pubertad se caracteriza por el rápido crecimiento físico (llamado "estirón") la aparición de las características sexuales secundarias, el comienzo de la menstruación en la mujer (menarquia) y la capacidad eyaculatoria en el varón (espermarquia).

Los cambios físicos que se observan en las púberes mujeres y en los púberes varones se producen a consecuencia del funcionamiento hormonal; la testosterona en los varones y los estrógenos y progesterona en las mujeres.

A continuación, se detallan los principales cambios físicos observables:

En ambos:

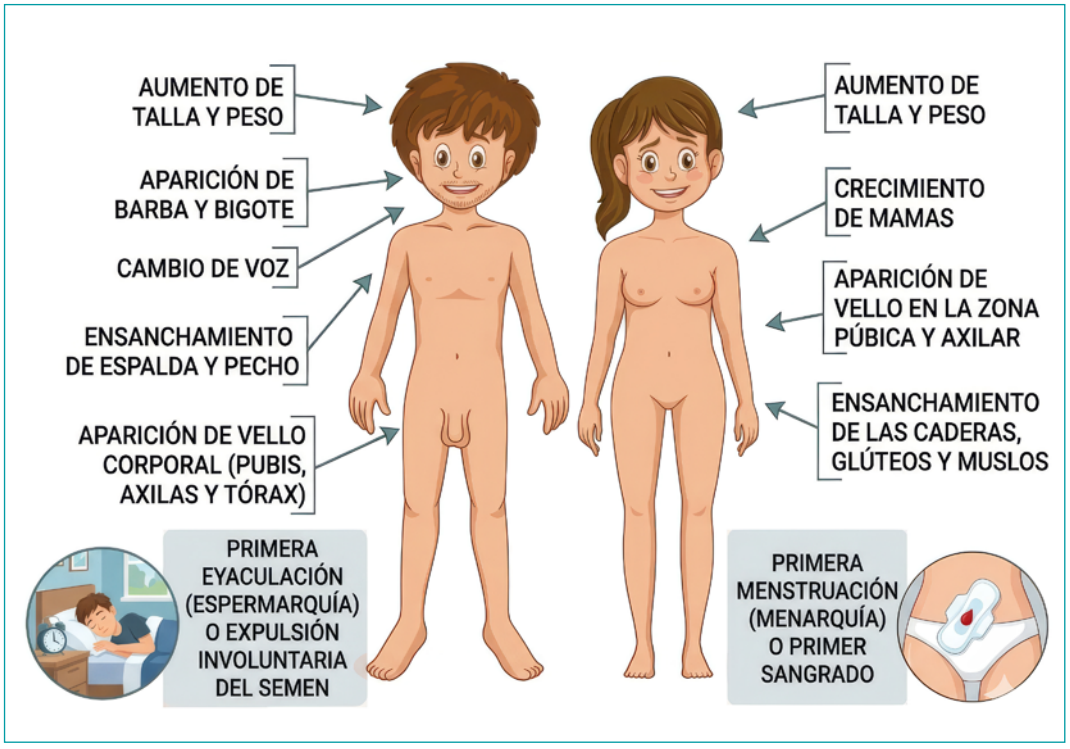
- Aumento de talla y peso
- Aparición del acné

En las mujeres:

- Crecimiento de los senos
- Crecimiento del vello en la zona púbica y en las axilas
- Ensanchamiento de las caderas, glúteos y muslos
- Aparición de la primera menstruación o menarca

En los varones:

- Aparición de vello en la zona del pubis, axilas, algunas veces en el tórax
- Aparición de barba y bigote
- Ensanchamiento de espalda y pecho
- Cambio de voz
- Primera eyaculación (espermarquia)
- Poluciones nocturnas



Durante la adolescencia, los cambios físicos pueden generar miedo, inseguridad o vergüenza. Es común que las chicas se sientan incómodas con la menstruación o que los chicos experimenten culpa al explorar su cuerpo. Estas emociones son normales, pero cuando no hay alguien con quien hablar, pueden generar angustia o confusión.

Además, los adolescentes están expuestos constantemente a mensajes en redes sociales, televisión y publicidad que muestran "cuerpos perfectos" y poco reales. Al compararse con esos modelos, muchos adolescentes, particularmente las mujeres, pueden sentirse insatisfechas con su apariencia o creer que deben parecerse a esos modelos para ser aceptadas.

Por eso, madres y padres cumplen un rol clave: deben conversar con sus hijos sobre los cambios físicos **antes** de que ocurran, para que los vivan con confianza y sepan cómo cuidarse. También es importante enseñarles a quererse, aceptar su cuerpo y comprender que el valor personal no depende del aspecto físico, sino de quiénes son y cómo se sienten consigo mismos.

1.3. CAMBIOS PSICOLÓGICOS

Lo más característico de esta etapa es la búsqueda y construcción de **la identidad personal.** Durante este proceso, el o la adolescente reflexiona sobre quién es, considera cómo lo perciben los demás y suele compararse con su grupo de pares para definir su propia manera de ser.

La presencia o intensidad de las características psicológicas en los adolescentes va a depender del contexto socio cultural en la que vive, algunos de los cambios más frecuentes son:

- **Impulsividad:** muchas veces actúan primero y piensan después; reaccionan con rapidez sin medir las consecuencias.
- **Labilidad emocional:** presentan cambios bruscos de humor y una mayor sensibilidad ante lo que les sucede.
- **Imagen de sí mismos inestable**: su autopercepción suele ser insegura o negativa, relacionada con los cambios corporales. Con frecuencia no se sienten conformes con su apariencia ni plenamente satisfechos consigo mismos.
- **Espíritu de contradicción:** tienden a oponerse a las ideas o normas de las personas adultas como una forma natural de marcar distancia y afirmar su identidad.
- **Sentimiento de invulnerabilidad** (omnipotencia): creen que "nada les va a pasar", lo que puede llevarlos a asumir conductas de riesgo.
- **Egocentrismo:** se perciben como el centro de atención, sienten que nadie los comprende y que sus experiencias son únicas.
- **Audiencia imaginaria**: piensan que los demás los observan o juzgan constantemente, lo cual los hace más sensibles a la opinión ajena.

1.4. CAMBIOS COGNITIVOS

En esta etapa se inicia el pensamiento abstracto, que implica razonar de manera más lógica y reflexiva. El pensamiento abstracto permite:

- Imaginar posibilidades más allá del presente y proyectarse al futuro.
- Elaborar hipótesis y analizar consecuencias, basándose en la lógica.
- Separar lo real de lo imaginario, desarrollando la capacidad de reflexión y creatividad.
- Cuestionar ideas establecidas y formar opiniones propias sobre temas sociales, políticos o filosóficos.
- Desarrollar habilidades para resolver problemas, siempre que cuenten con acompañamiento, información y espacios para decidir.

La madurez del pensamiento, está mediada por los estímulos del entorno socio educativo del adolescente.

1.5. CAMBIOS SOCIALES

La principal tarea del adolescente es **descubrir quién es** y **construir una identidad propia**, basada en cómo se percibe y en las relaciones que establece con los demás.

Cuando este proceso no se consolida, puede aparecer la **confusión de roles** (Erik Erikson).

Entre las características sociales más destacadas están:

- **Búsqueda de independencia** respecto a los padres, madres o adultos cuidadores.
- **Gran influencia del grupo de pares**, con quienes comparten lenguaje, estilos y formas de pensar.
- **Necesidad de pertenecer a un grupo**, lo que fortalece su sentido de identidad y seguridad.
- **Desarrollo del sentido solidario y altruista**, junto con una mayor empatía.
- **Fuerte sentido de justicia**, que los lleva a cuestionar aquello que consideran injusto.
- **Cuestionamiento de valores familiares y sociales**, como parte del proceso de formar su propio sistema de creencias.
- **Asunción de nuevas responsabilidades**, que marcan la transición hacia la vida adulta.

Algo que puede ayudar a padres y madres a comprender los cambios psicológicos emocionales y sociales de la adolescencia es conocer sobre la madurez gradual del cerebro. En la adolescencia la zona frontal, responsable de la planificación, anticipación de consecuencias, la toma de decisiones recién empieza a madurar hacia el término de la adolescencia. Y más bien es la zona límbica del cerebro; la relacionada con el placer, el riesgo, etc., la que se encuentra más activa[16].

1.6. ROL DE LA FAMILIA DURANTE EL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA

Madres y padres pueden:

- Hablarles con naturalidad de los cambios propios de su cuerpo antes de que estos ocurran.
- Ser empáticos frente a sus fluctuaciones emocionales, sin dejar de establecer límites.
- Brindarles oportunidades para que socialicen y compartan actividades y deportes, pero siempre conociendo dónde y con quien se reúne.
- Fortalecer su confianza y su autoestima frente a los cambios que está viviendo.
- Promover autonomía progresiva dándole responsabilidades, para con la familia, de acuerdo a su edad
- Reconocer que las expresiones de la sexualidad es parte natural de su crecimiento.

16 PRISMA-UNICEF (2024)

- Brindar información clara y sin prejuicios y transmitirle sus valores al respecto.
- Hablar de su derecho al consentimiento y a tomar decisiones responsables.
- Escuchar con empatía y sin juzgar sus dudas, miedos y sentimientos.
- Promover un diálogo abierto en casa, que les dé seguridad y confianza

1.7. SALUD MENSTRUAL

La salud menstrual es un tema importante que los padres y las madres deben conocer para apoyar a sus hijas durante este período natural de sus vidas. Para ello es necesario saber responder las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la menstruación?

La menstruación es el sangrado vaginal normal y sano que ocurre cuando el revestimiento del útero cumplió su ciclo y no ha habido un embarazo; se expulsa sangre y parte de tejido del interior del útero.

b) ¿Qué es la salud menstrual?

La salud menstrual se define como el bienestar físico, mental y social completo en relación con el ciclo menstrual[17], y no simplemente la ausencia de enfermedades o dolencias, en relación con el ciclo menstrual Esto incluye la gestión del sangrado menstrual, el manejo del dolor y los síntomas asociados, y la promoción de una buena higiene y bienestar general.

Para tener salud menstrual se requiere que se cumpla con ciertas condiciones para las niñas, adolescentes, y mujeres.



FUENTE: Adaptado del Curso semipresencial "Cuidado integral de la Salud Menstrual desde los establecimientos de salud" (UNICEF-KALLPA, 2025)

17 Hennegan, J · Winkler, IT · Bobel, C · et al. Salud menstrual: una definición para la política, la práctica y la investigación. La salud reproductiva importa. 2021; 29 :1-8

c) ¿Cómo pueden los padres y las madres apoyar a sus hijas durante la menstruación?

Los padres y las madres pueden apoyar a sus hijas a través de las siguientes acciones:

- **Educación y comunicación:** Hablar con las hijas sobre la menstruación y responder a sus preguntas de manera honesta y abierta.
- **Preparación:** Ayudarles a prepararse para su primer período menstrual, explicándoles qué esperar y cómo manejar el sangrado.
- **Apoyo emocional:** Ofrecer apoyo emocional y comprensión durante el período menstrual, ya que puede ser un momento emocionalmente desafiante para algunas adolescentes.
- **Gestión del dolor:** Ayudar a las hijas a encontrar formas de manejar el dolor menstrual, como el uso de medicamentos o de técnicas de relajación.
- **Higiene y bienestar:** Animarlas a practicar una buena higiene menstrual, como cambiar regularmente los productos de higiene menstrual y lavarse las manos después de usar el baño.

d) Orientaciones para padres y madres de familia

- **Sé paciente y comprensivo:** La menstruación puede ser un tema delicado para algunas adolescentes.
- **Utiliza lenguaje claro y accesible:** Explica qué es la menstruación de manera clara y comprensible para que las hijas puedan entender.
- **Fomenta la confianza:** Ayuda a tus hijas a sentirse seguras y confiadas en su capacidad para manejar su menstruación.
- **Busca recursos adicionales:** como libros o sitios web, para obtener más información y apoyo.

Al entender y apoyar la salud menstrual de las hijas adolescentes, se le ayuda a desarrollar una relación positiva con su cuerpo y a sentirse más seguras y confiadas durante este período.

1.8 IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE LOS GENITALES EN LA ADOLESCENCIA

La higiene de los genitales es fundamental tanto para mujeres como para varones, ya que previene enfermedades y aporta al bienestar de los adolescentes.

a) En adolescentes mujeres la higiene adecuada contribuye a:

- La prevención de infecciones: como la candidiasis, la tricomoniasis y la vaginosis bacteriana[18].

18 https://www.cdc.gov/trichomoniasis/es/about/acerca-de-la-.html#:~:text=*%20Archivo%20CDC.%20*%20Publicaciones%20de%20Salud%20P%C3%BAblica.

- El mantenimiento de la salud vaginal y prevenir problemas como la sequedad vaginal y la irritación.
- La prevención de malos olores: La higiene adecuada de los genitales puede ayudar a prevenir malos olores y mantener la confianza y la autoestima.

b) En adolescentes varones la higiene adecuada contribuye a:

- La prevención de infecciones: como la balanitis y la epididimitis (La balanitis es la inflamación del glande (la punta del pene) y la epididimitis es la inflamación del epidídimo, un tubo enrollado detrás del testículo). Mantener el área limpia ayuda a prevenir la acumulación de bacterias y hongos que pueden causar estas infecciones.
- Una higiene genital adecuada es crucial para prevenir la **fimosis adquirida** (la que se desarrolla más tarde en la vida (pero no previene la **fimosis fisiológica o congénita).** Esta se desarrolla más tarde, a menudo en la adolescencia o la edad adulta, y es causada por cicatrices. La causa principal de estas cicatrices son episodios repetidos de inflamación o infección (como la balanitis). (Asociación Española de Pediatría (AEP)
- La prevención de malos olores y mantener la confianza y la autoestima.

c) Orientaciones sobre higiene de los genitales para los adolescentes:

La buena higiene de los genitales puede contribuir a una mejor salud y bienestar en general. A continuación, se presentan algunas orientaciones para las y los adolescentes.

En adolescentes mujeres	En adolescentes varones
La vagina tiene su propio sistema de autolimpieza. La higiene debe centrarse en la vulva (la parte externa). **Limpieza Suave:** Lava solo la parte externa de los genitales (la vulva) con agua y, si lo deseas, un jabón suave o gel de higiene íntima adecuado.	**Limpieza Completa:** Durante la ducha, se deben lavar bien todas las zonas. Si no estás circuncidado, es importante retraer suavemente el prepucio para limpiar la cabeza del pene con agua y jabón suave, eliminando cualquier acumulación (esmegma).
Dirección Correcta: Al limpiarte o usar papel higiénico, hazlo de adelante hacia atrás (desde la vulva hacia el ano). Esto es fundamental para evitar arrastrar bacterias del área anal hacia la vagina o el tracto urinario, lo que puede causar infecciones urinarias.	**Después de Orinar:** Sacude suavemente el exceso de orina y, si es necesario, usa papel higiénico para secar la punta del pene para evitar que la humedad manche la ropa interior o cause olores.
Evita las duchas vaginales: No es necesario ni recomendable realizar duchas vaginales internas. Estas pueden eliminar las bacterias buenas y alterar el equilibrio natural de la vagina.	**Secado:** Asegúrate de secar bien el pene y el área circundante, incluyendo los testículos y la ingle.

En adolescentes mujeres	En adolescentes varones
Higiene menstrual: Durante la menstruación, cambia las toallas sanitarias o tampones menstruales regularmente según las instrucciones del producto para mantener la higiene y prevenir olores e infecciones.	

Para ambos sexos
Ducha Diaria: Ducharse o bañarse a diario con agua tibia y un jabón neutro o suave es la mejor manera de mantenerse limpio y eliminar las bacterias que causan mal olor.
Secado Completo: Es vital secar completamente la zona genital después del lavado, prestando especial atención a los pliegues, ya que la humedad favorece el crecimiento de hongos y bacterias. Usa una toalla limpia dando golpecitos suaves, sin frotar.
Ropa interior de algodón: Utiliza ropa interior de algodón limpia todos los días. El algodón es transpirable y ayuda a mantener la zona seca, a diferencia de los materiales sintéticos que retienen la humedad.
Evita productos perfumados: Evita el uso de desodorantes íntimos, polvos perfumados, toallitas perfumadas o jabones con fragancias fuertes, ya que pueden irritar la piel sensible y alterar el pH natural de la zona, predisponiendo a infecciones.
Lávate las manos: Lávate bien las manos con agua y jabón antes y después de ir al baño, así como antes y después de cualquier práctica de higiene íntima.

Fuente: Portal Web del Ministerio de Salud, Asociación española de Pediatría (AEP), Nemours TeensHealth - Aspectos Básicos de la higiene.

La higiene genital y la salud menstrual son reconocidas como derechos de todos los adolescentes. Organismos como UNICEF, UNFPA, la OMS y el MINSA destacan la importancia de que las familias, las escuelas y los servicios de salud brinden educación clara, respetuosa y libre de prejuicios.

1.9. LAS EXPRESIONES DE LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE

a) La masturbación

La masturbación es una manifestación natural de la sexualidad, presente en diferentes etapas del desarrollo. En la infancia y adolescencia, forma parte del proceso de exploración y conocimiento del propio cuerpo. No causa daño físico ni psicológico.

Desde pequeños, niños y niñas pueden tocar sus genitales porque descubren sensaciones agradables, sin intención sexual. Esta conducta suele disminuir en la niñez y puede reaparecer en la adolescencia debido a los cambios hormonales.

Tanto varones como mujeres pueden masturbarse, aunque persisten mitos que generan culpa o vergüenza, por creencias culturales.

La masturbación continúa siendo un tema tabú debido a creencias culturales y falta de información. Es importante abordarla con enfoque educativo, reconociendo que es una conducta normal del desarrollo y promoviendo mensajes de respeto, privacidad y autocuidado.

Es importante que madres y padres comprendan que la masturbación forma parte del desarrollo natural de la sexualidad y no representa un problema en sí misma. Hablar del tema con calma, sin juicios ni castigos, ayuda a que los hijos la vivan con responsabilidad y sin culpa.

Se recomienda:

- **Mantener una comunicación abierta y respetuosa**, brindando información clara y basada en evidencia.
- **Evitar transmitir miedo, vergüenza o culpa**, ya que estas emociones pueden afectar la relación con el propio cuerpo.
- **Explicar que la masturbación es una práctica privada**, que no debe realizarse en lugares públicos.
- **Promover valores de autocuidado y respeto**, recordando que cada persona decide libremente sobre su cuerpo.
- **Buscar orientación profesional** si la conducta es excesiva, interfiere con otras actividades o se usa como forma de aliviar el malestar emocional.

Un acompañamiento afectuoso y educativo fortalece la confianza y permite que los adolescentes vivan su sexualidad de manera saludable y responsable.

b) El enamoramiento en la adolescencia

El **enamoramiento** es una experiencia emocional intensa que implica atracción, admiración y deseo de cercanía hacia otra persona. Se caracteriza por una idealización del otro, pensamientos frecuentes sobre esa persona y una mezcla de emociones positivas (alegría, entusiasmo, ilusión) y, a veces, de inseguridad o miedo al rechazo[19].

Se caracteriza por:

- Sentimientos intensos de atracción, pasión y apego hacia alguien.
- Idealización de la persona que les gusta, atribuyéndole cualidades perfectas y sobrevalorando la relación.
- Pueden sentir una fuerte dependencia emocional hacia la persona que les gusta, lo que puede afectar su autoestima y bienestar emocional.

c) Importancia del enamoramiento en la adolescencia:

Es una oportunidad para desarrollar habilidades emocionales, como la empatía, la comunicación y la regulación emocional y para aprender a resolver conflictos

19 Papalia, D., & Martorell, G. (2017). Desarrollo humano (13.ª ed.). McGraw-Hill Education.



Desafíos y riesgos:

- Puede terminar en desilusión y dolor, lo que puede afectar la autoestima y el bienestar emocional.
- Pueden sentir presión social para tener una relación o para ajustarse a ciertas expectativas, particularmente las mujeres.
- Puede afectar la salud emocional y aumentar el riesgo de ansiedad, depresión o comportamientos de riesgo.

Frente a los desafíos y riesgos del enamoramiento en la adolescencia, es importante que los padres y madres aborden el tema de manera abierta y honesta con sus hijos.

El enamoramiento es una oportunidad para fortalecer el diálogo familiar y hablar sobre afectividad, respeto, límites y cuidado. Madres y padres deben acompañar sin juzgar, escuchando con apertura para comprender cómo viven sus hijos el enamoramiento.

Algunas recomendaciones para padres y madres sobre el enamoramiento:

- **Comunicación abierta:** Es importante que hablemos abiertamente sobre tus sentimientos y relaciones. “Estoy aquí para escucharte y apoyarte”.
- **Establecer límites claros:** “Entiendo que estás creciendo y que quieres más independencia, pero es importante que establezcamos límites claros y razonables para tu seguridad y bienestar”.
- **Fomentar la autoestima:** “Recuerda que tu valor y autoestima no dependen de tu relación con alguien. Eres una persona valiosa y mereces ser tratada con respeto y amor”.

- **Hablar sobre la presión social:** "Sé que puede haber presión para tener una relación o para hacer ciertas cosas. Recuerda que no tienes que hacer nada que no te haga sentir cómodo".
- **Animar a la reflexión:** «¿Qué crees que es importante en una relación? ¿Qué te hace feliz y qué te hace sentir mal?» ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de tener una relación a esta edad? ¿cómo puede repercutir tener una relación a esta edad, en tus planes de vida?
- **Ofrecer apoyo:** "Estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Si necesitas hablar o si necesitas ayuda, no dudes en venir a mí".

Algunas orientaciones adicionales:

- **Sé paciente y comprensivo**: Recuerda que la adolescencia es un período de cambio y exploración.
- **Evita juzgar:** Trata de no juzgar a tus hijos por sus sentimientos o decisiones.
- **Fomenta la responsabilidad:** Anima a tus hijos a tomar decisiones responsables y a considerar las consecuencias de sus acciones.

Al abordar el tema del enamoramiento de manera abierta y honesta, los padres y las madres pueden ayudar a sus hijos a transitar los desafíos y prevenir los riesgos asociados con las relaciones afectivas y a desarrollar habilidades saludables para las relaciones futuras.

1.10. EL INICIO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA:

El inicio sexual en la adolescencia se refiere al momento en que el adolescente tiene su primera relación sexual voluntaria, lo que constituye un hito dentro de su desarrollo sexual y afectivo. Este proceso está determinado por una combinación de factores individuales, familiares, sociales y culturales, y requiere orientación adecuada para favorecer decisiones informadas y seguras[20].

Las causas del inicio sexual en adolescentes peruanos son diversas. Se debe a factores a nivel individual, familiar y socio contextual. A nivel individual, por ejemplo, el consumo de alcohol y las actitudes permisivas hacia el sexo (verlo como algo normal), así como el hecho de ser varón, estarían más asociados al inicio sexual temprano. A nivel familiar la falta de comunicación con los padres sobre temas de sexualidad, la presencia de familiares que ya fueron padres adolescentes, las familias monoparentales, y las relaciones familiares sin apoyo emocional. A nivel social y cultural, el nivel socioeconómico, la influencia de amigos y la presión de grupo[21]. También la residencia en zonas rurales o la selva y comunidades más pobres muestran inicio sexual más temprano comparado con zonas urbanas[22].

Es importante orientar a los padres y madres a tener presente estos factores para que orienten a sus adolescentes que iniciar relaciones sexuales porque las amigas lo hacen, o para demostrar a los amigos que "ya se es hombre" o actuar bajo los efectos del alcohol no es beneficioso, ya que estas situaciones limitan la libertad de decidir y pueden perjudicar su desarrollo.

20 OMS, 2020; UNFPA, 2022; Ministerio de Salud del Perú, 2023.
21 Cueto, S., & Leon, J. (2016). Early sexual initiation among adolescents: A longitudinal analysis for 15-year-olds in Peru. Interamerican Journal of Psychology, 50(2), 186-203.
22 UNFPA, Perú, 2019. El poder de decidir: Derechos reproductivos y transición demográfica.

Así también es importante explicar a los padres y madres que el inicio sexual sin protección en la adolescencia tiene riesgos para su salud como: embarazo no intencionado, Infecciones de transmisión sexual (ITS) y problemas emocionales o psicológicos asociados como la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, incluso el suicidio.[23]

Es también importante señalar que algunas adolescentes mujeres se inician sexualmente en contextos de presión, coerción o sin consentimiento, lo que deteriora profundamente su sentido de bienestar y autonomía.

Los padres y las madres pueden desempeñar un papel fundamental en la educación de sus hijos, en relación con la iniciación sexual.

Algunas sugerencias para las madres y los padres sobre iniciación sexual son:

- Establezca una relación de confianza y una comunicación abierta y honesta sobre temas de sexualidad desde antes de la adolescencia
- Aproveche los momentos cotidianos para hablar sobre temas de sexualidad y relaciones sexuales
- Escuche con serenidad y evite juzgar o criticar cuando el adolescente le pregunta o le cuenta sobre las relaciones sexuales.
- Exprese lo que cree y piensa sobre las relaciones sexuales en la adolescencia y ayúdele a reflexionar sobre el beneficio de postergar la actividad sexual: poder continuar su desarrollo sin interferencia.
- Explique de manera clara sobre las consecuencias de las relaciones sexuales en la adolescencia y acompañe a la reflexión de los adolescentes sobre las "ventajas" o desventajas de iniciar las relaciones sexuales a esta edad, realizando un balance de lo que es mejor para ellos
- Sea honesto y transparente y admita cuando no sabe algo.
- Ayude a su hijo(a) a desarrollar una autoestima saludable y a tener confianza en sí mismo, lo que les permitirá tomar decisiones informadas y saludables.
- Hable sobre la autonomía corporal y el consentimiento en las relaciones sexuales.
- Busque otros recursos y apoyo adicional, como libros, talleres o consejeros, para ayudarle a abordar este tema
- Evitar hablar sobre sus propias experiencias, recordemos que cada uno vive y experimenta el inicio de las relaciones sexuales de manera individual y diferente.

Conversar sobre "cómo es la primera vez" no debería ser un tema prohibido o silenciado en la familia. Al contrario, es una oportunidad para que el padre o la madre pueda acercarse a los hijos, y acompañarlos en este proceso de descubrimiento y ayudarles a tomar decisiones responsables, a cuidarse, a defender su autonomía corporal y a construir relaciones basadas en el respeto y a ejercer sus derechos plenamente.

23 Wesche R, Kreager DA, Lefkowitz ES, Siennick SE. Early Sexual Initiation and Mental Health: A Fleeting Association or Enduring Change? J Res Adolesc. 2017 Sep;27(3):611-627. doi: 10.1111/jora.12303. Epub 2017 Feb 10. PMID: 28776829; PMCID: PMC5546176.

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



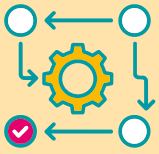
OBJETIVOS:
- Reconocer los cambios físicos, emocionales y sociales de la adolescencia y las expresiones de la sexualidad en esta etapa, en el contexto socio cultural actual.
- Comprender la importancia de la educación en salud e higiene menstrual.
- Comprender la importancia del acompañamiento al hijo adolescente.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Papelógrafo
- Plumones
- Tarjetas de 3 colores diferentes (verdes, celestes, amarillas) en tamaño: media hoja A4
- Cinta adhesiva
- Tarjetas adicionales
- Recurso N°1 Silueta de adolescentes
- "Mural de los compromisos" (elaborado en papelógrafo)



SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el objetivo y los temas que abordarán en la sesión, resaltando que las actividades requieren su participación activa para enriquecer el diálogo y el aprendizaje.

Actividad 1: "Mi Yo adolescente" en tres pasos... (visualización guiada) (20 minutos)

Invite a cerrar los ojos y respirar profundamente.

Con voz tranquila diga: "*Les invito a viajar en el tiempo... hacia atrás y a que regresen a cuando tenían 13 o 14 años. A esa edad eran adolescentes, con muchos cambios físicos, nuevos sentimientos y sueños por delante*".

Realice una narración pausada:

- *"Piensen en su cuerpo en esa etapa: ¿qué cambios notaban? ¿cómo se sentían con ellos?"*
- *"Recuerden el día de su primera menstruación o eyaculación... ¿cómo lo vivieron? ¿tuvieron información?, ¿con quién hablaron?"*
- *"Ahora, recuerden a sus amigos y amigas: ¿Qué lugar ocupaban en su vida?, ¿cómo se divertían, ¿qué les gustaba hacer juntos?"*
- *"Piensen en la primera vez que sintieron que alguien les gustaba, que les atraía... ¿recuerdan su primer amor? ¿Qué sentían en esos momentos?"*
- *"Piensen en su familia, cómo se llevaban con su padre, madre o la persona que lo crió, con quien tenía más confianza"*
- *"Y ahora, recuerden sus sueños: ¿Qué querían ser cuando fueran grandes? ¿cómo se imaginaban su futuro?"*

Invite a abrir los ojos, pregunte si lograron recordar su adolescencia, si fue fácil recordar o no. Asegure que los participantes hayan logrado hacer el ejercicio.

Luego pregunte si alguien quiere compartir y facilite para que al menos una persona comparta alguno de los recuerdos: sobre cambios, menstruación, primera eyaculación, amigos, primer amor, familia y sueños.

Agradezca la participación.

Finalmente solicite que escriban en una tarjeta, una palabra o frase que resuma **qué sintió en su adolescencia** (ejemplo: "vergüenza", "ilusión", "soledad", "amistad", "libertad") y lo peguen en la pared o papelote.

ADAPTACIÓN 1

En lugar de escribir, puede pedirles que piensen, en una palabra, que resuma cómo sintieron su adolescencia y la diga oralmente.

ADAPTACIÓN 2

Expresar con "caritas" cómo sintieron su adolescencia y colocar las caritas en el papelógrafo. (feliz, triste, avergonzado, etc).

Rescate las emociones comunes y diga:

IDEAS FUERZA



- ✔ ***La adolescencia es una de las etapas más hermosas de la vida. Todos pasamos por ella, algunos con alegría, otros con miedo, dudas, desconfianza, inseguridad, tristezas, pero todos con expectativas y sueños.***
- ✔ ***Así como nosotros atravesamos nuestra adolescencia llena de emociones, hoy nuestros hijos atraviesan lo mismo. Nos corresponde acompañarlos con respeto y cariño.***

Acompañar significa:
Escuchar al hijo sin juzgar, es decirle que comprendemos sus emociones, es hacerle reflexionar, es ayudarle a plantearse soluciones a sus problemas y necesidades, sin imponer, respetando y estimulando su autonomía y es brindarle límites claros y reglas con sentido desde el amor.

Invite a seguir dialogando sobre los cambios que ocurren en el cuerpo, en la mente y la forma como nuestros hijos se comportan al llegar a la adolescencia.

DESARROLLO

Actividad 2. Trabajo de grupo: "Los cambios durante la adolescencia" (25 minutos)

Para profundizar en el reconocimiento de los cambios de la adolescencia realice la siguiente dinámica.

Muestre una imagen de un adolescente y de una adolescente como la que aparece en la sección Recurso Nº1

Forme tres grupos. Entregue a cada grupo dos papelógrafos en los que dibujarán las siluetas de la imagen mostrada, y tarjetas de tres colores distintos.

Explique que, primero deben pensar en sus hijos adolescentes, recordar que cambios ha notado.

Señale que cada cambio que hayan observado, lo deben escribir en una tarjeta. Por ejemplo: le creció el bigote, me contesta feo, solo quiere estar en la calle. Cada cambio se debe escribir en una tarjeta.

Explique el uso de los colores de la siguiente manera:

Tarjetas verdes: son para escribir los cambios físicos. Por ejemplo: aumento de tamaño.

Tarjetas celestes: son para escribir los cambios psicológicos (emocionales, cambios en su forma de pensar). Ejemplo: se enoja mucho.

Tarjetas amarillas: se usarán para los cambios sociales. Ejemplo: Le gusta estar con los amigos.

En las siluetas colocarán las tarjetas que hayan escrito en el paso anterior.

Luego, facilite para que uno de los grupos explique su trabajo en plenaria, mientras los demás grupos complementan.

Refuerce este tema de los cambios con la ayuda del gráfico sobre los cambios en la adolescencia, que aparece en la sección de información básica.

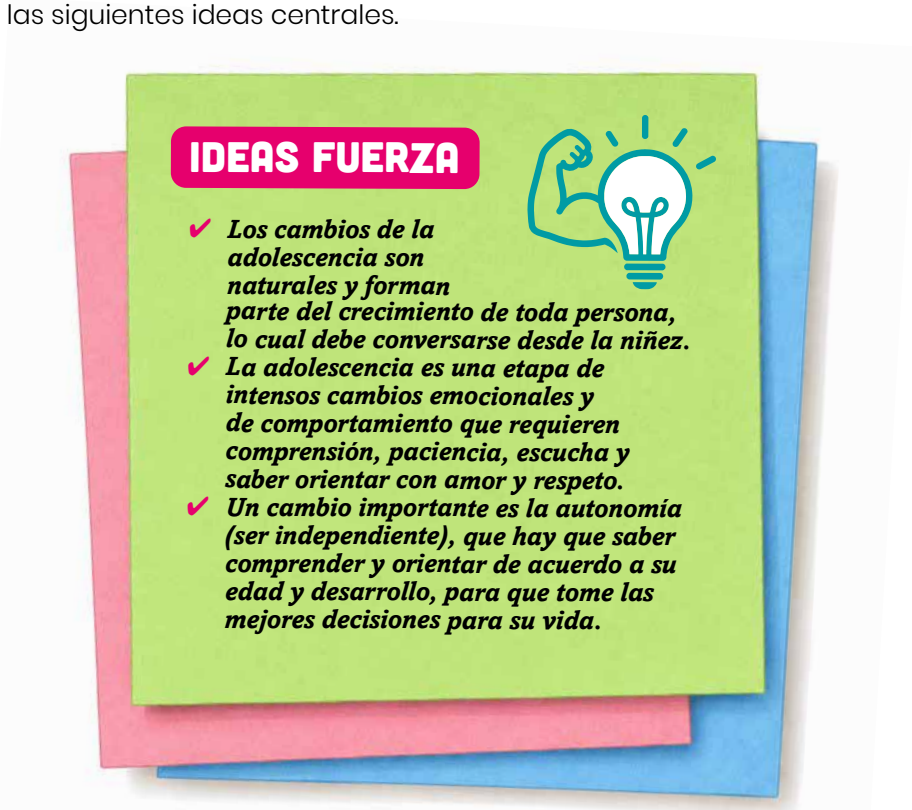
ADAPTACIÓN 1

Pedirles que escriban en tarjetas qué cambios han observado en su hijo(a) adolescente. Luego el facilitador es quien clasifica y explica a qué tipo de cambio se refiere.

ADAPTACIÓN 2

Se pueden utilizar imágenes con los principales cambios en la adolescencia para que las identifiquen y coloquen en los papelógrafos.

Finalice con las siguientes ideas centrales.



A continuación, señale que seguirán dialogando sobre los cambios y cuál es el papel de los padres y madres en la comprensión de los cambios en esta etapa del desarrollo.

Actividad 3. "Un paso adelante quién..." (25 minutos)

Solicite a los padres y madres que se pongan de pie y formen un círculo.

Explique que dará una instrucción: "De un paso adelante quien..."

La persona que cumpla con lo que usted diga, debe dar un paso adelante.

Solicite que sean sinceros en sus respuestas.

Inicie el ejercicio diciendo en voz alta: "De un paso adelante quien..."

- Habló con su hija de la menstruación antes que esta ocurra
- Habló con su hijo sobre las eyaculaciones antes que estas ocurran
- Habló de la masturbación con su hijo(a).
- Habló de la higiene de los genitales
- Habló sobre el enamoramiento
- Habló sobre la atracción sexual
- Habló sobre las relaciones coitales
- Habló sobre los cambios en el cuerpo



Agradezca la participación de los padres y madres.

Luego en plenaria facilite la reflexión del grupo con las siguientes preguntas:

- ¿A qué edad empezaron a tratar estos temas?
- ¿Qué les han dicho a sus hijos sobre la menstruación? ¿La primera eyaculación? ¿sobre la higiene de los genitales?
- ¿Qué les han dicho sobre la masturbación?

Permita la participación de dos o tres personas por pregunta, y escuche y agradezca las intervenciones.

- Si encuentra que los padres y madres responden en sentido contrario a lo que esperamos, por ejemplo, que señalen que "la masturbación te debilita". Evite confrontar, no descalifique, escuche y en tono amable señale que comprende su punto de vista, a la vez diga que, los estudios realizados señalan que esto no es así; pero que, tampoco se trata de alentar a que lo hagan, quien, por sus creencias, no quiere hacerlo.

- De esta misma manera, continúe reforzando información sobre los puntos abordados, con explicaciones concretas y claras adaptando la información que se presenta en la parte teórica de la sesión para padres y madres.

- Ponga especial interés en abordar y reforzar el tema de la menstruación y la salud menstrual de las adolescentes, así como la importancia de la higiene de los genitales.

IDEAS FUERZA



- ✔ ***La menstruación y la primera eyaculación son procesos normales del cuerpo, y comprenderlos ayuda a los hijos a vivirlos con tranquilidad. Los padres y madres cumplen un rol clave explicando con palabras sencillas qué es, por qué ocurre y resolviendo dudas para evitar el miedo y la vergüenza en los hijos.***
- ✔ ***Ayudar a las hijas a manejar el dolor durante la menstruación y reforzar hábitos de higiene hace que se sientan seguras, respetadas y capaces de cuidar su salud menstrual.***
- ✔ ***Cuidar la higiene de los genitales de varones y mujeres, ayuda a prevenir infecciones, incomodidades y malos olores. Acompañarlos con información simple y hábitos saludables contribuye a su bienestar y fortalece su autoestima.***
- ✔ ***La masturbación es una expresión normal del desarrollo, forma parte del proceso de exploración y conocimiento del propio cuerpo. No causa daño físico ni psicológico.***

Continúe la sesión preguntando:

- ¿Qué les han dicho sobre el enamoramiento? ¿las relaciones coitales?
- ¿Cómo se sintieron al hablar con sus hijos o hijas de estos temas? ¿por qué?
- ¿Por qué los padres y madres debemos abordar con los hijos el tema del enamoramiento, las relaciones coitales y la masturbación?
- ¿Qué puede hacer un padre o madre que no se siente seguro de poder abordar estos temas?

Escuche con atención, refuerce las ideas que aluden a que la educación sexual debe darse en los hogares, de lo contrario aprenderán sobre la sexualidad a través de los amigos o los medios de comunicación y la tecnología, que no siempre tienen la información correcta o adecuada para su edad.

Complemente con las siguientes ideas



Recuerde al grupo que pueden comunicarse con la Línea 103, opción 5, para recibir orientación en caso tuvieran alguna duda o quieran mayor información, o acudir al servicio para adolescentes del establecimiento de salud más cercano.

Invite a la siguiente actividad para el cierre de la sesión.

CIERRE:

Actividad 4. Dejando huellas (20 minutos)

- **Aplicación práctica:** Solicite que los padres y madres, hacer un tik tok con un mensaje breve a su hijo sobre alguno de los temas que se han abordado en la sesión.

- **Compromiso personal: "Mi compromiso como madre/padre"**

  Se entrega a cada participante una tarjeta.

  Escriben un **compromiso concreto** (ejemplo: "Hablaré con mi hija sobre la menstruación sin prejuicios", "Escucharé más y juzgaré menos", "Compartiré tiempo de calidad cada semana").

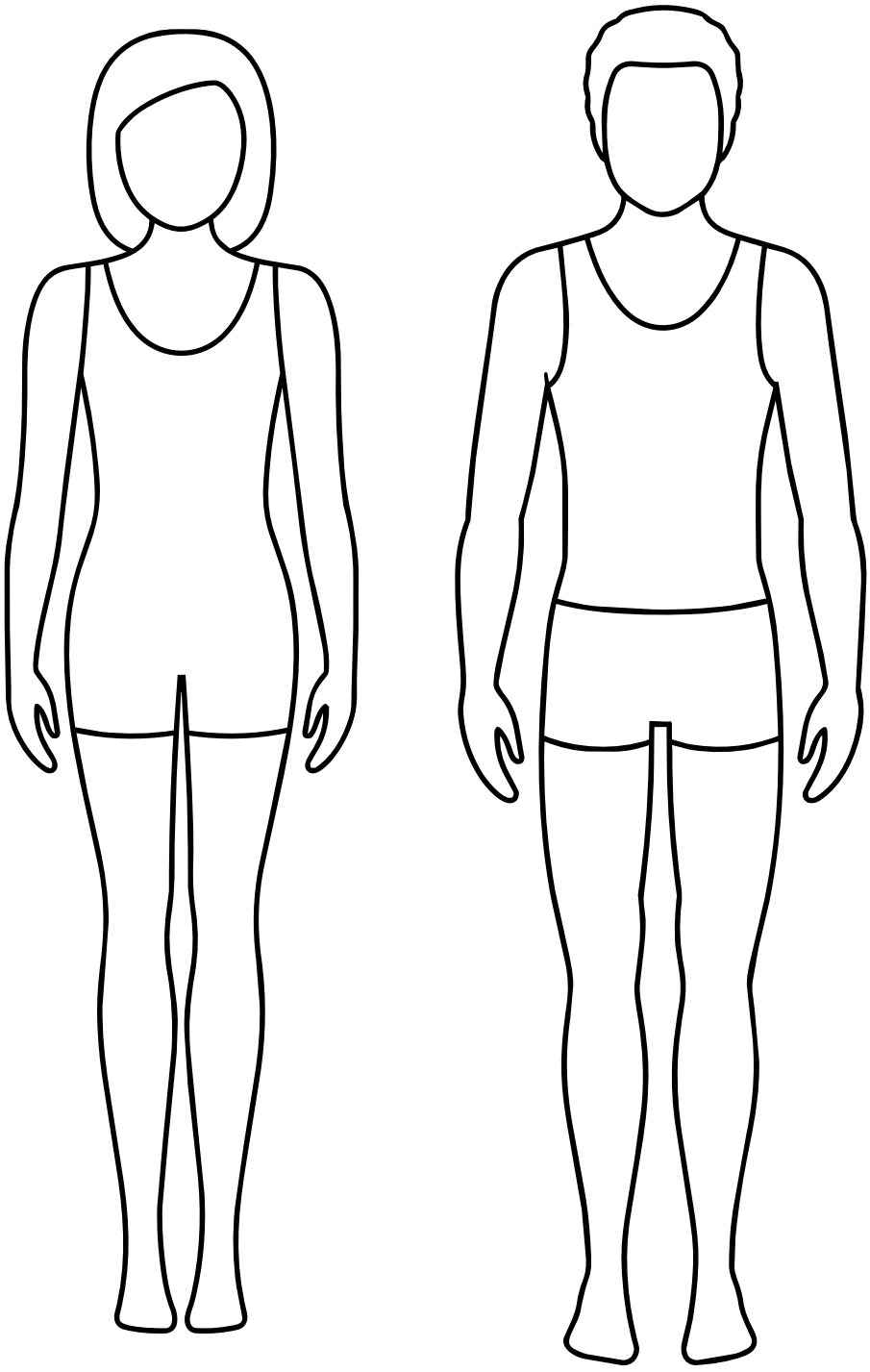
  Se coloca en el mural de los compromisos

"Nuestros hijos necesitan menos juicios y más acompañamiento. La adolescencia es el puente hacia su vida adulta: cruzarlo juntos es el mayor regalo que podemos darles"

Recursos

Recurso 1

SILUETAS DE ADOLESCENTES



Eje 3

Comprendiendo las dimensiones de la sexualidad para saber orientar a nuestros hijos adolescentes



Competencia: Reconoce la sexualidad como una dimensión integral de la vida, relacionándola con su contexto sociocultural y promoviendo una vivencia de la sexualidad basada en el respeto y la información científica.

CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN
Comprende la sexualidad como dimensión integral de la vida y cómo se relaciona con otros aspectos del contexto socio cultural.	■ Sexualidad como dimensión integral (biológica, psicológica, social y ética) y cómo se relaciona con otros aspectos del contexto sociocultural.	**4** "Mirando de manera integral la sexualidad"
Analiza críticamente los mitos y creencias sobre la sexualidad, promoviendo una educación sexual.	■ Derribando mitos y creencias sobre la sexualidad y la educación sexual.	**5** "Mitos y verdades sobre la sexualidad e importancia de educar en este ámbito desde el hogar".
Comprende la importancia de la educación sexual.	■ Importancia de la educación sexual desde el hogar.	

Sesión 4

Mirando de manera integral la sexualidad



I. LO QUÉ DEBEMOS SABER

1.1. SEXUALIDAD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "La sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de toda la vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se expresa y se vive a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales".[24]

En otras palabras, la sexualidad no se reduce al acto sexual ni a la reproducción. Es parte de lo que las personas son, de cómo sienten, cómo se relacionan y cómo dan y reciben afecto. A lo largo de la vida, la sexualidad se transforma y se expresa de distintas maneras según la edad, las experiencias y el contexto.

> La sexualidad es una dimensión central de la persona, ya que integra lo que somos, lo que queremos y cómo actuamos o nos relacionamos con los demás. Esta incluye diferentes aspectos clave para nuestra vida, como el conocimiento y relación con nuestro cuerpo, los lazos afectivos y la intimidad, el sexo, identidades y roles de género, la orientación sexual, el placer y la reproducción (UNPFA, 2023).

1.2. DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD[25]

La sexualidad tiene dimensiones biológica, psicológica y socio-culturale que están estrechamente relacionadas y que interactúan de manera dinámica. Todas son importantes para lograr la realización plena de la persona y una vida social en armonía.



24 OMS, Defining Sexual Health, 2002; actualizado en la web de WHO, 2021.
25 OMS, Defining Sexual Health, 2002; actualizado en la web de WHO, 2021.

A. Dimensión biológica

Se relaciona con el funcionamiento del cuerpo y los procesos físicos que hacen posible la reproducción y la respuesta sexual. Incluye:

- Las características sexuales: órganos sexuales, hormonas, genes, desarrollo corporal.
- Los cambios biológicos a lo largo de la vida: infancia, pubertad, adultez y envejecimiento.
- Las funciones reproductivas: fertilidad, embarazo.
- La respuesta sexual humana, que incluye el deseo, la excitación y el placer.

B. Dimensión psicológica

La forma en que cada persona vive, siente y piensa su sexualidad es única e incluye aspectos como la identidad, la autoestima, los deseos, las emociones y las experiencias afectivas. Para comprenderla mejor, se distinguen tres componentes principales:

a. **Componente cognitivo:** Se refiere al conocimiento y comprensión de la sexualidad. Implica conocer el propio cuerpo y sus cambios, reflexionar sobre valores y creencias, distinguir entre mitos e información basada en evidencia y tomar decisiones informadas y responsables sobre la vida afectiva y sexual.

b. **Componente afectivo:** Tiene que ver con la forma de sentir, expresar y compartir afecto. Incluye cómo se establecen los vínculos emocionales, cómo se manejan las emociones y cómo se construyen relaciones basadas en el respeto, la empatía y la confianza.

c. **Componente conductual:** Se relaciona con la forma como las personas expresan y viven su sexualidad. Abarca la forma en que las personas comunican sus deseos, toman decisiones sobre su cuerpo y practican su sexualidad.e.

C. Dimensión sociocultural de la sexualidad

Esta dimensión se refiere a cómo el entorno influye en la manera en que cada persona entiende, expresa y vive su sexualidad. Factores como la familia, los amigos, la escuela, la religión, los medios de comunicación y las normas sociales moldean nuestras ideas y actitudes sobre el tema.

Cada cultura establece valores, creencias y reglas que orientan —y a veces limitan— los comportamientos sexuales y los roles de hombres y mujeres. Incluye:

- **Normas sociales y culturales** que determinan lo que se considera adecuado en el comportamiento sexual y los roles de género.
- **Creencias religiosas** que influyen en las actitudes hacia la sexualidad.
- **Leyes, derechos y políticas públicas** que pueden proteger o restringir su libre expresión.
- **El entorno familiar, educativo y mediático,** que enseña, refuerza o cuestiona las formas de vivir la sexualidad.

Por ejemplo, **los mitos y tabúes**, que son ideas muy arraigadas en la cultura que influyen en cómo se entiende la sexualidad. Los **mitos** son creencias erróneas, sin



base científica, que se transmiten de generación en generación, como pensar que "la primera vez no hay riesgo de embarazo" o que "los varones tienen más deseo sexual que las mujeres".

Los **tabúes** son temas considerados "prohibidos" o incómodos, como la masturbación o la orientación sexual, que limitan el diálogo y el aprendizaje.

Hoy en día, los **medios de comunicación y las redes sociales** también influyen fuertemente en la vivencia de la sexualidad. Si bien pueden aportar información valiosa sobre salud y derechos sexuales, también difunden estereotipos, desinformación y modelos de sexualidad poco saludables.

Es clave resaltar que estas dimensiones no operan de forma aislada ya que lo que vive una persona en lo biológico interactúa con lo psicológico y lo sociocultural. Por ejemplo, una adolescente frente a sus cambios físicos (biológico) puede sentirse insegura (psicológico) no solo por su nueva imagen sino por las miradas o frases que puede recibir en las calles (sociocultural).

1.3. ACLARANDO MITOS Y CREENCIAS SOBRE SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL.

Los mitos y creencias sobre la sexualidad surgen cuando falta información clara y confiable. Aunque la sexualidad es una parte natural de la salud y el bienestar, muchas veces se evita hablar del tema por vergüenza o por considerarlo inapropiado. Este silencio lleva a que niños, niñas y adolescentes busquen respuestas en fuentes poco seguras, donde suelen encontrar información errónea.

La ausencia de una educación sexual en la escuela y el hogar refuerza ideas falsas, como creer que hablar de sexualidad "promueve" relaciones tempranas. En realidad, ocurre lo contrario: cuando los adolescentes reciben información veraz, pueden tomar decisiones más responsables y cuidar mejor de sí mismos.

En el Perú persisten muchos mitos, como pensar que la educación sexual influye en la identidad de género, lo cual es completamente falso. Estas creencias generan miedo, confusión y rechazo hacia la educación sexual.

Por eso, es fundamental que madres y padres reflexionen sobre sus propias creencias, se informen y conversen abiertamente con sus hijos, sin juicios ni tabúes. Cuando la familia se convierte en un espacio de diálogo y confianza, los mitos pierden fuerza y los adolescentes crecen con conocimiento, seguridad y respeto hacia sí mismos y hacia los demás.

En la tabla 1 se presentan algunos mitos, los cuales es necesario aclarar.

Tabla 1. MITO Y REALIDAD SOBRE SEXUALIDAD Y LA EDUCACION SEXUAL

MITO	REALIDAD
"Está irritable, seguro que está con su regla".	Los cambios hormonales pueden influir en el ánimo, pero las emociones no son exageradas ni irracionales. Escucharlas y atenderlas ayuda a comprender mejor lo que necesitan las chicas.
"La primera vez no pasa nada".	Esto es falso. Sin protección, puede ocurrir un embarazo o una ITS incluso en la primera relación sexual.
"Los varones son fuertes y valientes".	Este estereotipo limita a los hombres. También pueden expresar ternura, pedir ayuda y mostrar sus emociones.
"Si eyaculas fuera no hay embarazo".	El método del retiro no es seguro. No evita el embarazo ni protege de las ITS.
"El condón resta placer a las relaciones sexuales".	El placer no depende del condón. Usarlo protege del embarazo y las ITS, y brinda tranquilidad a la pareja.
"Las mujeres deben ocuparse de las tareas del hogar".	Las tareas del hogar son responsabilidad compartida. Hombres y mujeres deben asumirlas por igual.
"La menstruación limita la capacidad de las mujeres".	Las mujeres pueden realizar sus actividades con normalidad. Lo que limita son los estigmas, el dolor no tratado o la falta de insumos menstruales.
"Las ITS solo afectan a las personas promiscuas".	Cualquier persona sexualmente activa puede contraer una ITS si no se protege adecuadamente.
"Los hombres a quienes no les gustan las mujeres son raros".	La homosexualidad no es una enfermedad, y el respeto es fundamental.
"Por su naturaleza, los hombres no pueden controlar sus deseos sexuales".	Sí pueden hacerlo. Controlar el deseo es parte del respeto y la responsabilidad en las relaciones.
"Las mujeres cuando dicen no, quieren decir que sí".	Falso. "No" siempre significa "no". Ignorarlo es una forma de violencia.

1.4. LA IMPORTANCIA DE EDUCAR EN SEXUALIDAD DESDE EL HOGAR

La sexualidad se desarrolla a lo largo de toda la vida y es esencial para el bienestar integral, por ello, su educación es fundamental. La escuela cumple un rol formal en esta tarea, pero la educación sexual también ocurre de forma cotidiana en el hogar, entre amigos y a través de los medios de comunicación y la tecnología.

Niños y adolescentes reciben mucha información sobre sexualidad, aunque no siempre es correcta. Por eso, necesitan orientación, espacios de diálogo y acompañamiento seguro que solo la familia puede ofrecer. Es en el hogar donde se aprenden valores, respeto y autocuidado, pilares para construir una sexualidad sana y responsable.

Padres, madres y cuidadores tienen un papel clave: acompañar, guiar y fortalecer la autonomía progresiva de sus hijos para que tomen decisiones responsables y construyan su proyecto de vida. Aunque muchos adultos se sientan inseguros o poco preparados para hablar del tema, no necesitan ser expertos; basta con escuchar con atención, responder con honestidad y mantener una comunicación abierta y respetuosa.

A continuación, encontrará información de interés para ayudar a los padres y a las madres a comprender su rol y la importancia de la educación sexual desde el hogar.

Responder a las siguientes preguntas podría ayudar a los padres y madres a comprender **la importancia de su rol en la Educación Sexual.**

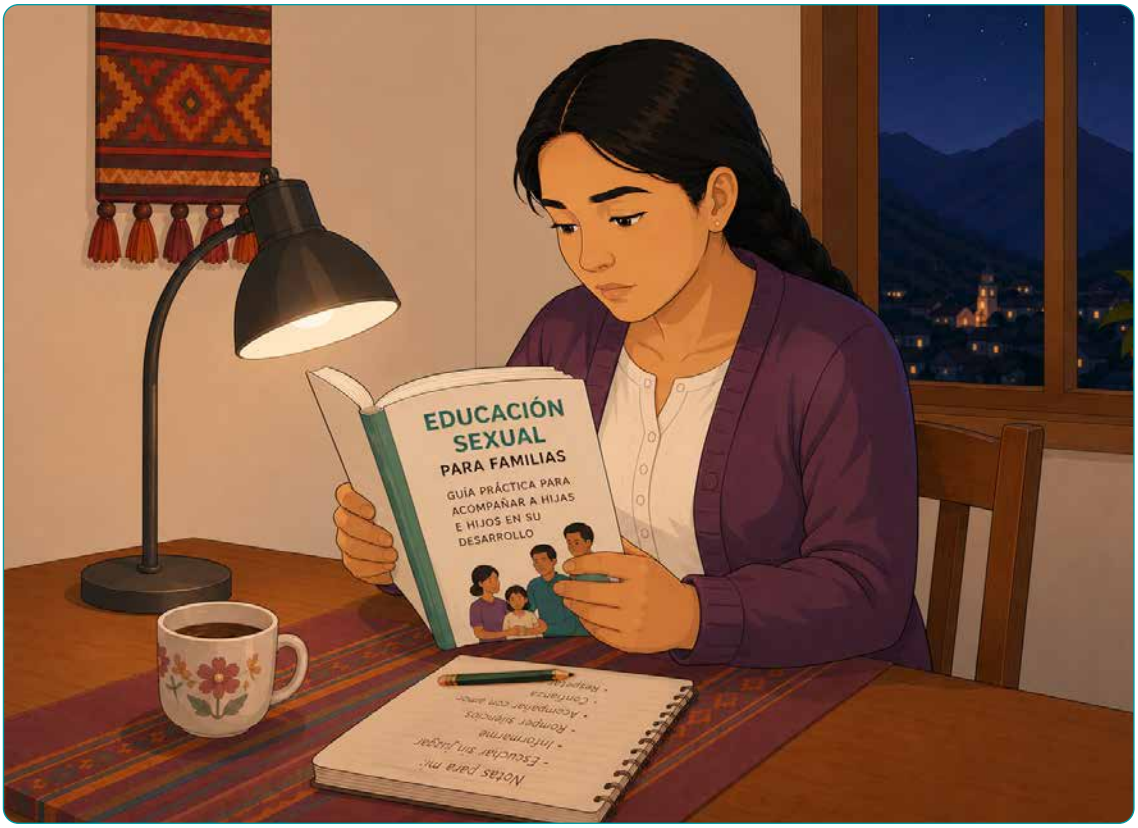
¿Realmente me corresponde educar en sexualidad? Sí. Tu rol es fundamental porque ofreces el contexto emocional y los valores que la información de internet no puede dar.

¿Estoy preparado para educar en sexualidad? Quizás no al 100%, pero tienes la experiencia y tienes valores. Además, ¡la preparación es un proceso! Se trata de aprender junto a tu hijo, reconocer que no lo sabes todo y estar dispuesto a hablar desde la honestidad y la confianza.

¿Por qué debo preocuparme de la educación sexual? Porque si tú no lo haces alguien más lo hará. Y tú eres quien verdaderamente lo ama y quieres su bienestar.

¿Qué riesgos corren mis hijos adolescentes con relación a la sexualidad? La adolescencia es una de las etapas más hermosas de la vida, pero también una de las más vulnerables, aun no se tiene la madurez total para medir las consecuencias y deben enfrentarse a decisiones relacionadas a la sexualidad, corren riesgos al no estar acompañados por adultos bien intencionados en sus vivencias acerca de la sexualidad.

¿Cómo me preparo para educar en sexualidad a mi hijo? La clave está en la **introspección** y la **acción.** Reflexiona sobre tus propias creencias y miedos. Luego, busca información confiable, establece un diálogo abierto con tu hijo y prepárate para abordar temas como la masturbación, el enamoramiento, el embarazo, la violencia sexual y el acoso. No se trata de dar una charla, sino de estar presente y disponible para escuchar. Pero, sobre todo, ser ejemplo para los hijos de una vida sexual saludable.



Algunas razones por las que la educación sexual desde el hogar es especialmente importante son:

Prevención temprana: Hablar sobre sexualidad desde edades tempranas ayuda a construir bases de confianza, reduce mitos, mitiga el impacto de información errónea o de fuentes poco confiables.

Desarrollo emocional y social: El diálogo en el hogar favorece la autoestima, conciencia corporal, respeto por el otro, comprensión de los cambios propios, gestión de emociones, etc. Toma de decisiones informadas: Cuando hay información clara y sin tabúes, los adolescentes pueden tomar decisiones responsables respecto de su sexualidad, salud, relaciones interpersonales, métodos anticonceptivos, etc.

Prevención de riesgos: Evitar embarazos no deseados en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, abuso sexual, violencia basada en género. El hogar aporta un entorno protector si se sabe cómo hablar del tema.

Respeto de derechos y autonomía: Enseñar que cada persona tiene derechos sexuales y reproductivos, que merece respeto, que tiene autonomía, ayuda a formar ciudadanos que valoren el consentimiento, la igualdad, la diversidad.

Complemento de la educación formal: La educación sexual en la escuela es importante, pero el hogar amplía, refuerza y personaliza ese aprendizaje.

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



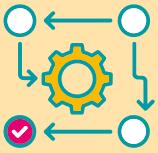
OBJETIVOS:
Comprender la sexualidad en su dimensión integral y su relación con otros aspectos del contexto socio cultural, así como el rol de los padres y de las madres de familia en la educación sexual.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Papelógrafo
- Plumones
- Cinta adhesiva
- Tarjetas ½ A4
- Recurso N° 1: Cuadro componentes de la sexualidad
- Recurso N° 2: Comprendiendo la influencia de los aspectos socio culturales
- "Mural de los compromisos" Elaborado en papelógrafo



SECUENCIA METODOLÓGICA

A tener en cuenta:

Esta sesión contiene ejercicios escritos. Si algún participante no supiera escribir, ofrézcale ayuda, escriba por él y facilite para que responda verbalmente. "Yo me comprometo a …"

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el objetivo y los temas que abordarán en la sesión, resaltando que las actividades requieren su participación activa para enriquecer el diálogo y el aprendizaje.

Actividad 1. "El túnel del tiempo" (20 minutos)

Explique que para esta actividad necesitan pasar por "el túnel del tiempo" y ubicarse cuando eran adolescentes. Deben imaginar que son adolescentes de 13, 14, 15 o 16 años.

Indique que se recuerden a sí mismos a esa edad, ¿Cómo vivían su sexualidad, qué sentían, con quien hablaban de sexualidad?, enfatice que no hay respuestas buenas ni malas.

Solicite voluntarios que quieran compartir sus recuerdos y cómo se sintieron.

Escuche con atención, comente y agradezca la participación.

A continuación, formule la pregunta: hoy que eres adulto ¿con qué palabra relacionas la sexualidad?

Reparta tarjetas y plumones para que respondan a la pregunta.

Luego, solicite que coloquen sus tarjetas en el papelógrafo previsto para esta actividad.

Explique que los hombres colocarán sus tarjetas en la parte izquierda del papelógrafo y las mujeres en la derecha.

ADAPTACIÓN

Una variante es hacer que respondan de manera oral la pregunta. ¿con qué palabra relacionan la sexualidad en la adolescencia?

Proceda a leer las respuestas y si hay palabras iguales o repetidas se superponen.

Pregunte:

- Las palabras de los varones ¿a que se refieren?
- ¿Las palabras de las mujeres?
- ¿Las palabras de los varones se parecen a la de las mujeres?

Explique que todo lo que han dicho está relacionado con la sexualidad, en sus diferentes aspectos.

Señale que en la sesión hablarán sobre los diferentes aspectos o componentes de la sexualidad. Y lo harán con un ejercicio.

DESARROLLO:

Actividad 2. Tríada (25 minutos) [26]

Forme 3 grupos.

Entregue a cada grupo:

- Un juego de tarjetas que contienen palabras relacionadas a cada uno de los aspectos de la sexualidad: biológico, psicológico y sociocultural (Recurso 1) y
- Un juego de tres carteles con las palabras biológico, psicológico y socio-cultural.

Señale que esas palabras pertenecen a una de esas tres categorías o aspectos.

El ejercicio consiste en que ellos deben decidir a cuál de ellas pertenece.

26 Adaptada de Guía metodológica para el desarrollo de talleres educativos de salud sexual dirigidos a adolescentes en espacios comunitarios (2025)

Solicite que agrupen las palabras que se les ha entregado, buscando semejanzas entre ellas y las coloquen debajo del cartel al que consideran que pertenece.

Una vez las palabras hayan sido agrupadas las pegarán en un papelógrafo y el grupo que lo desee puede explicar su trabajo.

Luego de escucharlos complemente:

ADAPTACIÓN

Una variante es presentar un juego de dibujos o imágenes de los diferentes aspectos de la sexualidad y pedir que los agrupen por similitud.

IDEAS FUERZA



- ✔ ***La sexualidad no solo se refiere a las partes genitales (biológico), también se refiere a nuestros sentimientos y afectos (psicológico) y a nuestra forma de relacionarnos como hombres y mujeres. (social)***
- ✔ ***La sexualidad se expresa de diferente forma a lo largo de la vida, y se educa en la familia, en la escuela, la comunidad y en las redes sociales.***
- ✔ ***Los padres, madres y cuidadores tenemos un rol muy importante en la educación sexual de nuestros hijos.***

Evite detenerse en explicar si la palabra pertenece o no a una u otra categoría, lo importante de esta actividad es que los participantes reconozcan que la sexualidad tiene diferentes dimensiones: biológico, psicológico y social.

Explique que seguirán dialogando sobre los diferentes aspectos de la sexualidad y que lo harán reflexionando sobre algunos casos.

Actividad 3. Comprendiendo la sexualidad (20 minutos)

Entregue a los grupos copia de los casos que aparecen en el Recurso No2, para que los lean en el grupo y respondan a las preguntas.

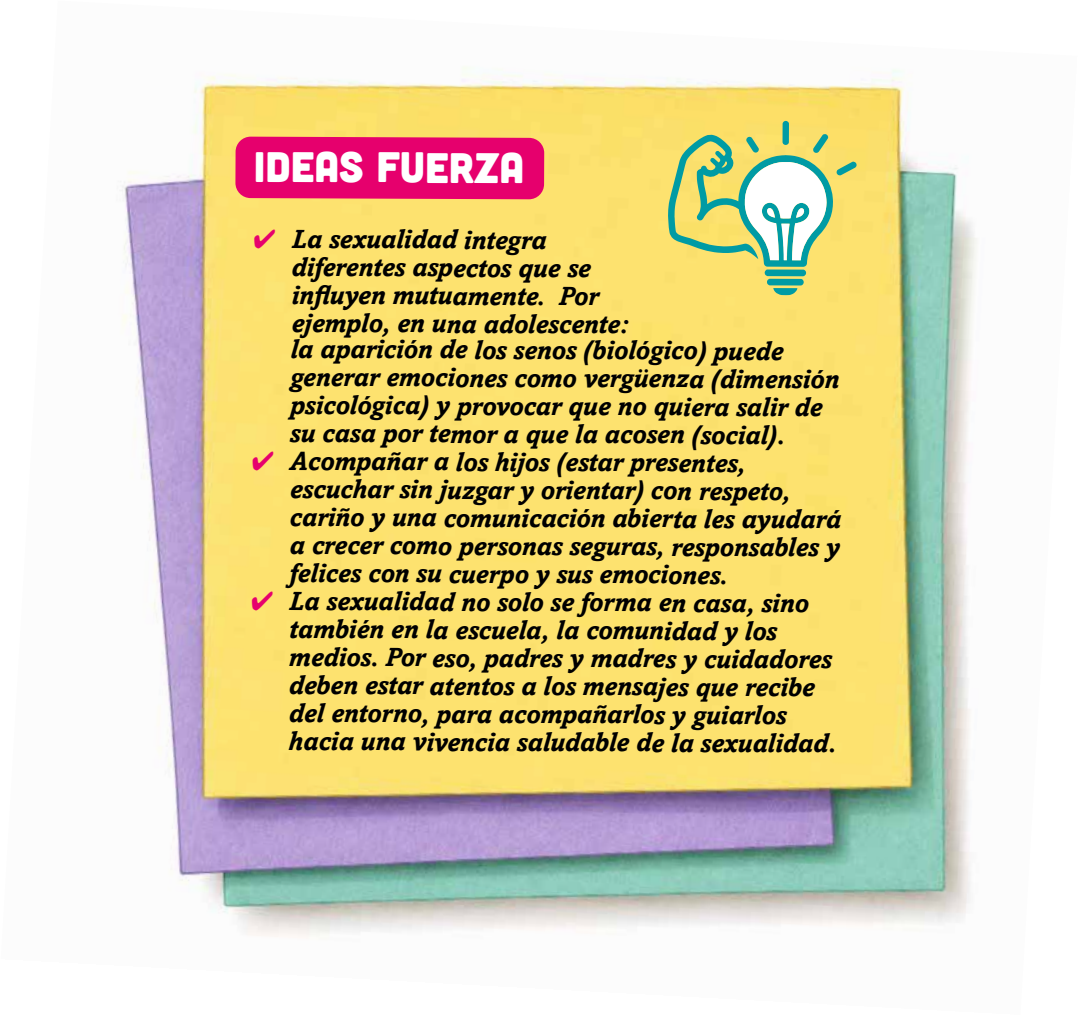
Señale que en el grupo todos deben dar su opinión. Luego en plenaria, el representante que elijan dará sus respuestas.

ADAPTACIÓN

El co facilitador puede leer los casos y los participantes responder a las preguntas oralmente.

Este atento a las respuestas de los padres y madres de familia, y de ser necesario re pregunte para asegurar que se cumpla el objetivo de la reflexión; que los padres comprendan las diferentes dimensiones de la sexualidad y la influencia del entorno sociocultural. Así mismo, esté atento a las respuestas concretas sobre lo que pueden decir para orientar o guiar a su adolescente en una situación similar.

Agradezca y felicite la participación y a continuación, complemente con algunas ideas, como:



Invíteles a cerrar la sesión con la siguiente actividad de compromiso.

Actividad 4. "Luces, cámara, acción" (20 minutos)

- **Aplicación práctica de lo aprendido:** Formando tres grupos, los participantes preparan una pequeña dramatización en la cual explican con sus propias palabras a su vecina que es lo que han aprendido de sexualidad y los factores que influyen en ella.

- **Compromiso individual:** Cada participante escribe en una tarjeta un compromiso personal relacionado con el tema. Por ejemplo, se puede comprometer a "hablar con mis hijos sin temor", "recordar que la sexualidad es mucho más que solo el sexo". Se concluye colocando las tarjetas en el "Mural de los compromisos"

Madres y padres influyen positivamente en la sexualidad de sus hijos cuando promueven el cuidado del cuerpo y hábitos saludables (**dimensión biológica**), fortalecen la autoestima y la expresión de emociones (**dimensión psicológica**), y modelan relaciones basadas en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres (**dimensión social**).



Recursos

Recurso 1

COMPONENTES DE LA SEXUALIDAD

BIOLÓGICA	PSICOLÓGICA	SOCIO-CULTURAL
Pene	Identidad sexual	Roles de género
Vagina	Orientación sexual	Estereotipos de género
Sistema reproductor	Enamoramiento	Mitos y creencias
Primera menstruación	Autoestima	Valores
Primera eyaculación	Pensamientos, sentimientos y emociones	Familia
Sexo	Conocimientos	Amigos
Procreación	Placer sexual	Iglesias
Hormonas	Femineidad	Medios de comunicación
Excitación sexual	Masculinidad	

Recurso 2

COMPRENDIENDO LA INFLUENCIA DE ASPECTOS SOCIO CULTURALES

Caso 1 "Joel y sus amigos" (15 años)



Joel, vive en Pucallpa, es buen estudiante y tiene un grupo de amigos con el que comparte el recreo. Sus amigos suelen hablar de mujeres y sobre que ya es momento de tener relaciones coitales. Joel piensa que, si no hace lo que sus amigos le dicen, lo van a considerar "poco hombre". Por ello, la semana pasada se acostó con una chica que no conocía y no uso condón.

- ¿Qué está pasando con Joel?
- ¿Qué está pasando con su grupo? ¿cómo le afecta?
- Si fueras el padre o madre de Joel, ¿cómo le ayudarías?

Caso 2 "Alex y los mitos" (16 años)



Alex fue de vacaciones a visitar a sus tíos que viven en Piura, después del almuerzo, los tíos se pusieron a hablar, decían que "en una relación de pareja, es el hombre quien debe tomar la iniciativa de las relaciones coitales, y es el hombre quien toma todas las decisiones, solo así la relación marcha bien". Alex tiene enamorada, él no le ha propuesto tener relaciones, y ha respetado que ella quiera esperar hasta que terminen sus estudios, pero al escuchar a sus tíos se cuestiona si él está cumpliendo bien su rol de hombre. En su último encuentro, Alex ha querido ir más allá de las caricias con su enamorada.

- ¿Qué está pasando con Alex? ¿Por qué?
- Si fueras el padre o madre de Alex ¿qué le dirías?

Caso 3 "María y la influencia de redes sociales" (14 años)

María pasa varias horas en redes sociales siguiendo a "influencers"; chicas bonitas y con cuerpos perfectos. María, no le gusta su físico, ni su cara ni su cuerpo, pero como sus amigas suben sus fotos a las redes sociales, ella también se animó a publicar fotos suyas. María recibió burlas y comentarios negativos y ahora se siente muy mal.



- ¿Qué está pasando con María?
- ¿Qué cosa la está afectando?
- Si fueras padre o madre de María ¿qué le dirías?

Caso 4 Caso 4: "Camila y los valores de casa" (17 años)

Camila proviene de una familia muy conocida de la ciudad de Huanta, con creencias religiosas que valoran la abstinencia hasta el matrimonio. Sus amigas se burlan de ella y le dicen que va a ser monja. A Camila las burlas de sus amigas no le importan. Ella ha sido muy sincera con su enamorado y le ha dicho que no quiere tener intimidad, porque primero quiere ingresar a la universidad.



- ¿Cómo se siente Camila?
- ¿Qué está influenciando en la decisión de Camila?
- Si fueras su madre, ¿qué le dirías?

Sesión 5

Mitos y verdades sobre sexualidad e importancia de educar desde el hogar





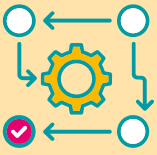
OBJETIVOS:
Analizar los mitos y creencias sobre sexualidad y promover una educación sexual basada en información confiable y valores de respeto.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Hojas.
- Lapiceros.
- Plumones.
- Papeles.
- Papelógrafo.
- Recurso Nº 1 Carteles de acuerdo desacuerdo duda.
- Recurso Nº 2 Mitos y argumentos.
- Recurso Nº 3 Situaciones sobre mitos.
- "Mural de los compromisos" Elaborado en Papelógrafo.



SECUENCIA METODOLÓGICA

A tener en cuenta:

- *En esta sesión se presenta un mito de la amazonia, usted puede elegir otro mito o leyenda similar de su región.*
- *Esta sesión contiene ejercicios escritos, si hay participantes no letrados, solicite que solo respondan verbalmente.*

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el objetivo y los temas que abordarán en la sesión, resaltando que las actividades requieren su participación activa para enriquecer el diálogo y el aprendizaje.

Actividad 1. Dinámica de motivación "Dicen por ahí..." (15 minutos)

Inicie la sesión narrando la leyenda del Yacuruna[27].

*"En la Amazonía peruana se cuenta que existe un ser del agua llamado **Yacuruna**. Dicen que aparece como un hombre muy atractivo, que seduce a las personas y las arrastra a vivir con él en su mundo acuático. Quienes se dejan llevar por él, no vuelven a ser los mismos"*

Pregunte: *¿Alguien había escuchado esta leyenda?*[28] *¿Qué creen que busca enseñar?*

Esta leyenda servía como advertencia para hablar de los peligros de la seducción sin control, de los deseos ocultos y de las relaciones entre un hombre y mujer que pueden traer consecuencias.

Pregunte: *¿Ustedes conocen otras leyendas?*

Solicite que cada padre/madre escriba en un papel o que recuerde:

- Una leyenda sobre sexualidad.
- ¿Qué sintió cuando le escuchó? (ej. miedo, vergüenza, silencio).
- ¿Cree que esa leyenda tiene algo de verdad?
- ¿Le contaría esa leyenda a su hijo(a)? ¿por qué?

Solicite voluntarios para que compartan sus respuestas.

Agradezca los comentarios y mencione que, así como existen leyendas que buscan transmitir enseñanzas, también existen otras creencias llamadas mitos que afirman algo, pero que no son verdad.

Por ejemplo, el mito de que, si una chica está con la menstruación, y carga un bebé, a este le dará cólico. O el mito de que si un adolescente toca sus genitales le saldrán pelos en las manos.

Diga que no existe ninguna razón científica para que una chica que esté con su regla ocasione cólico a un bebé, tampoco que aparecen vellos por tocar los genitales.

Señale que en la sesión dialogarán acerca de algunos mitos sobre la sexualidad y cómo estas creencias influyen en la forma como nuestros hijos viven su sexualidad.

27 El Yacuruna es una criatura mítica y una figura central en las leyendas de la Amazonía, lo que lo convierte tanto en un mito como en una leyenda.
28 Una leyenda es una narración que se transmite de forma oral o escrita, mezclando elementos reales con elementos imaginarios; El objetivo es transmitir valores y tradiciones de una comunidad.

DESARROLLO:

Actividad 2. Aclarando lo que pienso, creo y siento (25 minutos)

A continuación, coloque los carteles **"De acuerdo - desacuerdo - duda"** (Recurso 1) en diferentes partes del salón.

Explique que Usted irá leyendo una serie de frases sobre la sexualidad, ellos deben escuchar y pensar si están de acuerdo o no con la frase, o si la frase le genera duda.

Señale que en este ejercicio no hay respuesta correcta o incorrecta, todo lo que piensen estará bien.

Diga que antes de decidir si está de acuerdo o no con la frase, se aseguren de haberla entendido bien. Si no la entienden pueden levantar la mano y solicitar explicación.

Solicite al grupo de participantes se ubiquen al centro del salón.

Explique que irá leyendo diferentes creencias (Recurso Nº 2. Mitos).

Tras la lectura de cada creencia, deben ubicarse en algunos de los 3 carteles, según su decisión personal.

Luego, de manera respetuosa y en tono amable, sin que suene a cuestionamiento, pregunte dirigiéndose a uno de los grupos formados "¿quién quiere contar el por qué está de acuerdo? … ¿…en desacuerdo? o ¿tiene dudas?

Mantenga el diálogo con base a las respuestas de los participantes y complemente con los argumentos que aparecen en el Recurso Nº 2.

Al finalizar el ejercicio agradezca la participación y dirija una reflexión grupal final, con las siguientes preguntas:

- ¿Por qué es importante hablar sobre los mitos o las creencias falsas acerca de la sexualidad?
- ¿Qué se debe hacer o cómo se debe responder cuando se escucha algún mito?

Después de escucharlos, señale que las creencias falsas influyen en nuestra forma de entender la sexualidad y en cómo las personas nos relacionamos con los demás.

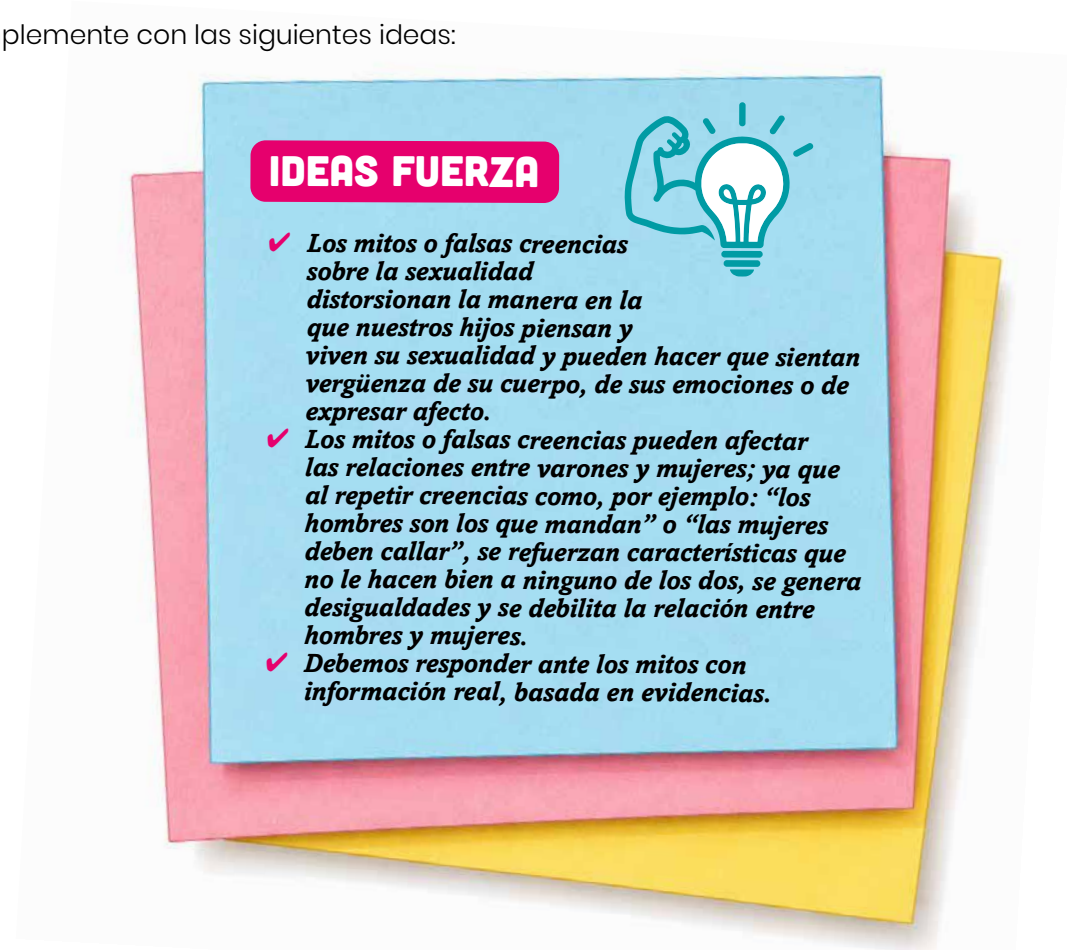
ADAPTACIÓN

En poblaciones menos acostumbradas a participar, una variante es presentar los mitos en una ficha de trabajo para marcar. Si algún participante no sabe leer, el co-facilitador/a le puede ofrecer ayuda.

Otra variante, es mantener al grupo sentado y en circulo, leer los enunciados uno a uno y pedirles que expresen su opinión individual con tarjetas de colores: de color rosado si está en desacuerdo, verde si está de acuerdo y naranja si tiene dudas.

Otra variante para poblaciones no letradas, es presentar los principales mitos en imágenes.

Complemente con las siguientes ideas:



Señale "A continuación seguiremos reflexionando sobre los mitos o las falsas creencias. Esta vez analizando algunos casos de la vida diaria con nuestros adolescentes"

Actividad 3. ¿Qué harías sí? (20 minutos)

Forme 4 grupos y entregue una copia de las situaciones que se encuentran en el recurso Nº 3.

Explique que deben leer, conversar en sus grupos sobre la situación presentada y decir qué hacer en cada uno de los casos.

Explique que es importante que cada padre o madre de su opinión, y que lleguen a acuerdos sobre sus respuestas. Pero, si no llegaran a ponerse de acuerdo, también está bien.

Se procede a plenaria.

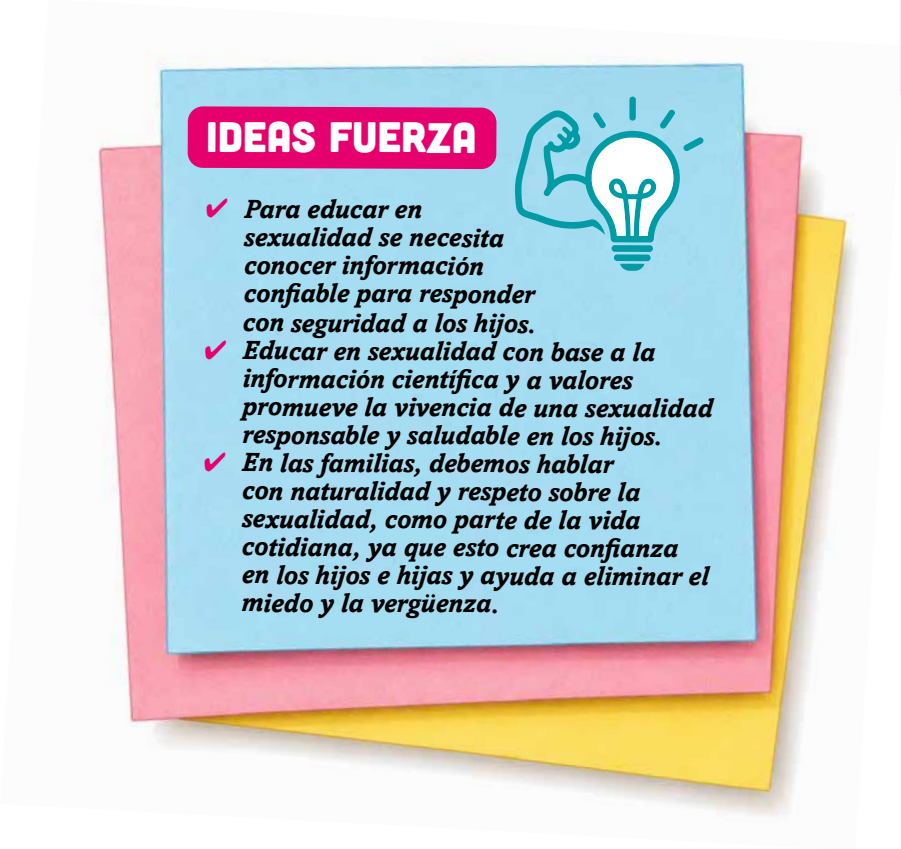
Esté atento a las respuestas de los padres y madres de familia, y de ser necesario re pregunte para asegurar que se cumpla el objetivo de la reflexión; que los padres den respuestas concretas sobre cada situación presentada y que la orientación o guía que brinden este en el sentido que se espera.

Luego de la intervención de todos los grupos, felicite y pregunte **¿Por qué es importante la educación sexual desde el hogar?, ¿Qué necesito para educar en sexualidad a mi hijo?**

Escriba en un papelógrafo o refuerce verbalmente las ideas que vayan brindando los padres y madres y complemente con lo siguiente.

ADAPTACIÓN

Cada situación puede ser presentada mediante imagen alusiva, mientras se va narrando la situación.



Invite al cierre de la sesión con la siguiente actividad.

CIERRE:

Actividad 4. ¡Eureka! (10 minutos)

Aplicación práctica: En grupos los padres y madres

- Eligen un mito sobre sexualidad y elaboran argumentos para contrarrestarlos

Compromiso personal:

- Cada participante escribe su compromiso personal y lo pega en el mural de los compromisos.

Hablar de sexualidad con la verdad y con respeto protege a nuestros hijos. Al aclarar los mitos y creencias erróneas, les damos herramientas para vivir su sexualidad con confianza, responsabilidad y bienestar.

Recursos

Recurso 1

CARTELES DE ACUERDO, DESACUERDO Y DUDA



DE ACUERDO



DESACUERDO



DUDA

Recurso 2

MITOS Y ARGUMENTOS "DE ACUERDO, DESACUERDO Y DUDAS SOBRE SEXUALIDAD"

MITOS	ARGUMENTO EDUCATIVO PARA PADRES Y MADRES
La educación sexual influye para que los adolescentes tengan relaciones coitales	En realidad, contribuye a retrasar el inicio sexual y promueve decisiones responsables.
La Educación Sexual habla de anticonceptivos y promueve la promiscuidad entre nuestros hijos.	No es verdad. La educación sexual también habla del afecto, de relaciones de igualdad, de los valores, la autoestima, toma de decisiones y brinda conocimientos para tomar decisiones acertadas sobre la sexualidad.
La Educación Sexual solo trata de sexo biológico y la reproducción.	Incluye derechos, género, respeto, emociones, enamoramiento y a aprender a distinguir relaciones afectivas saludables.
La Educación Sexual no beneficia a nuestros hijos adolescentes	La evidencia demuestra que cuando se brinda educación sexual en los colegios, en el hogar y se cuenta con acceso a servicios de consejería y métodos anticonceptivos para quienes lo requieren, hay reducción de embarazos adolescentes, ITS y violencia.
La Educación Sexual promueve "estilos de vida" LGBTQIA+ entre nuestros hijos adolescentes	La Educación Sexual no promueve ni hace campaña a favor de ningún «estilo de vida» en particular. Promueve el bienestar de todos y el respeto a los derechos de todas las personas sin excepción.
"El varón no puede controlar su deseo sexual"	Los varones sí pueden controlar sus impulsos. Educar en el respeto y la responsabilidad es clave para prevenir la violencia sexual.
"Una vez que los adolescentes inician caricias sexuales es imposible que se detengan".	Las caricias generan excitación, pero con autocontrol y comunicación se pueden establecer límites saludables.
"Un hombre que hace tareas domésticas es menos hombre (saco largo)".	Cuidar y compartir tareas del hogar es parte de la responsabilidad familiar y fortalece los vínculos.

MITOS	ARGUMENTO EDUCATIVO PARA PADRES Y MADRES
"Hablar de diversidad sexual en la escuela promueve la homosexualidad".	Educar en diversidad fomenta el respeto y previene la discriminación; no influye en la orientación sexual.
"Si la mujer usa métodos anticonceptivos se vuelve promiscua".	Usar métodos anticonceptivos es un acto de responsabilidad y cuidado personal, no un signo de promiscuidad.
"La primera vez que un chico tiene sexo no pasa nada".	Sí pasa. Desde la primera relación sexual sin protección se puede producir un embarazo o transmitir una infección de transmisión sexual (ITS). No hay 'primera vez segura' si no se usan métodos de protección adecuados.
"Una señorita de su casa no habla de sexo".	Hablar de sexualidad no es malo. Es una forma de cuidarse, conocerse y tomar decisiones informadas. Las chicas y los chicos tienen derecho a recibir y hablar de educación sexual.
"Si un chico se masturba le sale pelos en las manos"	Eso es falso. La masturbación no causa daños ni cambios físicos. Es una práctica natural que forma parte del conocimiento del propio cuerpo.
"Si a un chico les gusta jugar vóley es porque es gay".	No existe ningún deporte o actividad que defina la orientación sexual. Los gustos no determinan la identidad ni la orientación sexual de una persona.
"Si estás con la regla no debes bañarte"	Falso. Durante la menstruación se puede y se debe mantener una buena higiene. Bañarse ayuda a sentirse limpia y a prevenir infecciones.
"Los varones solo piensan en sexo".	Es normal, y los padres y madres y las instituciones educativas deberían brindar educación sexual.
"Las mujeres afro peruanas son fogosas"	No existe evidencia que relacione el origen étnico con la forma de vivir la sexualidad. Cada persona es diferente. Repetir este mito promueve prejuicios, discriminación y falta de respeto hacia las mujeres afroperuanas.

Recurso 3

SITUACIONES SOBRE MITOS

SITUACIÓN 1

Tu hija se niega a bañarse durante la regla, porque ha escuchado que hace daño. ¿Qué le dirías?

SITUACIÓN 2

Tu hijo te cuenta que ha escuchado que sus compañeros dicen que la primera vez que tienen relaciones coitales con su enamorada no pasa nada, no embarazas a la chica. ¿Qué le dirías?

SITUACIÓN 3

Tu hijo se niega a colaborar en las tareas de la casa, pues en las casas de sus amigos son las mujeres las que se encargan de cocinar, lavar y planchar ¿Qué le dirías?

SITUACIÓN 4

Tu hija te comenta que su enamorado la ama tanto que la cuida y siempre se pone celoso. ¿Qué le dirías?

Eje 4

Acompañando a nuestros hijos adolescentes en la construccion de vínculos basados en el respeto y la igualdad



Competencia: Reflexiona sobre la violencia basada en género y la importancia de prevenirla, acompañando de manera comprensiva el proceso de enamoramiento de sus adolescentes e identificando señales de alerta y cómo y dónde buscar ayuda.

CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN
Reflexiona sobre la violencia basada en género y toma conciencia sobre la importancia de prevenirla.	Comprendiendo qué es la violencia basada en género (VBG): Estereotipos y roles de género, el machismo.	**6** Previniendo la violencia de género, con amor y respeto desde el hogar.
	Consecuencias de la violencia de género en los adolescentes y la importancia de la dinámica familiar en su prevención. (Violencia sexual: tipos)	
Acompaña el proceso de enamoramiento de su hijo adolescente, y conoce cómo actuar frente a señales de alerta de situaciones de violencia.	El enamoramiento como manifestación natural del proceso de desarrollo psicológico y sexual en la adolescencia.	**7** Acompañando a nuestros hijos en el enamoramiento saludable.
	Cómo hablar con nuestros hijos sobre sus propios límites y el respeto a los demás. Consentimiento.	
	Diferencia entre relación de enamoramiento saludable y relación dañina y cómo alertar a nuestros hijos adolescentes.	
Reconoce señales de alerta en las relaciones sociales, el rol de los padres y donde acudir en caso de necesitar ayuda.	Los amigos y su influencia. Señales de alerta en las amistades presenciales (aislamiento, exclusión).	**8** Identificamos riesgos a tiempo.
	Señales de alerta en redes sociales (Ciberacoso, Grooming, Sexting).	
	Rol de los padres y madres y dónde buscar ayuda. - rutas de acceso a orientación y atención integral.	

Sesión 6

Previniendo la violencia de género, con amor y respeto desde el hogar



I. LO QUE DEBO SABER PARA DESARROLLAR LA SESIÓN

1.1. LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)

La violencia basada en género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres también pueden ser blanco de ella[29].

La violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas, la coerción y la manipulación son también formas de violencia de género. La violencia de género puede tomar muchas formas: violencia de pareja, violencia sexual, matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y los supuestos «crímenes de honor"[30].

Las consecuencias de la violencia de género son devastadoras y las repercusiones para quienes logran sobrevivir pueden ser permanentes. De hecho, la violencia de género puede provocar la muerte de una persona.

La violencia contra las mujeres es la forma más frecuente de VBG, y siendo la familia el primer espacio de socialización, donde los hijos aprenden a relacionarse resulta imprescindible reflexionar cuando esta ocurre en el hogar, con miras a resolver esta situación, prevenir su repetición y promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la convivencia libre de violencia, evitando que los hijos reproduzcan estos patrones en su vida futura.

1.2. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES? [31]

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres:

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual.

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra.

29 NNUU (2023) en https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/
30 NNUU (2023) en https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/
31 LEY 30364 (2015) Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

1.3. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?[32]

Se señalan varios factores que explican por qué ocurre la VBG, organizados como factores de riesgo estructurales, sociales, relacionales e individuales.

En la siguiente tabla se presenta estas causas organizadas por categorías.

CATEGORÍA	CAUSAS PRINCIPALES
Estructurales	■ Desigualdad de poder entre hombres y mujeres. ■ Brechas económicas, educativas y políticas.
Culturales / sociales	■ Estereotipos y roles tradicionales que asignan dominio al hombre y sumisión a la mujer. ■ Normalización social de la violencia y su transmisión intergeneracional.
Institucionales	■ Impunidad y débil aplicación de sanciones. ■ Limitaciones en servicios de protección y acceso a justicia.
Relacionales	■ Control, celos, conflictos de pareja y dependencia económica o emocional.
Individuales	■ Creencias que justifican la violencia. ■ Consumo de alcohol o drogas (factor agravante). ■ Baja autoestima, antecedentes de trauma o violencia previa.
Contextuales/ de vulnerabilidad	■ Mayor riesgo en emergencias, desastres o migración. ■ Discriminación hacia mujeres indígenas, rurales, migrantes o con discapacidad.
Prácticas nocivas	■ Matrimonios infantiles o uniones tempranas que perpetúan relaciones desiguales.
Educativas	■ Falta de educación sexual y formación en igualdad y derechos.

1.4. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE PUEDEN DARSE?[33]

Son las siguientes:

- **Violencia física:** cuando se usa la fuerza para dañar el cuerpo de otra persona: golpes, empujones, patadas, jalones, quemaduras o el uso de objetos y armas.
- **Violencia psicológica:** cuando se afectan la autoestima, la seguridad o la estabilidad emocional, a través de insultos, humillaciones, amenazas, control, aislamiento, celos excesivos o manipulación.

32 MIMP (2022) Marco conceptual para la prevención de la violencia de género contra las mujeres.
33 Ley 30364 (2015) Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

- **Violencia sexual:** cuando se obliga a alguien a realizar actos sexuales sin su consentimiento, ya sea por tocamientos, relaciones forzadas, acoso, hostigamiento o explotación.
- **Violencia económica o patrimonial:** cuando se limita el acceso al dinero, a los bienes o a los recursos, impidiendo que la mujer trabaje o estudie, quitándole su dinero, controlando sus ingresos o apropiándose de sus pertenencias.

Todas estas formas de violencia tienen un mismo origen: las creencias erróneas sobre el papel de las mujeres, las relaciones desiguales con los varones y es clave reconocerlas y trabajar desde el hogar para erradicarlas.

1.5. ¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE VIOLENCIA?[34]

Las modalidades de violencia que se pueden dar incluyen:

- La violencia en la relación de pareja,
- El feminicidio,
- La explotación sexual,
- El acoso sexual y
- El acoso virtual.

1.6. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA VBG?

Las principales consecuencias en las mujeres y en los hijos se muestran en la tabla a continuación.

Consecuencias de la Violencia contra las mujeres y sus hijos[35]

DIMENSIÓN / TIPO DE CONSECUENCIA	EN LAS MUJERES	EN HIJOS
Salud física	Lesiones, discapacidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, problemas ginecológicos.	Somatización (dolores, fatiga, malestares sin causa médica), afectación del desarrollo físico por estrés.
Salud mental / emocional	Depresión, ansiedad, miedo, culpa, baja autoestima, aislamiento, estrés postraumático.	Miedo, ansiedad, tristeza, culpa, pesadillas, retraimiento o irritabilidad.
Social / relacional	Aislamiento familiar o social, pérdida de redes de apoyo, dificultad para establecer relaciones saludables.	Problemas para socializar, desconfianza hacia adultos, dificultades en vínculos afectivos. Búsqueda de un espacio de pertenencia, que a veces los expone a grupos violentos o conductas de riesgo.

34 Ley 30364 (2015) Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
35 Adaptado de MIMP, 2017; Programa Nacional Aurora, 2021.

DIMENSIÓN / TIPO DE CONSECUENCIA	EN LAS MUJERES	EN HIJOS
Económica / laboral	Pérdida de empleo, disminución de ingresos, dependencia económica, menor productividad.	Impacto indirecto por empobrecimiento del hogar y reducción de oportunidades educativas.
Educativa / cognitiva	Limitaciones para continuar o acceder a estudios	Dificultades de concentración, bajo rendimiento escolar, ausentismo.
Conductual	Cambios de hábitos, retraimiento, autolesiones o conductas de riesgo.	Conductas agresivas, rebeldía o repetición de modelos violentos observados. Los varones pueden asociar agresión con obtener respeto, mientras que las mujeres pueden naturalizar el control y el maltrato como parte de las relaciones.
Reproductiva	Embarazos no planificados, abortos espontáneos, ITS.	Embarazo producto de la violencia
Intergeneracional	Riesgo de transmitir modelos de sumisión o tolerancia a la violencia.	Reproducción del ciclo de violencia en la vida adulta (como víctimas o agresores).

1.7. ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO: ¿QUÉ SON? Y ¿CÓMO INFLUYEN EN LA VIOLENCIA?

Los roles de género son expectativas sociales que dictan cómo "deberían" comportarse mujeres y hombres. A menudo se escuchan frases como:

- "Los hombres no lloran".
- "Las niñas deben ser delicadas".
- "El varón tiene que ser fuerte".
- "Las mujeres deben obedecer y cuidar del hogar".

Estos roles se van aprendiendo desde la infancia y se repiten de manera casi automática.

Los estereotipos de género son creencias rígidas que reducen a mujeres y hombres a características muy limitadas: por ejemplo, que las mujeres son emocionales y los hombres racionales, o que ellas son mejores para las tareas del hogar mientras ellos destacan en el trabajo.

Estos estereotipos no son reales, pero influyen en las decisiones, en las oportunidades y en la manera en que las personas se relacionan. En el fondo, lo que hacen es crear desigualdad.

Cuando en el hogar se refuerzan estos mensajes, los hijos aprenden que hay cosas "permitidas" solo para algunos y "prohibidas" para otros. Esto no sólo limita sus sueños y su desarrollo, sino que también abre la puerta a relaciones basadas en el control y la falta de respeto que son características que anteceden a la violencia.

1.8. EL MACHISMO: LA RAÍZ DE LA VIOLENCIA

El machismo es un sistema de creencias y actitudes que da más valor a lo masculino que a lo femenino. Es la idea de que el hombre tiene derecho a decidir, mandar y controlar, mientras que la mujer debe obedecer, servir y callar.

El machismo se expresa en frases cotidianas como:

- "Si él te cela, es porque te quiere".
- "El hombre es hombre y necesita más mujeres".
- "La mujer que se viste así busca problemas".
- "La mujer ha sido creada para obedecer"

Pensar así es peligroso, pues en realidad son ideas que justifican la violencia. Cuando se normaliza el machismo, se enseña que el poder se ejerce desde la imposición y no desde el respeto. Así, los varones pueden aprender a ejercer violencia como una forma de "ser hombres", mientras que las mujeres pueden aprender a aguantarla como una "obligación" de ser mujeres.

Los hombres pueden alimentar el machismo cuando repiten conductas aprendidas que les dan más poder o ventajas sobre las mujeres, incluso sin darse cuenta. Esto sucede cuando normalizan el hecho de controlar a las mujeres, imponer sus ideas, dejarles todo el trabajo de la casa o callar frente a la violencia de otros hombres. También lo refuerzan cuando no reflexionan sobre sus propios privilegios o creen que "ser hombre" es actuar con dureza o agresividad. Identificar estas actitudes es clave para cambiarlas y construir relaciones más justas y sin violencia.

Muchas veces son las mujeres, las que sin darse cuenta fomenta ese machismo, al hacer preferencias por los hijos varones, para ellos las mejores presas, o para ellos los permisos para salir todos los fines de semana, sin importar si asea o no su cuarto, mientras que eso "no se puede permitir a una mujercita".

Hombres y mujeres deben reconocer que el machismo no es un problema individual, sino cultural y si hombres y mujeres pusieran de su parte, particularmente desde la familia se podría combatirlo.

Es oportuno recordar que la etapa de adolescencia es una oportunidad para el aprendizaje de cómo relacionarse con los demás y particularmente cómo establecer relaciones afectivas sanas, sabiendo resolver los problemas y las dificultades de manera correcta, sin que nadie resulte maltratado o lastimado. Si en casa hay situaciones de violencia contra la mujer y/o violencia contra los hijos e hijas, los efectos pueden ser graves y duraderos.

1.9. LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN EN EL HOGAR

Es importante recalcar a los padres, madres y cuidadores que lo que los hijos ven en casa será el modelo de relación que seguirán en el futuro y por tanto es importante que puedan enseñarles con el ejemplo.

Las evidencias señalan que haber sufrido maltrato en la infancia, puede afectar la manera en que una persona adulta criará a sus hijos en el futuro. De adulto, puede mostrar conductas de control o de violencia, o tener dificultades para cuidar y manejar sus emociones. Así, los patrones aprendidos en la infancia y las formas inadecuadas de afrontar los conflictos pueden repetirse en la siguiente generación, haciendo que la violencia se reproduzca[36].

Algunas acciones que los padres y las madres pueden hacer son:

- Revisar sus historias personales, y si han vivido algún tipo de violencia, el objetivo es sanar y para ello debe buscar ayuda.
- Revisar creencias sobre el amor, la vida en pareja, los roles de género. El mundo ha cambiado y hoy hombres y mujeres somos capaces de cumplir diversas tareas.
- Revisar mensajes propios: evitar frases que refuercen estereotipos, como "tú no puedes porque eres niña" o "eso no es de hombres" "calladita te ves más bonita" "los machos no lloran"
- Fomentar la corresponsabilidad: enseñar que las tareas del hogar son responsabilidad de todos y todas, sin importar el género.
- Dar la misma oportunidad a hijas e hijos: motivar a las niñas a desarrollar sus talentos en cualquier área, y a los varones a participar en tareas de cuidado.
- Escuchar y dialogar: dar espacio a que hijos expresen lo que piensan y sienten, sin burlas ni juicios.
- Promover el respeto mutuo: establecer normas claras de convivencia donde no se acepten insultos, golpes ni humillaciones.
- Acompañar la adolescencia: mostrar interés por lo que viven, sus amistades, lo que consumen en redes sociales, y hablar abiertamente sobre temas como la igualdad y el respeto.
- Reflexionar en familia: ver películas, leer historias o comentar noticias que les permita cuestionar los estereotipos de género.
- Dar ejemplo: mostrar con acciones cómo resolver conflictos de manera pacífica y dialogada.
- Reconocer los errores: si alguna vez levantan la voz o usan un comentario machista, pedir disculpas enseña mucho más que ocultar el error.
- Buscar apoyo cuando sea necesario: si identifican situaciones de violencia en casa, recordar que no están solos. El MIMP y el MINSA ofrecen líneas de ayuda y servicios especializados.

Como padres y madres, tienen un papel fundamental en la prevención de la VBG y contra cualquier miembro de la familia. No se trata solo de proteger a los hijos de experiencias dolorosas, sino de darles la oportunidad de crecer en un hogar donde aprendan a valorar la igualdad, el respeto y el amor.

36 Greene CA, Haisley L, Wallace C, Ford JD. Intergenerational effects of childhood maltreatment: A systematic review of the parenting practices of adult survivors of childhood abuse, neglect, and violence. Clin Psychol Rev. 2020 Aug;80:101891. doi: 10.1016/j.cpr.2020.101891. Epub 2020 Jul 23. PMID: 32745835; PMCID: PMC7476782.

Dar ejemplo es la forma más poderosa de enseñar. Si los hijos crecen viendo respeto, igualdad y buen trato, ellos también replicarán estos valores en sus relaciones futuras. Madres y padres, pueden prevenir la violencia desde el hogar enseñando con el ejemplo a mostrar afecto, respeto y consideración mutua, compartiendo las responsabilidades de la casa, manteniendo una comunicación directa y la disposición a escucharse sin juicios, ni críticas en los momentos de tensión y resolviendo los conflictos de manera pacífica, todo lo cual crea un ambiente seguro donde no hay cabida para los actos de violencia.



1.10. ¿QUE HACER CUANDO UNO DE LOS HIJOS HA SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL?

1. **Creerle**

   Lo más importante es creer. Escuchar con calma, sin cuestionar ni poner en duda su relato. Frases como: “Gracias por contarme”, “Te creo” o “No estás solo” ayudan a que se sienta protegido.

2. **Brindarle contención emocional**

   Permitirle expresar lo que siente, sin presionarlo. Hacerle saber que hizo lo correcto al contarlo y que usted estará a su lado para protegerlo. Evite reacciones de ira o desesperación, ya que podría aumentar su angustia o hacer que se sienta responsable.

3. **No echarle la culpa**

   Nunca pregunte por qué no habló antes, por qué no se defendió o qué hizo para que ocurriera. La responsabilidad es siempre de quien ejerció la violencia. Culpar o juzgar a la víctima puede generar vergüenza, miedo y dificultar su recuperación.

4. **Buscar ayuda especializada**

   La atención integral es fundamental, aunque el hecho haya ocurrido hace algún tiempo. Un profesional podrá evaluar las necesidades del adolescente, brindar apoyo y orientar a la familia sobre los pasos a seguir.

5. **Si la agresión ocurrió recientemente, acuda de inmediato al establecimiento de salud más cercano**

   Idealmente dentro de las primeras 72 horas para activar el protocolo de atención conjunta para casos de violencia y el kit de emergencia.

6. **Denunciar los hechos**

   La violencia sexual es un delito y debe ser denunciada. Puede acudir a la Policía o al Ministerio Público. También puede comunicarse con la Línea 100 de MIMP.

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



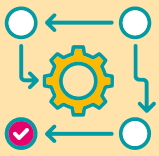
OBJETIVO:
Reflexionar sobre la violencia basada en género y contra los integrantes del grupo familiar, y motivar a prevenirla.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Papelógrafo
- Plumones
- Recurso Nº 1 Rompecabezas de casa (Plantilla y piezas cortadas).
- Recurso Nº 2 Escala abreviada sobre "Creencias de género y relaciones".
- Recurso Nº 3 Imágenes varias sobre violencia.
- Tarjetas.
- "Mural de los compromisos" Elaborado en papelógrafo.



SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el **objetivo de la sesión:** reflexionar sobre la violencia basada en género contra las mujeres y la violencia en el hogar, resaltando que las actividades requieren su participación activa para enriquecer el aprendizaje.

Actividad 1: "El rompecabezas de la casa" (20 minutos)

Imprima los dos rompecabezas de las casas Recurso N° 1 para cada grupo de participantes y su plantilla.

Cada rompecabezas tiene piezas tipo "ladrillos", y cada ladrillo lleva escrito palabras relacionadas con la convivencia familiar, por ejemplo: Respeto, confianza, igualdad, miedo, violencia, apoyo, comunicación, silencio, amor, comprensión, insultos, gritos, malos tratos, diálogo, calma, peleas, bondad, gratitud, cuidados, control, poder, autoridad, risas, burlas, menosprecios, alegría, perdón, paz, rencor, ira, resentimiento, mentiras.

Forme 3 o 4 grupos pequeños, según el número de participantes.

Entregue a cada grupo un juego de los dos rompecabezas (los ladrillos con palabras).

Indique a los grupos que su tarea es construir una casa utilizando solo los ladrillos que consideren necesarios.

Pueden elegir libremente qué piezas o ladrillos usar y cuáles dejar fuera.

Una vez terminada la construcción, cada grupo debe preparar una breve presentación.

Invite a cada grupo a mostrar su casa al plenario y explicar su elección.

Facilite una reflexión final con las siguientes preguntas:

- ¿Les gusta la casa que construyeron? ¿Por qué?
- ¿Por qué eligieron esas piezas para su casa?
- ¿Por qué decidieron no incluir las otras piezas?

Agradezca el trabajo realizado y refuerce la idea de que cada familia "construye" su convivencia a partir de valores que son importantes para su familia.

Señale que las familias, se fortalecen con amor, respeto, comunicación, cuidado, etc., pero se fracturan con la desigualdad, la falta de apoyo, de respeto, de valoración hacia las mujeres, lo cual genera violencia, cualquiera sea el tipo de familia

Recuerde que existen varios tipos de familias: las que se componen de padre, madre e hijos (familia nuclear), las que se componen de un solo progenitor y los hijos (familia monoparental), las que se forman de la unión de parejas donde uno o ambos miembros tienen hijos de relaciones anteriores (familia reconstituida), aquella que Incluye a parientes de distintas generaciones conviviendo juntos, como abuelos, tíos o primos (familia extensa) u otros.

Explique que en la sesión revisarán algunas creencias que existen sobre el rol del hombre y de la mujer y sobre cómo deben ser las relaciones entre ellos. Muchas veces estas creencias ocasionan violencia de pareja y en contra de las hijas.

Para ello invíteles a realizar el siguiente ejercicio.

ADAPTACIÓN

"La casa con imágenes"

Se pueden utilizar Imágenes simples, claras y culturalmente cercanas (pueden ser dibujos grandes o recortes).

Ejemplos de imágenes positivas: pareja conversando, padre e hijas abrazados, hermanos sonrientes, padre y madre cocinando juntos, niños jugando tranquilos, padre cargando bebé, familia riendo, etc. Ejemplo de imágenes negativas: Pareja peleando, hombre gritando, un puño cerrado, una persona triste, alguien controlando a otra, madre castigando a hija, pareja de espaldas sin hablarse, alguien empujando, gesto de desprecio, etc. Esto para reemplazar las palabras mostradas en el recurso utilizado en la actividad.

DESARROLLO:

Actividad 2. "Estereotipos de género y relaciones" (25 minutos)

Entregue a cada participante una copia de la **Escala abreviada de creencias de género y relaciones** para que puedan contestar (Recurso N° 2). Esta escala contiene afirmaciones sobre los roles y las relaciones entre hombres y mujeres y las creencias sobre el amor.

ADAPTACIÓN

El facilitador lee cada frase en voz alta y solicita a los participantes que expresen si están de acuerdo, en desacuerdo o tienen dudas, usando tarjetas de tres colores diferentes.

Explique que cada afirmación tiene 3 alternativas de respuesta: 1, 2 o 3; 1 significa totalmente de acuerdo; 2 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 3 totalmente en desacuerdo.

Solicite que cada persona responda de manera personal y privada.

Si el grupo no es muy grande revise una a una las frases.

Facilite para que dos o tres participantes respondan si están de acuerdo o en desacuerdo en cada frase.

Escuche con empatía, evite confrontar y aproveche para complementar o aclarar ideas cuando sea necesario.

Facilite una reflexión final con las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles afirmaciones les resultó más difíciles de responder? ¿por qué?
- ¿Cuáles afirmaciones repetimos a los hijos y a las hijas?
- ¿Qué consecuencias pueden tener en la convivencia familiar y en la relación de pareja?

Puede decir:

En la vida diaria, muchas veces repetimos ideas sobre cómo "deben ser" los hombres y las mujeres, como si eso viniera de la biología, cuando en realidad son creencias que aprendemos de la sociedad. Cuando aceptamos estas ideas sin cuestionarlas, no ayudamos a que las relaciones entre hombres y mujeres se den en igualdad y respeto. Por ejemplo, creer que la mujer debe ser sumisa o que el hombre es quien manda en la casa.

También existen ideas dañinas sobre el amor. Por ejemplo: "si me quiere, debo aguantar todo" o "me cela porque me quiere". Estas creencias vulneran el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y no favorecen relaciones basadas en el respeto, la confianza y el buen trato.

Los Estereotipos que tenemos sobre los roles y sobre el amor influyen en cómo nos relacionamos en pareja y puede abrir la puerta a la violencia. Por eso, reconocer y revisar nuestras propias creencias es el primer paso para prevenirla.

IDEAS FUERZA



- ✔ ***Cuando criamos sin estereotipos de género, abrimos el camino para que nuestros hijos sean quienes realmente son. La igualdad no quita autoridad, le da sentido al amor y fortalece los lazos familiares.***
- ✔ ***El machismo enseña desigualdad; Pero cada vez que compartimos las tareas, escuchamos sin imponer y valoramos por igual a los hombres y a las mujeres, estamos construyendo relaciones sanas y un hogar libre de violencia.***
- ✔ ***Los mitos del amor romántico nos hicieron creer que amar es sufrir. Enseñemos a nuestros hijos que el verdadero amor cuida, respeta y deja espacio para crecer juntos, sin miedo ni dependencia.***

Señale que la violencia tiene serias consecuencias. Para comprenderla mejor y contribuir a su prevención, se realizará una actividad de análisis de imágenes.

Actividad 3. "Las consecuencias invisibles" (25 minutos)

Forme 3 grupos y entregue las imágenes sobre violencia contra las mujeres (Recurso Nº 3).

Indique que cada grupo debe elaborar una historia, que considere:

- ¿Qué está pasando en la imagen?
- ¿Qué creen que pasó antes?
- ¿Quiénes sufren las consecuencias?
- ¿Cómo terminará la historia?

Una vez que el grupo haya elaborado su historia, nombran a un representante para que exponga en plenario.

ADAPTACIÓN

Usted puede utilizar imágenes que reflejen mejor la realidad y contexto del grupo de padres y madres en su región.

Puede usar testimonios o historias de casos de su región. Adaptando las preguntas para la reflexión.

Cuando los tres grupos hayan expuesto sus casos felicítelos y agradezca.

A continuación, diga: A partir de las imágenes que han revisado,

- *¿Qué tipos de violencia conocen?*
- *¿Cuáles son las consecuencias de la violencia?*

- *¿Qué debe enseñar el padre o la madre a la hija y al hijo adolescente para prevenir la violencia contra las mujeres?*
- *¿Cómo podemos prevenir la violencia?*
- *¿Qué debe hacer el padre, madre o cuidador si su hija le cuenta que ha sido víctima de violencia sexual?*

Facilite para que dos o tres padres respondan a cada una de las preguntas.

Esté atento a la respuesta sobre las consecuencias de la violencia y refuerce que, en la mayoría de casos, quienes más sufren la violencia son las mujeres. Este daño puede ser emocional, físico y, en situaciones extremas, llegar al feminicidio. Además, las consecuencias también afectan a los hijos, que pueden quedar huérfanos y cargar heridas emocionales para toda la vida.

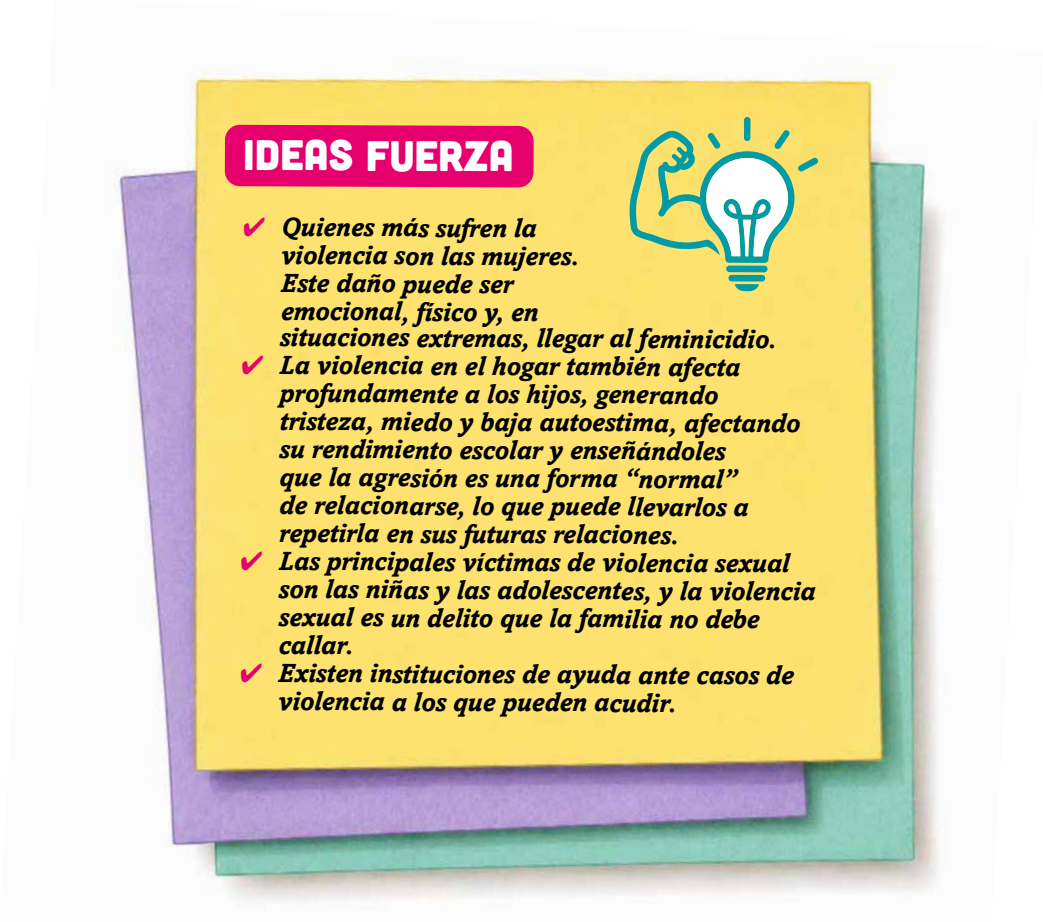
Escuche con respeto y agradezca sus intervenciones.

El co-facilitador tomará nota en un papelógrafo rotulado "¿Cómo prevenir la violencia? las estrategias para prevenir la violencia que plantean los participantes.

Complemente con las estrategias para prevenir la violencia, que se encuentra en la parte teórica de la sesión, adaptando el lenguaje a las características propias del grupo.

Apóyese en una PPT o un papelógrafo.

Complemente con las siguientes ideas:



Presente el siguiente cartel:



También puede mostrar el cuadro de instituciones de ayuda que aparecen en la tabla Nº 2 de la sesión 7.

Invite a cerrar la sesión con la siguiente actividad.

CIERRE:

Actividad 4. "¿Cómo podemos actuar frente a la violencia contra las mujeres?" (20 minutos)

- **Aplicación práctica**

  Los mismos grupos formados reflexionan sobre acciones concretas que pueden hacer desde el hogar para prevenir la violencia contra las mujeres.

  Para ello plantee la idea de que una vecina, o un familiar (prima, sobrina, hermana) está pasando por un problema de violencia en su hogar *¿Qué acciones concretas le sugeriría? ¿A dónde le sugeriría acudir para solicitar ayuda?*

  Cada grupo presenta su propuesta.

- **Compromiso personal**

  Cada participante escribe en una tarjeta dos acciones personales que se compromete a realizar para prevenir la violencia contra las mujeres en su hogar.

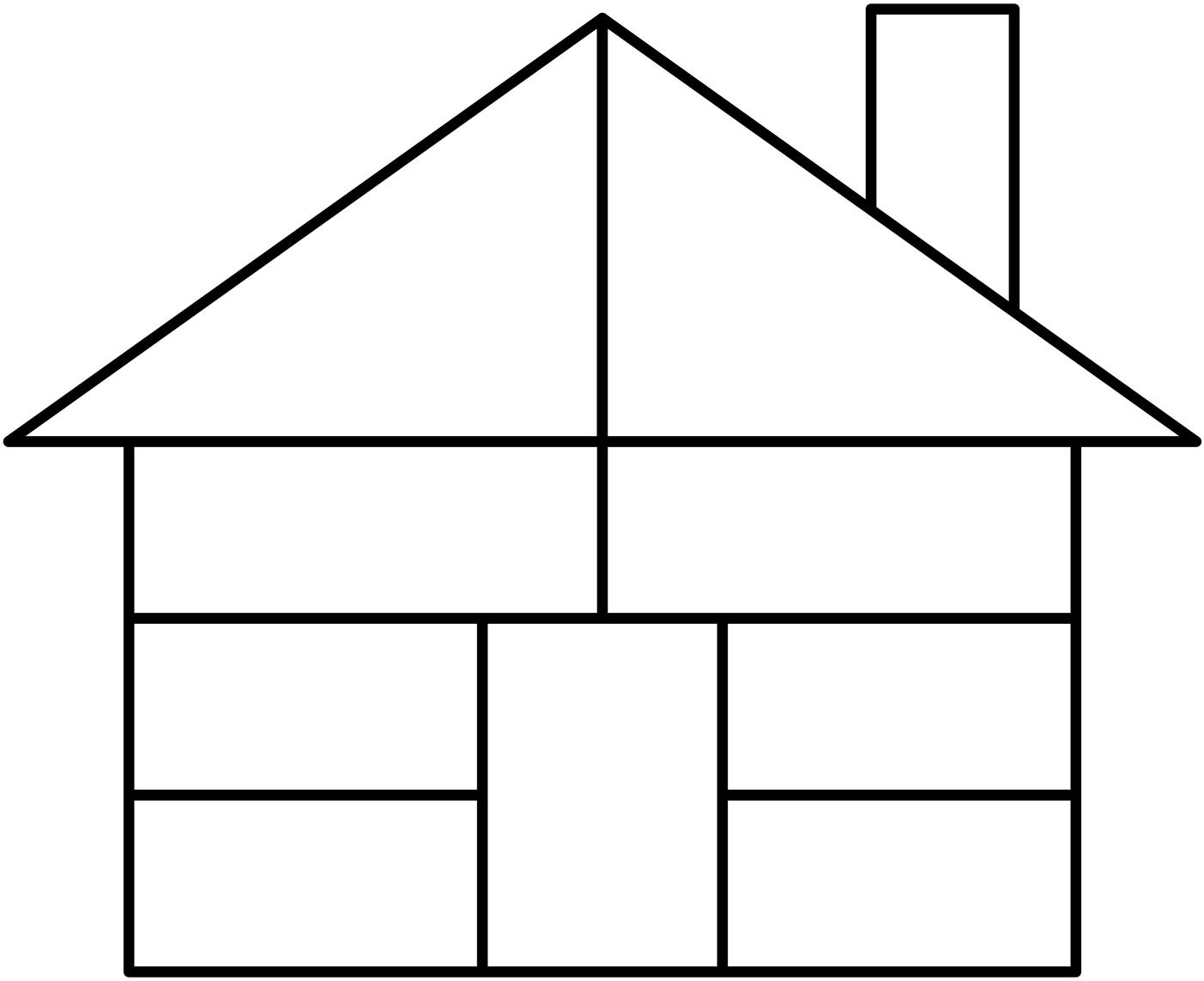
  Se colocan las tarjetas en el Mural de los Compromisos.

"La prevención de la violencia comienza en casa. Cuando elegimos el respeto, la valoración y la igualdad, entre hombres y mujeres, cuidamos a nuestras hijas, hijos y a toda la familia y los protegemos de la violencia".

Recursos

Recurso 1

ROMPECABEZA DE LA CASA




GRATITUD
COMPRENSIÓN
RISAS
CONFIANZA
COMUNICACIÓN
ALEGRÍA
AMOR
PAZ
APOYO
RESPETO


MALOS TRATOS
RESENTIMIENTOS
IRA
VIOLENCIA
MENTIRAS
RENCOR
MIEDO
SILENCIO
INSULTO
PELEAS

Recurso 2

FICHA DE CREENCIAS SOBRE GÉNERO Y RELACIONES SOCIALES

Instrucciones:

Lea cada afirmación y marque una de las siguientes opciones.

1 : Totalmente de acuerdo **2** : Ni de acuerdo ni en desacuerdo **3** : Totalmente en desacuerdo

N.°	Afirmación	1	2	3
1	Las tareas del hogar son responsabilidad de las mujeres.			
2	Un hombre debe ser el principal proveedor económico del hogar.			
3	Las niñas deben comportarse de manera sumisa			
4	Un hombre no debe llorar			
5	Una persona que cela es porque ama mucho.			
6	El amor hacia la pareja puede lograr que cambie y deje de maltratar.			
7	Amar es aguantar, es resistir por amor.			
8	Los hombres deben tener la última palabra en la familia.			
9	Un hombre debe controlar lo que su pareja hace.			
10	A las mujeres las acosan porque se visten provocativamente			

Nota: Ficha elaborada sólo para fines educativos.

Recurso 3

IMÁGENES SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES







Sesión 7

Acompañando a nuestros hijos en el enamoramiento



I. LO QUE DEBEMOS SABER

1.1. EL ENAMORAMIENTO

El enamoramiento es una manifestación de la sexualidad y como tal debe ser entendida por los padres, madres y cuidadores. Sin embargo, podría significar riesgos a una edad en la que el cerebro adolescente no termina de madurar.

Por ello, es importante que padres, madres y cuidadores conozcan sobre la **autonomía corporal**, es decir la capacidad de decidir libremente sobre la vida, las emociones y las relaciones, respetando sus propios valores y límites personales.

1.2. AUTONOMÍA CORPORAL Y DERECHO A DECIDIR

El UNFPA define la autonomía corporal como la capacidad de cada persona para tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo y su vida. Para los adolescentes, esto incluye decidir no tener relaciones sexuales o cuándo, cómo y con quién iniciar relaciones, usar métodos anticonceptivos, y recibir servicios de salud con confidencialidad y respeto.

Es importante que los padres, madres y cuidadores sepan que la autonomía corporal es un derecho humano fundamental. Bajo este derecho ningún adolescente puede ser privado de tomar decisiones sobre su cuerpo. Nadie puede hacer con él, lo que el adolescente no quiere o no decide con total libertad, que significa tener conocimientos y estar informado sobre sexualidad.

> **La autonomía corporal** consiste en tener el poder y la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros futuros, sin violencia ni coacciones. Esto incluye decidir si queremos tener relaciones sexuales, cuándo o con quién. Incluye decidir si queremos quedar embarazadas, cuándo o de quién. Significa la libertad de acudir a un médico cuando sea necesario. Recordemos también que son las niñas y las adolescentes quienes suelen sufrir limitaciones en su autonomía corporal con consecuencias para su salud, su bienestar y su potencial en la vida.

Relacionado con el concepto de autonomía corporal, está el concepto de consentimiento sexual. Es importante que los padres, madres y cuidadores dialoguen con sus hijos sobre el consentimiento sexual, es decir la manifestación expresa de que se está de acuerdo o NO se está de acuerdo y a gusto en una relación íntima.

En el enamoramiento, la autonomía corporal significa que cada uno puede:

- Mantener su **identidad** (preferencias, amistades, proyectos personales).
- **Elegir** cómo expresar afecto y hasta dónde llegar.
- **Decidir sin presiones** si quiere continuar o terminar la relación.
- Sentirse **libre de decir "no"** si no quiere tener relaciones coitales.

Promover la **autonomía corporal** ayuda a prevenir relaciones basadas en control, dependencia o violencia, y favorece el desarrollo de la autoestima y la toma de decisiones responsables. Es importante también porqué fortalece la salud emocional y la confianza en sí mismos, previene relaciones de dependencia o manipulación y permite que el enamoramiento sea una experiencia de aprendizaje positivo y no de sufrimiento.

1.3. ¿CÓMO FOMENTAR LA AUTONOMÍA CORPORAL?

Los padres y las madres pueden:

- **Escuchar sin juzgar**: Validar lo que sienten, aunque a veces nos parezca exagerado.
- **Promover espacios propios**: Animar a que mantengan amistades, hobbies y metas personales.
- **Ser ejemplo de relaciones respetuosas**: Mostrar en casa que el respeto y la negociación son parte del amor.
- **Hablar de límites y consentimiento**: Explicar que "querer a alguien" no significa ceder a todo, que tiene la libertad de negarse si algo de la relación no le gusta.
- **Reforzar la toma de decisiones**: Preguntar su opinión en la vida cotidiana y respetar sus elecciones.
- **Dar información confiable:** Basado en evidencias.

La autonomía corporal, implica respeto. Los adolescentes tienen que saber que el **respeto** en relaciones afectivas implica tratar al otro (y ser tratado) con dignidad, reconocimiento, cuidado, consideración, sin imposiciones, sin violaciones de sus derechos.

Para los padres, madres y cuidadores esto implica, brindar a sus hijos una **crianza respetuosa**, que es un modelo de cómo formar personas capaces de respetar y ser respetadas en sus vínculos afectivos. (UNICEF). En otras palabras, si aspiramos a que nuestros hijos se hagan respetar, debemos criarlos con respeto.

> Acompañar a los hijos adolescentes en sus primeras experiencias de enamoramiento implica enseñarles que el amor no debe doler ni controlar, sino dar seguridad, libertad y respeto.

1.4. RELACIONES DE ENAMORAMIENTO SALUDABLE[37]

Una relación saludable se basa en **respeto, confianza, comunicación y seguridad mutua**. En ella, ambas personas se sienten cómodas, valoradas y libres para expresar lo que piensan y sienten. El amor es **recíproco, sincero e igualitario**, y se respetan los **límites, la autonomía corporal y los derechos** de cada uno.

Características de un enamoramiento saludable

- Reciprocidad: Ambos expresan afecto, escucha, atención mutua.
- Independencia: Cada uno mantiene intereses propios, amistades, espacios personales.

37 MIMP, MINSA y otras organizaciones internacionales usan el término enamoramiento saludable

- Autonomía corporal: Cada uno toma decisiones sobre su propio cuerpo, sin presiones ni imposiciones.
- Comunicación abierta: Se hablan dudas, problemas, límites.
- Respeto: No hay presión ni exigencias abusivas.
- Confianza: No hay vigilancia constante, chantajes emocionales, invasión de privacidad.
- Crecimiento mutuo: Se motivan a aprender, a mejorar, no a depender emocionalmente.
- Seguridad: Ambos se sienten protegidos, hay confianza en que ninguno hará daño al otro.

En cambio, **un enamoramiento problemático puede presentar:**

- Celos, vigilancia, desconfianza permanente, exigir acceso al celular.
- Aislamiento de los amigos y/o de la familia.
- Presión para tener intimidad.
- Mensajes o llamadas constantes, exigencias emocionales.
- Manipulación afectiva ("Si me quisieras no te harías de rogar")
- Chantajes emocionales ("Si no lo hacemos, aquí terminamos")
- Culpabilizar ("Por tu culpa, estoy así")

Es importante saber que los **celos, el control o la manipulación no son muestras de amor**, sino señales de una relación poco saludable. Pensar que el amor justifica el sufrimiento o que la pareja cambiará puede poner en riesgo el bienestar emocional y físico.

Las madres y los padres deben enseñar a sus adolescentes que:

- Tienen **derecho a decir "no"** a cualquier contacto físico.
- **Nadie puede presionarlos ni chantajearlos** por afecto ni hacerles sentir culpables.
- Aun cuando se está enamorado, no se debe perder la autonomía; es decir la libertad de decidir por uno mismo.

Reconocer estos aspectos les ayuda a construir relaciones basadas en el respeto y el cuidado mutuo.

1.5. VIOLENCIA EN EL ENAMORAMIENTO

Puede manifestarse de forma física, psicológica, sexual o simbólica. Algunos ejemplos:

- **Violencia física**: empujones, bofetadas, agresiones.
- **Violencia emocional / psicológica**: humillaciones, insultos, menosprecio, amenazas.
- **Violencia sexual**: obligar, presionar o coaccionar al otro respecto al contacto íntimo sin su pleno consentimiento.
- **Violencia simbólica / control**: celos enfermizos, control de vestimenta, aislamiento social, mensajes invasivos, exigir contraseñas.

Estos patrones surgen de creencias internalizadas sobre el amor (mitos del amor romántico, "de la media naranja", "el amor todo lo puede", "el amor todo lo soporta") sin embargo, es posible reestructurar esas creencias hacia el amor propio, el respeto y la autonomía.

1.6. SEÑALES DE ALERTA QUE UN PADRE O MADRE PUEDE OBSERVAR

Algunas señales que pueden alertar que la relación de su hija o hijo es dañina:

- Cambios de humor pronunciados: tristeza, irritabilidad, ansiedad
- Menos dedicación al estudio, a las amistades y a los hobbies que solía tener
- Cambios en su vestimenta
- Evita contar detalles de la relación
- La pareja controla sus salidas y con quién habla
- Presenta marcas físicas
- Aislamiento repentino

Si observamos alguna de estas señales, debemos intervenir con delicadeza: abrir conversación, validar emociones y ofrecer ayuda profesional.

1.7. RUTAS DE AYUDA Y ATENCIÓN

Cuando la relación muestra signos de riesgo, o si el adolescente lo solicita, hay recursos disponibles para protección, orientación y atención. En la tabla 2 se presentan estos recursos.

Buscar ayuda profesional si:

- Hay violencia física, amenazas o agresiones.
- Hay señales de depresión, ansiedad, ideación suicida en su adolescente.
- El/la adolescente siente que "no puede salir" de la relación.
- Hay abuso sexual o coerción.
- Han intentado dialogar y la situación empeora.

1.8. ¿CUÁL ES EL ROL CENTRAL DE LAS MADRES Y LOS PADRES?

- **Acompañar emocionalmente**: validar emociones (alegría, miedo, vergüenza) y escuchar sin juzgar. Esto fortalece la confianza y hace más probable que el adolescente consulte ante dudas o problemas.
- **Informar y educar**: ofrecer información clara sobre el amor, la autonomía corporal, el consentimiento, métodos anticonceptivos, embarazo, ITS, prevención de violencia, acorde a su edad.
- **Enseñarle a su hijo a construir su semáforo de seguridad,** vinculado con la autonomía corporal**;** a tener definido con claridad qué actitudes o comportamientos NO debe permitir en su relación.
- **Modelar relaciones sanas**: los comportamientos de los adultos (respeto, comunicación, manejo de conflictos) sirven de modelo. Mostrar cómo resolver desacuerdos sin violencia enseña más que las palabras.
- **Fijar límites y supervisión adecuada**: vinculado con la autonomía progresiva, supervisión proporcional a la edad —no control absoluto— que combine respeto por su autonomía y medidas prácticas para su seguridad.
- **Buscar ayuda especializada cuando sea necesario**; para ello debe conocer los lugares o instituciones o los recursos donde puede encontrar ayuda.

Tabla 2. Servicios de ayuda y atención

SERVICIO	CASOS O EMERGENCIAS QUE ATIENDE	CÓMO CONTACTAR
Línea 100 (MIMP)	▪ Violencia familiar o sexual. ▪ Orientación y apoyo emocional a víctimas o testigos. ▪ Derivación a servicios legales, psicológicos y de salud (como CEM).	Llamar al número gratuito 100 (disponible las 24 horas en todo el país).
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA)	▪ Protección de derechos de niños y adolescentes. ▪ Conflictos familiares (alimentos, tenencia, visitas). ▪ Violencia familiar y conciliación extrajudicial. ▪ Reconocimiento de filiación y fortalecimiento familiar. Prevención y orientación familiar.	Acudir a la DEMUNA de las municipalidades distritales.
División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT)	▪ Delitos cibernéticos (amenazas, fraudes, estafas, extorsión). ▪ Pornografía infantil y ciberacoso. ▪ Geolocalización en desaparición de personas. ▪ Crimen organizado con uso de tecnología.	Contactar con la Policía Nacional del Perú – DIVINDAT. Denuncias presenciales o vía web en www.policia.gob.pe. (01) 431-8898 y 1818 para denuncias de delitos informáticos.
Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC)	▪ Trastornos mentales y emocionales (depresión, ansiedad, psicosis). ▪ Problemas en infancia y adolescencia (autismo, TDAH, maltrato). ▪ Adicciones a drogas y alcohol. ▪ Violencia de género. ▪ Rehabilitación y apoyo comunitario.	Acudir al Establecimiento de Salud más cercano para la derivación
Plataforma SíseVe (Ministerio de Educación)	▪ Violencia escolar (física, psicológica, sexual, verbal). ▪ Ciberacoso o violencia virtual. ▪ Disponible para estudiantes, docentes, padres y testigos.	Ingresar a la web https://siseve.minedu.gob.pe/web/
Línea 113 opción 5 (MINSA)	▪ Problemas emocionales y de salud mental. ▪ Depresión, ansiedad ▪ Violencia, bullying, etc.	Llamar al número gratuito (disponible las 24 horas al día a nivel nacional)
Línea 113 opción 3 (MINSA)	▪ Ofrece orientación sobre planificación familiar, derechos sexuales y reproductivos, y salud en general.	Esta línea gratuita funciona las 24 horas del día
Línea 105	▪ De la Policía Nacional del Perú	
Linea 107 opción 3	▪ De ESSALUD Brinda apoyo y orientación psicológica	▪ Línea gratuita, atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Establecimientos de salud del I, II, III nivel de atención.	▪ Atención integral ▪ Atención de la violencia ▪ Dotación del kit de emergencia para la violencia sexual	▪ Acudir al Establecimiento de Salud más cercano

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



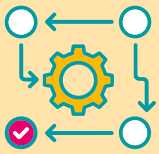
OBJETIVO:
Acompañar el proceso de enamoramiento de su hijo adolescente y conocer cómo actuar frente a señales de alerta.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Papelógrafo
- Plumones
- Tarjetas
- Recurso N° 1: Casos
- "Mural de los compromisos" Elaborado en Papelógrafo



SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique a los participantes que el tema de la sesión será el enamoramiento en la adolescencia, una experiencia que todos y todas hemos vivido.

Actividad 1. "Un gesto que enamora" (10 minutos)

Diga: "Los invito a pensar en un gesto que sirva para expresar cuando una persona se siente enamorada" Por ejemplo:

- En comunidades quechuas: regalar una **chuspa tejida**, o ayudar en la chacra.
- En la Amazonía: compartir **frutas**, enseñar un canto.
- En zonas urbanas: una carta, enviarle **un emoticón** de corazón por redes sociales.

Luego, invítelos a decir su palabra/gesto en voz alta, uno por uno (si el grupo es grande, solo algunos voluntarios).

Agradezca la participación y finalmente señale: "Así como ustedes vivieron esta experiencia, sus hijos también la están viviendo, pero en un mundo distinto, con redes sociales y nuevas formas de relacionarse".

"La tarea que tenemos los padres, madres y cuidadores es acompañarlos con comprensión y respeto, sin olvidar que enamorarse es parte natural del desarrollo adolescente".

Mencione que para saber cómo acompañar, a continuación, haremos un ejercicio.

DESARROLLO:

Actividad 2. "Frases negativas y positivas" (25 minutos)

Primera parte:

Distribuya una tarjeta por persona y un plumón

Solicite que escriban lo siguiente:

- Una frase negativa que suelen decir los padres cuando se dan cuenta que a su hijo le gusta alguien o ya tiene enamorada(o). Por ejemplo. "No tienes edad para esas cosas"

Con ayuda del co-facilitador asegúrese que las frases escritas por los padres, madres y cuidadores se entienden y estén expresadas en el tono que se ha solicitado.

Si no es así, motive a que escriban otras frases, como: "No me vengas con tonterías" "No sabes ni lavar tu ropa y estás pensando en enamorado" "Estas muy chico para esas cosas" u otras que suelen decir los padres o madres.

A continuación, recoja las tarjetas y organice un juego de roles. Para ello forme parejas y a la mitad de ellos entregue las tarjetas con frases negativas.

Solicite que las parejas se pongan de pie, uno al frente del otro. Uno de ellos hará de padre, madre o cuidador y el otro de adolescente.

Indique que cada padre, madre o cuidador leerá la tarjeta en voz alta, con mucho énfasis, como si estuvieran actuando, dirigiéndose a quien hace el papel de adolescente y la repetirá dos veces.

A continuación, conduzca una reflexión con todo el grupo en base a las siguientes preguntas:

- *¿Cómo se sintieron los que hicieron de adolescentes cuando recibieron el mensaje negativo?*
- *¿Si ustedes estuvieran en el lugar de sus hijos, tendrían confianza como para hablarles sobre enamoramiento?*

Escuche con atención y valide la idea que una comunicación autoritaria genera desconfianza en los hijos

Segunda parte:

Distribuya una tarjeta por persona y un plumón.

Señale: Ahora tendremos la posibilidad de decir otras palabras a nuestros hijos sobre el enamoramiento.

Esta vez deben escribir frases positivas. Por ejemplo. "Lo importante es que te respete" "Háblame del chico(a) que te gusta", etc.

Adaptación

Como alternativa, se puede realizar una dramatización, utilizando el guion que se presenta en el Recurso N° 2.

Luego de la dramatización se conduce la reflexión.

Reparta tarjetas para que cada uno escriba una frase positiva. Ofrezca ayuda para escribir a quien lo necesite.

Con ayuda del co-facilitador asegure que las frases escritas por los participantes se entiendan y estén escritas reflejando el tono solicitado.

Seguidamente, en las mismas parejas, repita el ejercicio pero en esta ocasión leerán las frases positivas. Luego pregunte a los que hicieron de hijos:

¿Cómo se sintieron los hijos cuando recibieron el mensaje positivo?

¿Si fueras tu hijo adolescente, tendrías confianza para hablar con tu padre o con tu madre?

Agradezca y felicite la participación.



A continuación, señale que, si bien el amor es una expresión muy bonita de los seres humanos, algunas veces las personas enamoradas no se sienten bien en la relación. Para entender mejor este lado del enamoramiento lo haremos analizando y opinando sobre algunos casos.

Actividad 3. "¿Historias de amor?" (25 minutos)

Organice a los participantes en 4 grupos pequeños y entregue copias de los casos que haya seleccionado del Recurso Nº 1. Previamente seleccione los casos que corresponda a su zona (urbano o rural)

Comente que van a trabajar algunas historias sobre enamorados adolescentes.

Explique que cada grupo recibirá una historia para que la lean y respondan las preguntas que están en las historias. Los grupos comparten sus respuestas en el plenario.

Agradezca y felicite.

Finalice con una reflexión general con todo el plenario a partir de lo compartido. Pregunte:

- *¿Cuáles son las características de un enamoramiento saludable?*[38]
- *¿Cuáles son las señales de alerta durante el enamoramiento?*
- *¿Cómo puede un padre o madre actuar frente a estas señales de alerta?*

Adaptación

En el recurso Nº 1 se presentan dos casos que se ajustan más a zonas urbanas y otros dos que se adecuan más a contextos rurales. Sin, embargo, estos últimos son solo referenciales, y pueden seguir adaptándose al contexto de cada región.

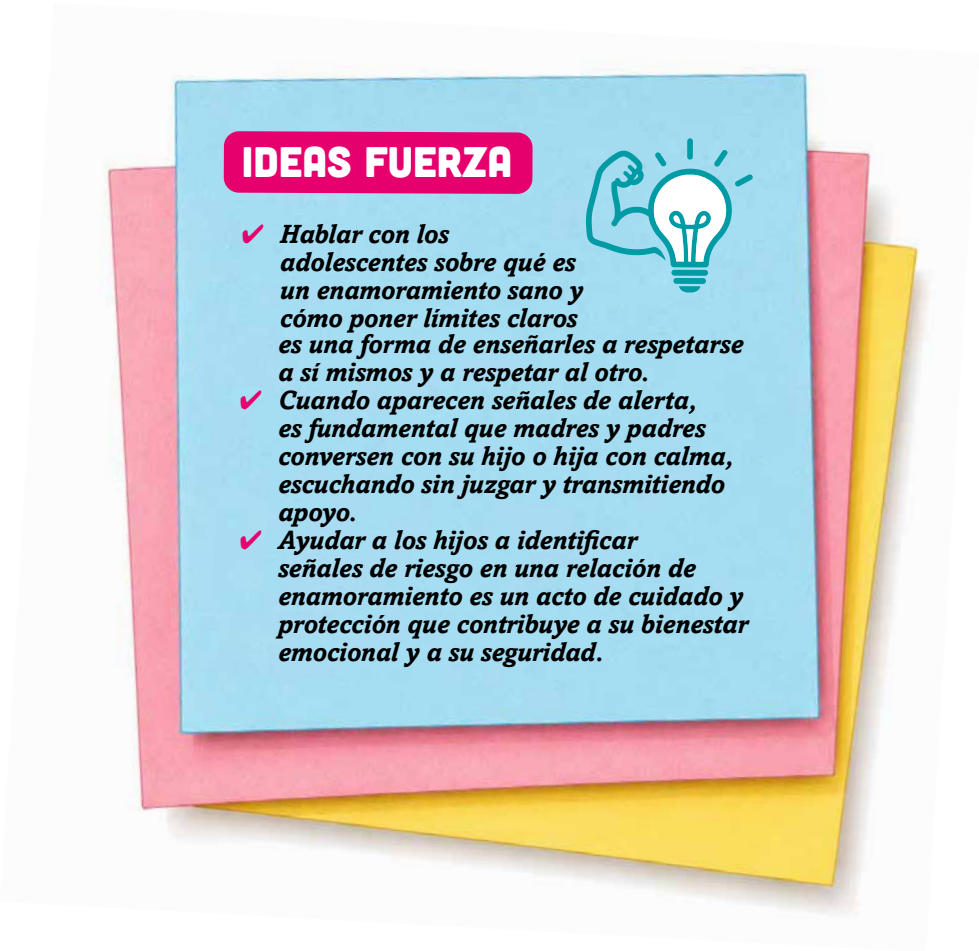
El co-facilitador toma nota de las respuestas en un papelógrafo y con ayuda de una PPT o de un papelógrafo presenta las características de un enamoramiento saludable, las señales de alerta durante el enamoramiento , los servicios de ayuda y el rol de los padres en el enamoramiento de los hijos.

Adicionalmente se puede entregar impresa la Tabla 2: Servicios de ayuda y atención.

Adaptación

Se sugiere presentar de manera dosificada esta información, mediante el uso de imágenes.

Complemente con las siguientes ideas:



38 MIMP, MINEDU usan este término

CIERRE:

Actividad 4. Momento creativo (20 minutos)

Aplicación práctica:

- En grupos escriben la letra de una canción en la cual le dan recomendaciones a sus hijos sobre el enamoramiento

En plenario, los grupos entonan su canción.

Compromiso personal:

Proponga a los participantes escribir en una tarjeta un compromiso personal como padres, madres y cuidadores: una acción concreta que pondrán en práctica con sus hijos.

Puede ser algo pequeño pero significativo:

- Escuchar sin interrumpir.
- Preguntar cómo se siente en su relación.
- Hablar sobre consentimiento y respeto.

Al terminar pegan sus tarjetas en el Mural de los compromisos.

> "Acompañar a nuestros hijos en el camino del enamoramiento no significa controlar ni prohibir, sino guiarlos para que aprendan a relacionarse de manera sana, segura y respetuosa. Ese es el mejor regalo que podemos darles para su presente y su futuro"

Recursos

Recurso 1

CASOS

CASOS ZONA URBANA



Caso 1 Luis está estresado (16 años)

Luis está muy entusiasmado con su enamorada. Últimamente dejó de salir con sus amigos porque ella se molesta si él no le responde de inmediato. Revisa su celular constantemente porque teme que ella se enoje si no le contesta. Ha bajado sus notas y se siente estresado.

- ¿Es sano que Luis tenga miedo de la reacción de su enamorada si no responde de inmediato?
- ¿Qué cambios en su vida diaria muestran que esta relación le está afectando negativamente?
- ¿Qué podría hacer la familia para que Luis sienta confianza para hablar de lo que está viviendo?
- ¿Cómo pueden ayudarlo a reconocer que el control no es una muestra de amor?



Caso 2 Valeria no sabe que hacer (17 años)

Valeria está ilusionada con su pareja, que suele decirle frases cariñosas, pero también la crítica por su forma de vestir y la presiona para tener relaciones sexuales. Cuando Valeria dice que no, él le responde que "si de verdad se aman ella debería demostrarlo".

- ¿Es respetuoso que su pareja decida cómo debe vestirse?
- ¿La frase "si de verdad me amas, demuéstralo" es una expresión de afecto o un tipo de presión?
- ¿Cómo pueden los padres crear un ambiente donde Valeria se sienta en confianza para contarles lo que le pasa?
- ¿Qué mensaje necesitan reforzar respecto a su derecho a decir "no" sin sentirse culpable?

CASOS ZONA RURAL



Caso 1 Flor ya no puede salir con amigas (15 años)

Flor vive en un caserío donde todos se conocen. Desde que empezó a enamorarse de Joel, él le pide que le cuente cada detalle de su día: con quién caminó de regreso del colegio, a quién saludó en la feria o con quién conversó en la parroquia.

Joel le insiste en que "si lo quiere de verdad, debe contarle todo", incluso lo que habla con sus amigas. Cuando Flor duda o le dice que eso no le parece, él responde:

—"Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te molesta?"

Flor empieza a sentirse confundida y con miedo de que Joel se enoje o la deje si ella pone límites.

- ¿Es normal que Joel quiera saber todo lo que hace Flor a cada momento?
- ¿Flor se siente tranquila en la relación o vive con miedo a que Joel se enoje o la deje?
- ¿Cómo pueden los padres darse cuenta de que Flor está siendo controlada o presionada
- ¿Cómo pueden acompañarla sin juzgarla y ayudarla a poner límites sanos en su relación



Caso 2 Margarita se siente incómoda (17 años)

Margarita vive en una comunidad pequeña y está muy ilusionada con su pareja, Miguel, que trabaja en la zona. Al inicio, él era muy cariñoso y atento; la acompañaba cuando iba por agua o cuando regresaba del colegio.

Con el tiempo, Miguel empezó a decirle cómo debería vestirse, porque él cree que "una chica que se respeta no muestra mucho". También la presiona para tener relaciones, diciéndole:

—"Si de verdad me quieres, deberías demostrarlo".

Margarita se siente incómoda y a veces tiene miedo de quedarse sola con él, pero también teme que él la deje si no hace lo que él pide.

- ¿Es correcto que Miguel decida cómo Margarita debe vestirse?
- ¿Margarita se siente segura con él o siente miedo cuando están solos?
- ¿Cómo pueden los padres notar que Margarita ya no se siente cómoda en la relación?
- ¿Cómo pueden ayudarle a reconocer que el amor no debe dar miedo ni presionar?

Recurso 2

DRAMATIZACIÓN (PARA SER USADO EN LA ADAPTACIÓN)

GUIÓN 1: "TE VI EN LA FERIA" (ADOLESCENTE VARÓN)

Personajes: Julián (16), Papá, Mamá, Vecina

Escena 1: Feria del domingo
(Sonido de feria, gente conversando, animales. Julián acomoda verduras en un saco.)

Vecina: (con tono curioso)
—Ay, comadrita, vi a tu Julián conversando bien cerquita con la Rosa. Se reían bonito.
(La mamá frunce el ceño. El papá la mira preocupado.)



Escena 2: Casa, tarde
(Julián entra con su sombrero en la mano, cansado.)

Papá: (serio, sentado en la banca)
—Julián, siéntate. Quiero hablar contigo.

Julián: (confundido)
—¿Ha pasado algo, papá?

Mamá: (molesta)
—¿Por qué estabas conversando con la Rosa? La gente ya está hablando. ¿Así nomás vas a estar con chicas?

Julián: (tímido)
—Solo conversamos... Somos compañeros de clase.

Papá: (alzando un poco la voz)
—No quiero excusas. Tú todavía eres joven. Primero tus estudios y tu trabajo. Desde mañana no irás solo a la feria. Y nada de andar por ahí riéndote con muchachas.

(Julián baja la mirada, respira hondo.)

Julián:
—Está bien, papá... *(Se retira triste.)*

- **¿Qué creen que sintió Julián con lo que escuchó?**
- **¿Ayuda esta forma de reaccionar a que él confíe y cuente cómo se siente?**
- **¿Cómo podrían sus padres acompañarlo sin juzgarlo ni avergonzarlo?**

GUIÓN 2: "Te vieron en el camino" (adolescente mujer)

Personajes: Maribel (15) Mamá, Vecina, Ernesto

Escena 1: Camino de regreso
(Sonido de pasos y viento. Maribel y Ernesto bajan por el camino con cuadernos.)

Ernesto: (amable)
—Dame, Maribel, te ayudo con tu mochila, parece que está pesada.

Maribel: (sonriendo)
—Gracias, Ernesto. Siempre estás atento.

(La vecina observa desde lejos.)



Escena 2: Casa
(Mamá está parada en la puerta, con los brazos cruzados.)

Mamá: (seria)
—Maribel, ven un ratito. Quiero hablar contigo.

Maribel: (nerviosa)
—Sí, mamá...

Mamá: (en tono duro)
—¿Qué hacía ese muchacho contigo? Una señorita no debe andar riéndose con chicos por el camino.

Maribel:
—Mamá... solo me ayudó a cargar mi mochila

Mamá: (molesta, tajante)
—Nada de eso. Desde mañana vienes con tu hermana. No te quiero ver sola en el camino. No quiero problemas ni chismes.

(Maribel se queda callada, con los ojos al piso.)

Facilitador:

- **¿Cómo se sintió Maribel al ser tratada así?**
- **¿Qué mensaje recibe sobre su valor o su libertad?**
- **¿Qué podría decir o hacer la mamá para orientarla sin hacerla sentir culpa o miedo?**

Sesión 8

Detectando riesgos a tiempo en relaciones con los amigos



I. LO QUE DEBEMOS SABER

Durante la búsqueda de identidad, las y los adolescentes suelen cambiar de amistades; los **distanciamientos y conflictos** son parte natural de su crecimiento. Con el tiempo, las relaciones tienden a volverse **más estables y significativas**.

La **necesidad de pertenecer** influye en su autoestima e identidad. A menudo, buscan la aprobación del grupo y pueden adoptar conductas basadas en percepciones erróneas, como creer que sus amigos consumen más alcohol o drogas de lo que realmente ocurre (**Widman et al., 2016**).

En el ámbito sexual, los pares ejercen gran influencia sobre el **inicio de la vida sexual y el uso de métodos de protección**, siendo los varones más vulnerables a la presión social. Quienes tienen amigos sexualmente activos presentan mayor probabilidad de iniciar relaciones, especialmente si creen que eso les dará reconocimiento (**Sieving et al., 2006**).

Por ello, es esencial que madres y padres **dialoguen y orienten** sobre la influencia de las amistades, tanto en la vida real como en el entorno digital. Mantener **vínculos positivos y saludables** actúa como un **factor protector** frente al consumo de sustancias, la violencia y los problemas de salud mental (**UNFPA, 2023**).

1.1. SEÑALES DE ALERTA

- Su adolescente empieza a pasar demasiado tiempo solo o se aleja del grupo de amigos sin una explicación clara.
- Los amigos lo dejan fuera de actividades, no lo incluyen en los trabajos, no lo invitan o lo hacen sentir que “no encaja”.
- Se le observa triste, irritable, preocupado.
- No quiere hacer las actividades que antes disfrutaba (MINEDU, 2021; MINSA, 2020).
- Tiene un amigo de comportamiento dominante.

Cuando estas situaciones persisten, podrían estar relacionadas con experiencias de bullying o acoso escolar, que requieren atención y acompañamiento oportuno

1.2. BULLYING O ACOSO ESCOLAR

Es una forma de violencia entre estudiantes que se manifiesta de manera repetida y deliberada con el fin de humillar, excluir o discriminar a otra persona. Puede ser verbal, física, psicológica o digital (ciberacoso).

Esta violencia es generalmente reproducción de la violencia que se vive en otros espacios (hogar, comunidad, redes sociales) y parte de sus raíces son la discriminación por diferentes causas, así como los estereotipos de género: los varones que no se ajustan a modelos tradicionales de masculinidad o las chicas que desafían normas sociales pueden ser blanco de burlas, exclusión o violencia.

El bullying puede generar consecuencias graves como baja autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento e incluso suicidio.

Algunas señales de alarma incluyen: rechazo a asistir al colegio, síntomas físicos sin causa médica clara (dolor de cabeza, de estómago), hematomas, tristeza, miedo, retraimiento o bajo rendimiento escolar.

1.3. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES, MADRES Y CUIDADORES ANTE SITUACIONES DE RIESGO?

A. Escuchar sin juzgar

- Mostrar calma y apertura; evitando reaccionar con enojo o reproches.
- Hacerles preguntas que inviten a hablar: "*¿Qué pasó exactamente?*" *¿Cómo te sientes?*
- Validar sus emociones; "Comprendo cómo te sientes"
- No criticar

B. Reforzar la confianza y el apoyo

- Hacerle saber que cuenta con su apoyo para resolver esta situación.
- Recordarle que nadie merece recibir malos tratos ni ser excluido.
- Recordarle que tiene cualidades y habilidades y que se le ama.

C. Guiarlo para actuar

- Orientarlo a tomar distancia de quienes lo hieren o presionan y a identificar amistades positivas.
- Enseñarle a **decir "no"** cuando no está de acuerdo con algo o lo presionan. Y a pedir ayuda.
- En c*a*sos de **bullying escolar** conversar con el docente tutor y seguir los canales formales del colegio, ingresando a la plataforma de SISEVE.

1.4. RIESGOS EN REDES SOCIALES

El uso de internet y redes sociales trae grandes beneficios, pero también riesgos que madres y padres deben conocer:

- **Ciberacoso**: cuando un adolescente recibe mensajes ofensivos, burlas, amenazas o la difusión de rumores en línea.
- **Grooming**: adultos que se hacen pasar por adolescentes para ganarse la confianza, manipular y finalmente buscar un encuentro con fines de explotación sexual.
- **Sexting**: cuando un adolescente envía fotos o videos íntimos que luego pueden usarse para chantajearlo o humillarlo (UNICEF, 2021; MINEDU, 2021).
- **Sextorsión:** alguien amenaza con publicar fotos o información íntima para obtener dinero o más contenido sexual.

Es fundamental mantener una comunicación abierta y sin juicios, para que los adolescentes sepan que pueden pedir ayuda si algo les incomoda en el mundo digital.

A. Señales de alerta:

- Cambia de ánimo después de estar conectado (tristeza, enojo o nerviosismo).
- Se aísla o evita hablar sobre lo que hace en redes.
- Oculta la pantalla o borra mensajes cuando alguien se acerca.
- Recibe mensajes o regalos de desconocidos.
- Pasa mucho tiempo en línea, especialmente de noche.
- Habla de un amigo o amiga que es muy bueno(a) en redes sociales
- Tiene amigos en redes que no conoce de manera presencial.

B. ¿Qué hacer si detectan un problema?

- **Escucha y conversa sin juzgar**: Crea confianza para que tu hijo(a) te cuente lo que pasa. Evita reacciones impulsivas.
- **Acompaña el uso de redes**: Revisen juntos la privacidad, bloqueen o reporten cuentas sospechosas.
- **Refuerza su criterio y autocuidado**: Enséñale a identificar mensajes manipuladores, retos peligrosos o pedidos inadecuados.
- **Actúa si hay señales de riesgo**: Guarda evidencias, reporta y, si es grave, denuncia ante la PNP o autoridades competentes.
- **Cuida su bienestar emocional**: Apóyalo, no lo culpes y busca orientación profesional si notas ansiedad, miedo o aislamiento.

C. Rol de madres, padres y cuidadores frente a los riesgos en redes sociales:

El rol de la familia frente al mundo social de su hijo adolescente es el de acompañar, responder con sensibilidad y guiar. Algunas pautas clave son:

- **Conversar frecuentemente** con sus hijos sobre lo que hacen en internet y en redes sociales.
- **Explicar con ejemplos sencillos** qué es el acoso, el grooming, la presión para enviar fotos íntimas o la difusión de contenido sin permiso.
- **Establecer acuerdos claros de uso**: horarios, lugares comunes para conectarse y normas básicas de seguridad.
- **Revisar juntos la configuración de privacidad** y enseñarles a bloquear, silenciar o reportar cuentas peligrosas.
- **Acompañar sin invadir**, mostrando interés genuino y manteniendo una comunicación que genere confianza.
- **Fomentar que pidan ayuda de inmediato** si reciben mensajes incómodos, amenazas o solicitudes extrañas.
- **Practicar estrategias de autocuidado digital**, como no compartir datos personales, evitar hablar con desconocidos y pensar antes de publicar.

- **Buscar apoyo de servicios especializados** cuando detecten riesgos o situaciones de violencia en línea.

1.5. VIOLENCIA SEXUAL

La violencia sexual puede ocurrir en espacios presenciales o virtuales, y afecta profundamente la salud física, emocional y social de los adolescentes.

Se reconocen diferentes formas:

- **Acoso sexual**: comentarios, insinuaciones o conductas de carácter sexual que incomodan o intimidan.
- **Explotación sexual**: cuando se utiliza a un adolescente para obtener beneficios económicos, materiales o de otro tipo.
- **Abuso sexual**: actos sexuales impuestos por la fuerza, manipulación o engaño.
- **Violación**: acto sexual forzado sin consentimiento.

Señales de alerta de violencia sexual (las más frecuentes)

- Retraimiento, irritabilidad o cambios bruscos en el estado de ánimo.
- Descenso repentino en el rendimiento escolar.
- Miedo o resistencia a interactuar con determinadas personas.
- Conductas regresivas.
- Alteraciones del sueño o de la alimentación; conocimiento o conductas sexuales no apropiadas para la edad.
- Presencia de lesiones genitales o infecciones de transmisión sexual

Reconocer estas señales de riesgo y hablar de ellas en casa, de manera clara y sin tabúes, es una forma de proteger la integridad y los derechos de los adolescentes.

¿Qué hacer si detecta violencia?

Si un padre o madre identifica indicios de violencia sexual, lo primero es

- **Mantener la calma y brindar apoyo emocional**, asegurando al hijo que no es culpable de lo ocurrido.
- Es esencial **escuchar sin presionar, sin interrogar y sin emitir juicios**, permitiendo que el adolescente exprese lo que pueda y quiera en ese momento. Evitar la revictimización.
- Luego, deben **buscar atención en un servicio de salud** para la evaluación clínica, el apoyo psicológico y las medidas de prevención y tratamiento oportuno (incluyendo profilaxis, pruebas diagnósticas y acompañamiento emocional).
- También deben **activar de inmediato los mecanismos de protección** establecidos en su territorio: denunciar ante la autoridad competente (Policía, Fiscalía) y, en el caso de menores de edad, acudir a los servicios de protección (como DEMUNA, UPE o los servicios del MIMP).

Algunos recursos para pedir ayuda aparecen en la tabla 2 (pág. 132).

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



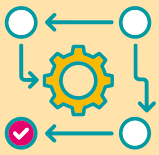
OBJETIVO:
Promover relaciones sanas en la vida real y en las redes sociales, reconocer señales de alerta y saber cómo buscar apoyo oportuno.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Papelógrafo
- Plumones
- Cinta adhesiva
- Hojas de colores
- Tarjetas de cartulinas cortadas ½ A4 de dos colores diferentes
- Video de la amistad: canción "Cuenta conmigo" https://www.youtube.com/watch?v=WX0Ff2AWhF8
- Video sobre acoso escolar: https://aprendemosjuntos.bbva.com/especial/esta-es-la-historia-de-un-nino-que-sobrevivio-al-acoso-escolar-inaki-zubizarreta/
- Recurso N° 1: Testimonio sobre bullying
- Recurso N° 2: Casos para identificar riesgos en redes sociales
- Recurso N° 3: Noticia sobre caso de grooming
- Recurso N° 4: Lista de chequeo para identificar riesgo en relaciones sociales reales.
- Recurso N° 5: Lista de chequeo para identificar riesgo en redes sociales.



SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO:

Brinde una cordial bienvenida, exprese gratitud por dar su tiempo y por su interés en participar en este taller.

Presente el objetivo y el tema que se abordará en esta sesión.

Actividad 1: "Cuenta conmigo" (15 minutos)

Invite a ver y comentar el video sobre la amistad

Facilite la reflexión preguntando:

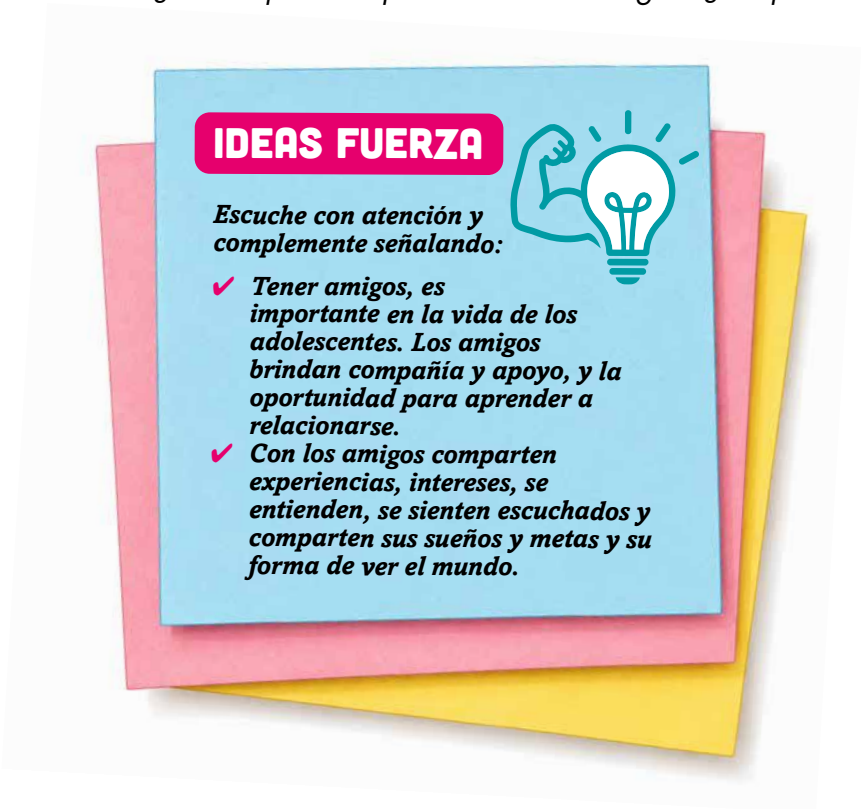
- *¿Qué dice la canción sobre la amistad?*
- *¿Ustedes tienen amigos?, ¿sus hijos tienen buenos amigos?*
- *¿Creen que es importante tener amigos? ¿Porqué?*

ADAPTACIÓN 1

Iniciar la sesión con un cuento o relato real de algún notable en su ciudad sobre la verdadera amistad y su importancia.

ADAPTACIÓN 2

Leer la letra de la canción y continuar con la reflexión propuesta.



Pero no siempre hay amigos verdaderos y para saber identificarlos pasaremos a la siguiente actividad.

DESARROLLO:

Actividad 2. La historia de un niño que sobrevivió al acoso escolar" (25 minutos)

Proyecte el video sobre Acoso escolar y haga preguntas generales:

- *¿De qué trata el video?*
- *¿Qué les pareció el video?*

- *¿Ocurren en los colegios, situaciones parecidas a la mostrada en el video?*
- *¿Cómo hubieran reaccionado ustedes como padres, madres, cuidadores si algo así le pasara a su hijo o hija?*

ADAPTACIÓN

Leer Testimonio de caso sobre bullying, en el anexo N 1.

Luego de escuchar sus respuestas, explique que continuarán hablando sobre el tema, pero en grupos.

Forme 3 o 4 grupos según número de participantes. Solicite que respondan las siguientes preguntas:

- *¿Qué les dirían a sus hijos sobre cómo son los buenos amigos?*
- *¿Cómo pueden reconocer si su hijo se está sintiendo bien en la escuela?*
- *¿A dónde deben recurrir si su hijo está sufriendo violencia en la escuela?*

Señale que, en los grupos, cada integrante debe dar su opinión y responder a las preguntas. Al finalizar un representante presenta en plenaria un resumen de lo trabajado.

Encuentre similitudes y complementariedad en las respuestas de los grupos.

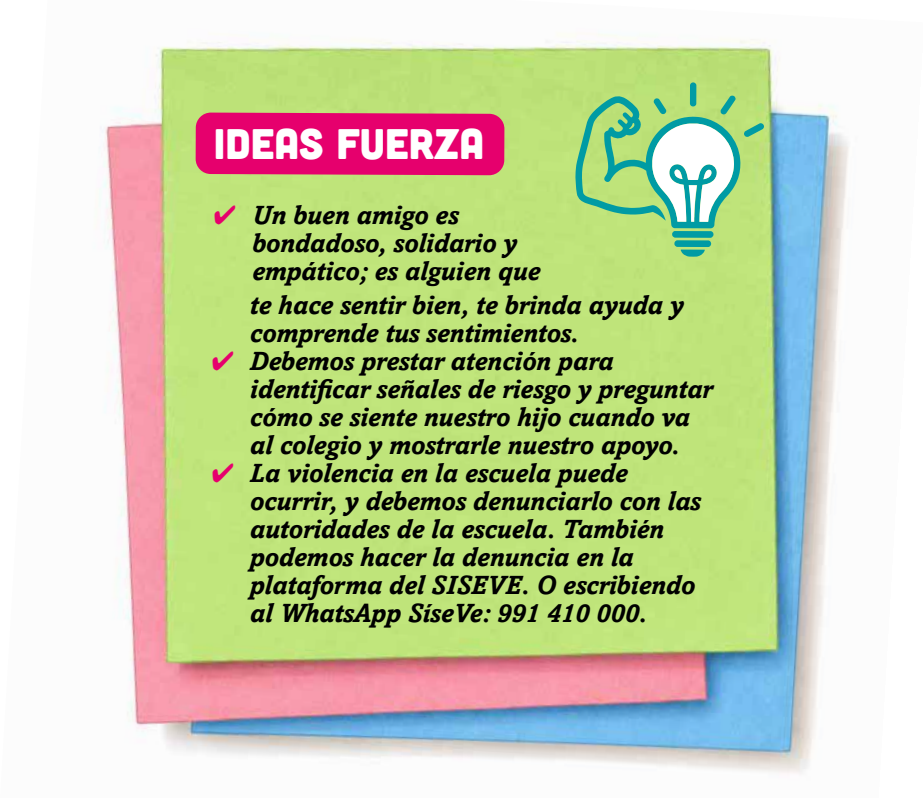
Indique: Antes de finalizar tendremos un espacio de reflexión personal, vamos a verificar si nuestro hijo está mostrando señales de alerta ante casos de bullying. Invita a todos a mirar el PPT (o papelógrafo con el cuadro siguiente), en silencio cada uno identificara si su hijo está mostrando las conductas señaladas. También puede repartir el cuadro a cada uno para que de manera personal y privada respondan.

	¿Mi hijo está bien con sus amigos?	Si/No
1	Su hijo empieza a pasar demasiado tiempo solo o se aleja del grupo de amigos sin una explicación clara.	
2	Ha notado que los amigos lo dejan fuera de actividades, no lo incluyen en los trabajos, no lo invitan o lo hacen sentir que “no encaja”.	
3	Se le observa triste, irritable, preocupado.	
4	No quiere ir al colegio o se siente enfermo con frecuencia	
5	Tiene marcas o señales de golpe	
6	Evita hablar de lo que pasa con sus compañeros o cambia de tema cuando se le pregunta.	

Indique: Si usted ha respondido si a cualquiera de estas conductas, converse con su hijo y de ser necesario busque ayuda.

Agradezca y felicite el trabajo y con apoyo de una PPT o papelógrafo proporcione información sobre qué pueden hacer los padres, madres y cuidadores ante situaciones de riesgo, que se encuentra en el contenido teórico de la sesión.

A continuación, presente las siguientes ideas:



A continuación, explique que actualmente, nuestros hijos usan la tecnología para hablar con sus amigos y para jugar, algunos con quienes juegan son los mismos compañeros del colegio, pero hay otros "amigos" que no conocen en persona, pero con quienes hablan y juegan también.

Invite a los padres a seguir conversando sobre estos "supuestos amigos" en las redes sociales.

Actividad 3: "Riesgos en redes sociales" (20 minutos)

Pregunte si han escuchado alguna noticia con relación a personas que se hacen pasar como amigos de menores de edad, en las redes sociales.

Si no estuvieran enterados, cuente el último caso de la niña de 11 años que a través del juego Roblox conoció a un "amigo", un hombre de 39 años (Recurso 3).

Diga que a esto se le llama **GROOMING**, que significa que un adulto se hace pasar por niño o adolescente para engañar y manipular sexualmente a un menor.

Señale que no es el único peligro que sus hijos enfrentan, también hay otros que ocurren en las redes sociales, de los cuales es necesario hablar.

Explique que lo harán en sus mismos grupos formados anteriormente.

A continuación, entregue una copia de los casos que representan situaciones de riesgo para nuestros hijos en Internet (Ver Recurso 2).

Explique que, en grupo van a reflexionar sobre los tres casos, con las siguientes preguntas:

- *¿Qué peligro es el que enfrenta el adolescente? (problema)*
- *¿Qué señales de alerta podían haber notado los padres o madres?*
- *Si fueras tú el padre o madre, ¿qué hubieras hecho?*
- *¿Dónde acudir en busca de ayuda?*

Luego de reflexionar sobre los tres casos, solicite a cada grupo compartir sus respuestas.

ADAPTACIÓN

Los participantes pueden elaborar casos a partir de las experiencias en su comunidad o región y sobre ellos hacer el análisis.

Para poblaciones no letradas, una alternativa es presentar imágenes para cada riesgo en internet. Narrar una historia similar a la presentada aquí, modificando nombres y dando un contexto más cercano a su realidad y continuar con la reflexión grupal en base a las preguntas.

Encuentre similitudes y complementariedad en las respuestas.

Agradezca y felicite la participación.

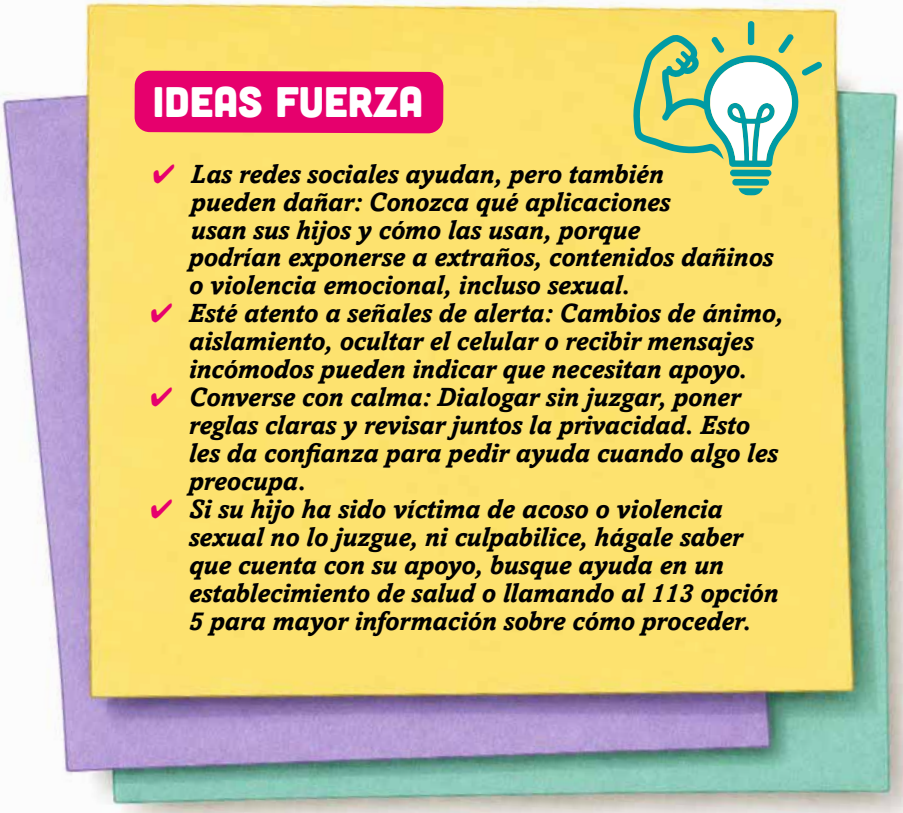
Indique: Antes de finalizar esta actividad tendremos un espacio de reflexión personal, vamos a verificar si nuestro hijo está mostrando señales de alerta en relación al uso de redes sociales. Invita a todos a mirar el PPT (o papelógrafo) con el cuadro siguiente, en silencio cada uno identificara si su hijo está mostrando las conductas señaladas. También puede repartir el cuadro a cada uno para que, de manera personal y privada, respondan.

	¿Mi hijo está bien con sus amigos?	Si/No
1	Mi hijo parece triste, molesto o nervioso, después de estar conectado en el internet	
2	No cuenta sobre lo que hace en internet o en las redes sociales	
3	Oculta la pantalla o borra mensajes cuando alguien se acerca.	
4	Recibe mensajes o regalos de desconocidos.	
5	Pasa mucho tiempo en línea, especialmente de noche.	
6	Habla de un amigo en redes sociales que es muy bueno	
7	Tiene amigos en redes que no conoce de manera presencial	

Indique: Si usted ha respondido si a cualquiera de estas conductas, converse con su hijo y de ser necesario busque ayuda.

Complemente con información de los contenidos de la parte teórica.

Culmine el análisis con las siguientes ideas:



Invite al cierre de la sesión con la siguiente actividad.

CIERRE:

Actividad 4. Momento creativo (10 minutos)

- **Aplicación práctica**

  Los padres organizados en grupo preparan un lema dirigido a padres, madres y cuidadores con información sobre señales de alerta y cómo prevenir los riesgos en redes sociales e información de los lugares donde puede denunciar, pedir ayuda, etc.

- **Compromiso personal: "*Un paso para cuidar*"**

  Cada padre escribe una acción concreta que se compromete a hacer en casa (P. ej: revisar juntos la privacidad en redes, conversar semanalmente sobre amistades, establecer límites para el uso de las redes sociales, observar cambios de ánimo, entre otros).

  Se pegan en el mural de los compromisos.

  Lee algunos compromisos en voz alta.

> **"Acompañar a nuestros hijos no significa controlarlos, sino estar presentes y disponibles. Los padres y madres somos la primera red de apoyo para que aprendan a construir vínculos basados en el respeto y la igualdad".**



Recursos

Recurso 1

TESTIMONIO DE CASO DE BULLYING (PARA SER USADO EN CASO DE ADAPTACIÓN)

"Durante mi etapa en la primaria, mis compañeros y compañeras solían burlarse de mi color de piel y de mi cabello. Con el tiempo, los apodos, las risas y los empujones se hicieron constantes. Cuando buscaba ayuda, la profesora solo me decía: "No les hagas caso, ignóralos". Empecé a faltar a clases y mi mamá, al notar mi cambio, me preguntó directamente qué ocurría. Al contarle todo, fue a la dirección conmigo, pero ahí nos respondieron que "eran solo palabras" y que yo debía "aprender a responder". Mi mamá decidió cambiarme de colegio, pero el daño emocional ya estaba hecho.

En secundaria me costaba confiar en los demás y por eso casi no tuve amigos. Sin embargo, encontré un grupo en internet de fans de mi banda musical favorita y ahí sí pude expresarme con libertad. Varias personas habían pasado por bullying y me comprendían. Hice muchos amigos y amigas en ese espacio, aunque no conozco sus nombres reales ni quiénes son fuera de la pantalla. Aun así, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola". Tania, 17 años.

Recurso 2

CASOS PARA PENSAR SOBRE LO QUE OCURRE EN REDES SOCIALES

Caso 1 (Adolescente varón, 15 años)



Luis, vive en Ayacucho, recibe mensajes ofensivos en un grupo de WhatsApp que fue creado por sus compañeros de clase para coordinar las tareas escolares. Algunos de sus compañeros se burlan de él, le dicen que es muy feo, que mejor se vaya a Chachapoyas (donde nació). Hablan mal de su padre (con quien no vive), difunden rumores falsos sobre él, y le dicen a Luis que es mejor que se suicide. Los otros compañeros le dan like a estas publicaciones. Luis está nervioso, se siente humillado, no quiere conectarse al WhatsApp, y todos los lunes se queja que le duele el estómago, y no quiere ir a clases.

Riesgo: Ciberacoso (violencia psicológica en internet)

Caso 2 (Adolescente mujer, 14 años)



Sofía, vive en Lima, comenzó a chatear con un chico que le dijo que tenía 16 años y le daba like a sus publicaciones en tik tok. Él le decía que nunca había visto una chica tan linda y le enviaba corazoncitos y emojis tiernos. Ella comenzó a contarle algunos problemas que tenía en casa, y él le decía "no estás sola, me tienes a mí". Sofía se quedaba hasta tarde con el celular, y empezó a preocuparse por vestirse mejor y a maquillarse. Después de semanas de conversación, el chico le pide encontrarse en un parque. Sofía va y se encuentra que no era un adolescente, sino una persona adulta.

Riesgo: Grooming (Persona adulta que se hace pasar por menor de edad).

Caso 3 (Adolescente mujer, 14 años)



Camila es de Piura, ella estuvo enamorada de Gustavo por 4 meses, se veían en el colegio y se sentían felices. Ambos estuvieron de acuerdo en esperar para tener sexo. Cuando Gustavo viajó de vacaciones a Lima, empezaron a comunicarse por videollamada, y una vez él se mostró con el dorso desnudo. Camila también hizo lo mismo, y este juego se repitió varias veces. Gustavo comenzó a pedirle que le enviara más fotos. Camila ya no quiso seguir y quiso terminar su relación. El la amenazó que si terminaban compartiría sus fotos.

Riesgo: Sexting y Sextorsión o extorsión digital (Extorsión por fotos subidas al celular).

Recurso 3

NOTICIA

Una menor de 11 años de un distrito de Lima fue reportada como desaparecida, la menor habría quedado en contacto con un hombre de 39 años, mediante un videojuego en línea. La madre de la menor contó que el último domingo, cuando llegó a su casa, no encontró a su hija en la vivienda. Al revisar su vivienda, encontró el celular de la niña y tras revisar el equipo se dio cuenta que se enviaba mensajes por WhatsApp con un "hombre".

Los familiares consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa a la niña, vestida con una polera azul y pantalón negro, saliendo de su casa y encontrándose con el hombre en un parque de la zona. Luego ambos se van de lugar con rumbo desconocido. La niña estuvo desaparecida, retenida por tres días por el sujeto. El acusado está siendo investigado por presunto delito contra la libertad sexual, secuestro de menores, captación mediante videojuego, etc.

Eje 5

Hablando sobre salud sexual y reproductiva con nuestros hijos adolescentes.



Competencia: Fortalece la comunicación con sus hijos adolescentes, abordando con apertura y respeto temas relacionados con la sexualidad, reconociendo los beneficios de los métodos anticonceptivos y valorando su rol en la prevención del EA y las ITS

CAPACIDADES	CONTENIDOS	SESIÓN
Conoce cómo comunicarse mejor con su hijo adolescente.	■ La comunicación con los hijos adolescentes. ■ Barreras intergeneracionales ■ Estrategias para superar las barreras.	**9** Herramientas para comunicarnos mejor en familia.
	■ Técnicas de comunicación asertiva, escucha activa, afrontamiento de la presión social. ■ El respeto a su privacidad.	
Dialoga con sus hijos adolescentes sobre las situaciones difíciles asociadas a la vivencia de la sexualidad.	■ El embarazo en la adolescencia, las ITS y el VH, las uniones y matrimonios tempranos y la violencia sexual.	**10** Acompañando a nuestros hijos adolescentes para prevenir situaciones que ponen en riesgo su bienestar.
	■ Reflexionando sobre las causas y consecuencias del EA y las ITS y otras situaciones difíciles, y los factores contextuales y socioculturales. ■ Dónde encontrar ayuda.	
Reconoce los beneficios de la metodología anticonceptiva en los adolescentes que han iniciado su actividad sexual. Valora su rol en la prevención del EA y las ITS y en dónde encontrar ayuda.	■ Beneficios de la protección sexual. Derribando mitos sobre los métodos anticonceptivos.	
	■ Rol de padres, madres y cuidadores en la prevención del EA y las ITS. ■ Dónde encontrar ayuda.	

Sesión 9

Herramientas para comunicarnos mejor en familia



I. LO QUE DEBEMOS SABER

1.1. COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS ADOLESCENTES

La llegada de los hijos a la adolescencia suele llevar a madres y padres a recordar su propia experiencia en esa etapa y la relación que tuvieron con sus progenitores. En el pasado, hablar de sexualidad en casa era un tema prohibido, rodeado de silencio, vergüenza y culpa, por lo que la información provenía principalmente de los pares, muchas veces distorsionada y cargada de mitos.

Hoy, aunque el contexto ha cambiado, la comunicación familiar sobre sexualidad sigue siendo limitada, breve y superficial[39]. El acceso a internet permite que los adolescentes busquen información por su cuenta y, en ocasiones, sepan más que sus padres, aunque no siempre recurren a fuentes confiables o basadas en evidencia.

Por ello, es esencial que madres y padres rompan con ese legado de silencio y promuevan un diálogo abierto, respetuoso y confiable. Hablar de sexualidad en familia significa ofrecer un espacio seguro donde los adolescentes puedan aprender y desarrollarse de manera sana y responsable.

A. La barrera intergeneracional

Una de las principales dificultades que enfrentan madres y padres para dialogar sobre sexualidad con sus adolescentes es la barrera intergeneracional. Esta se sustenta en las diferencias de experiencia, información, pensamiento, lenguaje y formas de interpretar y expresar la sexualidad.

Las principales barreras son:

- **Tabúes y silencios familiares:** La experiencia propia de los padres, madres y cuidadores, de haber sido educados en el silencio, porque el tema de la sexualidad era considerado un tabú. Por ello, los padres, madres y cuidadores actuales sienten inseguridad y temor de "equivocarse" y de asumir la educación sexual de sus hijos
- **Brecha tecnológica y generacional:** Percepción de que los padres, madres y cuidadores están desactualizados o poco cercanos a ellos para dialogar sobre estos asuntos, debido a que las nuevas generaciones tienen mayor acceso a la tecnología y usan las plataformas virtuales para expresarse y explorar su sexualidad.
- **Las actitudes liberales hacia la sexualidad**: La población joven se caracteriza por actitudes más abiertas en temas como las relaciones pre y extramaritales, la edad de la primera relación sexual y las relaciones entre personas del mismo género (Barragán-Pérez & Fouilloux-Morales, 2021; González-Quiñones et al., 2019; Twenge et al., 2015; Wells & Twenge, 2005). Así también se perciben más derechos y equidad de género (Krauskopf-Roger, 2019), así como mayor aceptación de las identidades trans (Ruiz & Garrido, 2018).

39 UNICEF (2023); OPS & UNFPA (2022); Padilla-Walker & Coyne (2022).

- **Modelos tradicionales y roles de género rígidos** Se transmiten ideas que asocian la sexualidad femenina con culpa y la masculina con poder, reforzando desigualdades. Se limita la educación en temas de equidad, consentimiento y respeto (OPS & UNFPA, 2020).
- **Normas culturales y religiosas restrictivas:** Algunas creencias culturales o religiosas desalientan el diálogo abierto sobre sexualidad en la familia. Entre las consecuencias se restringe la expresión de la sexualidad y se promueve únicamente la abstinencia sexual (UNESCO, 2018).
- **El lenguaje:** Mientras que los adolescentes de hoy se expresan con un lenguaje marcado por las redes sociales, el uso de abreviaturas, anglicismos o códigos propios de su grupo de pares, muchos adultos mantienen formas más formales, y alejadas del mundo tecnológico actual. Esta brecha genera incomprensión, distancia y, en ocasiones, resistencia de los hijos a conversar sobre temas sensibles, como la sexualidad, al sentir que las personas adultas no saben o no comprenden o que recibirán juicios. (UNESCO, 2018).

La ausencia de un "código compartido" entre padres e hijos dificulta el acompañamiento en la toma de decisiones informadas. Para superar esta barrera, es importante que madres y padres desarrollen habilidades de **escucha activa**, se acerquen al **lenguaje juvenil sin juzgar** y promuevan **diálogos horizontales** donde sus adolescentes se sientan valorados.

Reconocer estas diferencias generacionales es el primer paso hacia una comunicación abierta. No se trata de tener todas las respuestas, sino de **escuchar, acompañar y aprender juntos**. Con respeto y empatía, las brechas generacionales se transforman en oportunidades para crecer en familia y garantizar que los adolescentes reciban una educación basada en el respeto, el amor y la protección de sus derechos.

B. Estrategias para superar estas barreras

Algunas estrategias que pueden ayudar a los padres, madres y cuidadores a superar estas barreras incluyen:

a) Reconocer la historia personal

Esto es, reflexionar sobre cómo recibieron (o no) educación sexual en su adolescencia. Reconocer esas experiencias sin juzgarlas les permite entender sus propios miedos y decidir construir una nueva forma de comunicación con sus hijos.

b) Prepararse, buscar información

Contar con información clara y confiable sobre sexualidad, derechos, prevención y uso de métodos anticonceptivos brinda seguridad al momento de conversar.

c) Evitar dar sermones

Los adolescentes valoran ser escuchados. Dar espacio a que ellos hablen y expongan sus dudas, opiniones y experiencias, sin interrumpir ni juzgar fortalece la confianza y abre la puerta a un diálogo sincero.

d) Usar un lenguaje cercano

Adaptarnos al lenguaje que emplean los adolescentes, evitar tecnicismos y comunicarse con sencillez ayuda a que el mensaje sea comprendido y aceptado.

e) Aprovechar los momentos cotidianos

No se requiere de charlas largas o solemnes. Una noticia, una película, una canción o una situación del entorno cercano pueden ser oportunidades para hablar con naturalidad sobre sexualidad y valores.

f) Educar desde el ejemplo

Más allá de las palabras, los hijos observan cómo los adultos se relacionan, respetan los límites y toman decisiones. Ser un modelo de respeto, responsabilidad y cuidado es una forma poderosa de educar.

g) Construir confianza y respeto mutuo

Cuando los adolescentes sienten que pueden hablar sin miedo a ser castigados o ridiculizados, estarán más dispuestos a acudir a sus padres ante una duda o situación difícil.

Algunas otras actitudes que pueden ayudar a romper con la barrera intergeneracional son:

- Mostrar interés por su día a día; preguntar cómo se siente, preguntar por sus amistades, por sus gustos y preocupaciones.
- Evitar actitudes críticas, negativas, juzgar y por el contrario brindar apoyo y seguridad
- Mostrarse dispuesto para conversar y hablar con naturalidad sobre sexualidad sin juicios ni críticas.
- Aceptar de manera serena las preguntas y confesiones de su hijo.
- Validar su interés y curiosidad por saber sobre sexualidad
- Validar lo que sienten ayuda a fortalecer el vínculo.

1.2. COMUNICACIÓN ASERTIVA Y ESCUCHA ACTIVA

A. ¿Qué es?

La comunicación asertiva es un estilo de comunicación que consiste en expresar lo que se siente, piensa y cree sobre las cosas, de manera respetuosa, sin imponer ideas o sentimientos y mucho menos agredir. Es una alternativa efectiva de comunicación frente a otros estilos de comunicación agresiva y pasiva que empleamos las personas. Se caracteriza por ser directa y clara al momento de transmitir mensajes, las frases de una comunicación asertiva son: Yo opino, yo siento, yo prefiero...", "A mí me gustaría...", "Yo estoy de acuerdo, pero te escucho" "No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión", etc.

B. ¿Cómo se desarrolla?

El desarrollo de esta habilidad comienza en el hogar, cuando padres, madres y cuidadores permiten y alientan a niños y adolescentes a expresar sus pensamientos y emociones, validando su voz y enseñándoles a hacerlo con respeto.

C. ¿Cuáles son sus beneficios?

- Cuando un adolescente es asertivo, tiene menos probabilidades de involucrarse en comportamientos de riesgos y tiene más probabilidades de lograr lo que se proponga, además que gana el respeto de las personas a su alrededor.

- Para los padres, madres y cuidadores, con relación a la educación de la sexualidad, la comunicación asertiva les permite decir con claridad lo que quieren decir, transmitir valores, dar opinión, estando dispuestos a escuchar a sus hijos y mostrando respeto por sus opiniones.

- Para los adolescentes la comunicación asertiva es una herramienta poderosa para enfrentar la presión del grupo de pares.

Es importante que padres, madres y cuidadores utilicen el estilo de comunicación asertiva con sus hijos y que dedique tiempo a entrenarlos para que la empleen en distintas situaciones

1.3. LA ESCUCHA ACTIVA

A. ¿Qué es?

Es una forma de atender y responder al hablante con atención plena, empatía y comprensión, usando gestos de interés y devolviendo a la persona lo que se entendió de lo que dijo. Esto transmite respeto y cercanía.

No se trata solo de oír, sino de entender profundamente lo que la otra persona dice, tanto en contenido como en emoción.

B. ¿Cómo se desarrolla?

Se desarrolla con voluntad y entrenamiento

El primer paso es **reconocer la importancia de escuchar** antes de responder. Esto implica controlar los impulsos de interrumpir, aconsejar de inmediato o juzgar.

C. ¿Cuáles son sus beneficios?

La escucha activa es una estrategia muy poderosa para la comunicación en la familia y para la educación sexual. Una buena aplicación de la escucha activa consigue que los adolescentes se sientan realmente escuchados y comprendidos, favoreciendo la confianza y la seguridad de la relación entre padres e hijos.

Algunas técnicas de escucha activa son:

- **Reflejar emociones:** Es identificar las emociones de la persona con la que estamos dialogando. Implica tener presente el lenguaje corporal. Muchas veces las emociones se expresan a través del cuerpo. Ejemplo, “veo que estas triste”, “veo que estás preocupado”.

- **Validación emocional:** Consiste en reconocer, aceptar y legitimar los sentimientos y emociones de otra persona, sin juzgarlos ni minimizarlos. No significa estar de acuerdo, sino dar a entender que lo que la persona siente

tiene sentido. Ejemplo: "entiendo que estés triste", "habías entrenado mucho y perder duele", "es normal sentir frustración".

- **Saber preguntar**: Hacer preguntas abiertas por ejemplo "¿qué piensas del acoso en redes sociales? y de profundidad como "¿te ha pasado a ti alguna vez?", ayudan a la reflexión y a estimular el pensamiento crítico, tan importante a esta edad.

La validación emocional, se aprende en el hogar y se desarrolla en la medida que el hijo se sienta atendido en sus necesidades emocionales; cuando los adultos se preocupan por saber cómo se sienten y son capaces de identificar, reconocer y entender que el hijo siente lo que está expresando.

1.4. AFRONTAMIENTO DE LA PRESIÓN SOCIAL

Según Santrock (2019), la **presión social** (o presión de grupo) se refiere a la **influencia que los pares** ejercen sobre las actitudes, valores y conductas de los adolescentes, especialmente en contextos donde la identidad y la aceptación social son prioritarias. La presión de los pares puede ser **positiva** (fomenta la cooperación, la responsabilidad y la autoeficacia) o **negativa** (lleva a conductas de riesgo o conformismo)

La capacidad de resistir la presión social depende de la autoestima, la madurez emocional y el desarrollo del pensamiento crítico del adolescente y de sus habilidades para la comunicación asertiva.

En este sentido, los padres cumplen un papel fundamental al acompañar y dialogar con sus hijos sobre la presión social, ayudándolos a reconocer que pueden presentarse momentos en los que se sientan motivados o presionados a actuar como lo hace su grupo de amigos. Ante estas situaciones, es importante que orienten a su adolescente a actuar con independencia, a pensar de manera crítica, con base en sus valores, ser asertivos y tomar decisiones responsables que les protejan de posibles riesgos.

Algunas técnicas asertivas que pueden ayudar a hacer frente a la presión de grupo son:

1. Técnica del "disco rayado"[40]	¿En qué consiste? Repetir de manera calmada y firme una misma frase o idea sin entrar en discusiones, por ejemplo: ▪ "No, gracias, no quiero fumar". ▪ Si insisten: "Te agradezco, pero no quiero fumar". ¿Cuál es el objetivo? Mantener la posición sin ceder ante la insistencia de otros, por ejemplo: ¿Por qué funciona?: Refuerza la seguridad y la coherencia personal, mostrando que no es necesario justificar en exceso las decisiones

40 Alberti, R. E., & Emmons, M. L. (2017). Tu derecho a ser asertivo. Desclée de Brouwer.
Ellis, A., & Harper, R. (2019). Cómo mejorar sus habilidades sociales. Desclée de Brouwer.

2. Técnica del "banco de niebla"	¿En qué consiste?: Aceptar parcialmente lo que dice el otro sin perder la postura ni entrar en confrontación, por ejemplo: ■ "Puede que tengas razón en que parece divertido, pero yo prefiero no hacerlo". ¿Cuál es el objetivo? Evitar la discusión sin ceder. ¿Por qué funciona?: Permite mantener la calma y reduce la presión sin romper la relación con el grupo.
3. Técnica del "acuerdo asertivo"	¿En qué consiste? Reconocer los propios errores o límites sin dejarse manipular, por ejemplo: ■ "Sí, a veces soy demasiado cuidadoso, más que los demás, pero me gusta sentirme seguro". ¿Por qué funciona? Enseña responsabilidad personal sin ceder al juicio del grupo.
4. Técnica del "aplazamiento asertivo"	¿En qué consiste? Postergar una decisión para ganar tiempo y reducir la presión del momento, por ejemplo: ■ "Prefiero pensarlo, yo te aviso luego". ¿Por qué funciona? Evita decisiones impulsivas bajo presión social.
5. Técnica del "yo elijo" o afirmación del derecho personal	¿En qué consiste? Reafirmar el derecho a tomar decisiones propias, por ejemplo: ■ "Entiendo que tú quieras hacerlo, pero Yo decido no hacerlo". ¿Por qué funciona? Refuerza la autonomía y la autoafirmación
6. Técnica de la "asertividad positiva"	¿En qué consiste? Afirmar los propios gustos o decisiones de manera amable y segura, por ejemplo: ■ "Gracias por pensar en mí, pero prefiero hacer otra cosa". ¿Por qué funciona? Mantiene la buena relación sin renunciar a los propios valores.

1.5. RESPETO A LA PRIVACIDAD[41]

Desde la psicología del desarrollo, la **privacidad** es una necesidad fundamental en la adolescencia, pues favorece la **autonomía, la identidad y la autoestima**. Contar con espacios propios —como una habitación o conversaciones privadas— les permite reflexionar y expresar emociones con libertad.

Respetar su privacidad no significa desinterés, sino reconocer su individualidad y fortalecer la confianza. En cambio, **invadir su intimidad** revisando pertenencias o mensajes sin permiso puede generar desconfianza y alejamiento.

Por ello, es importante **equilibrar la supervisión con la confianza**, estableciendo acuerdos y manteniendo un **diálogo abierto** que permita acompañar sin vulnerar su espacio personal.

41 Santrock, J. W. (2019). Psicología del desarrollo: Adolescencia. México: McGraw-Hill.

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



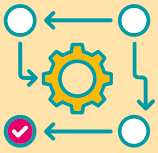
OBJETIVO:
Conocer cómo comunicarse mejor con su hijo adolescente.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Papelógrafo
- Recurso Nº 1 ¿Qué quiso decir mi hijo?
- Recurso Nº 2 Caso Manuel y su papá.
- Recurso Nº 3 ¿De qué otra forma puedo decir lo mismo
- "Mural de los compromisos" Elaborado en papelógrafo



SECUENCIA METODOLÓGICA

A tener en cuenta: Si, la actividad no se ajusta al contexto cultural, puede iniciar esta sesión a partir de las preguntas de reflexión de la actividad 1.

INICIO

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el objetivo y los temas que abordarán en la sesión, resaltando que las actividades requieren su participación activa para enriquecer el diálogo y el aprendizaje.

Actividad 1. "¿Qué quiso decir mi hijo?" (10 min)

Escribe en un papelógrafo las frases del recurso Nº 1.

Muestre primero la primera columna y solicite que intenten interpretar qué quieren decir esas frases. Luego se comparan las interpretaciones con el significado real, mostrando la segunda columna.

Se abre la reflexión grupal con las siguientes preguntas:

- *¿Cuándo su hijo le habla, comprende todo lo que dice?*
- *¿Qué podemos hacer cuando no entendemos lo que nos dicen nuestros hijos?*

ADAPTACIÓN

Empezar la sesión preguntando: ¿Últimamente, han escuchado a sus hijos usar palabras que ustedes no entienden? Cuando esto pasa ¿Qué hacen? Según las respuestas, continuar con la reflexión grupal propuesta.

Luego de las respuestas de los participantes señale:

> *"A veces sentimos que hablamos idiomas distintos con nuestros hijos. Pero si nos damos el tiempo de preguntar y escuchar, podemos entendernos mejor. Eso es también importante para hablar de temas más complejos, como la sexualidad".*

Mencione: *"Otras veces es nuestra forma de comunicar lo que nos impide acercarnos más a nuestros hijos. Para comprender este tema, lo haremos con la siguiente actividad"*

DESARROLLO

Actividad 2. Cambiando de estilo (15 minutos)

Lea la historia de Manuel y su papá (Recurso Nº 2).

Motive el análisis de la forma en que se comunica el padre de Manuel y cómo podría decir lo mismo de otra manera.

Pregunte:

- **¿Cómo se comunica el papá de Manuel?**
  (Respuesta esperada: autoritaria, agresiva, etc.)
- **Cuándo el papá usa esas expresiones ¿cómo creen que se siente Manuel?**
  (Respuesta esperada: mal, siente desconfianza, rencor)
- **¿Cómo creen que debería hablarle el papá a Manuel?**
  (Respuesta esperada: ser menos duro, no autoritario, no ser agresivo, etc.)

Con la ayuda de la información teórica explica de manera breve sobre los estilos de comunicación, incluyendo el estilo de comunicación asertiva.

Estilos de Comunicación

Estilo	¿Cómo se expresa?	¿Qué suele pasar?
Pasivo	No dice lo que piensa, siente o necesita. Calla para evitar problemas.	Se acumula malestar y puede explotar después.
Agresivo	Se expresa de forma autoritaria, brusca; con gritos, amenazas o culpa.	Genera miedo, distancia y conflicto. El adolescente se cierra y no tiene confianza.
Asertivo	Dice lo que siente y necesita con calma, claridad y respeto Respeta las opiniones y derechos de los demás Usa las siguientes palabras: «Yo prefiero...»; «Me gustaría...»; «No estoy de acuerdo, pero te escucho»; «Respeto lo que dices, aunque no esté de acuerdo»; «Yo opino...».	Mejora la comunicación, fortalece la relación y reduce conflictos.

Brinde un ejemplo de cada uno de los estilos de comunicación, por ejemplo:

- Para expresar pasividad: "Rompiste mi taza, ya no importa, está bien, compraré otra".
- Para expresar agresividad: "Rompiste mi taza, ¿eres torpe o qué?, te dije que tuvieras cuidado".
- Para expresar asertividad: "Rompiste mi taza, sé que no lo hiciste a propósito, pero me gustaría hijo que tengas más cuidado la próxima vez".

A continuación, mencione que harán un ejercicio, explique que usted leerá una expresión que usan los padres de familia cuando hablan con sus hijos y que ellos deben intentar cambiar a un estilo asertivo. Use las frases del recurso Nº 3.

ADAPTACIÓN

Explique los estilos de comunicación mostrando tres imágenes: la tortuga (representa la comunicación pasiva), un dragón (representa la comunicación agresiva) y un delfín (representa la comunicación asertiva)

Puede usar otros animales de su región para representar los estilos de comunicación.

Promueva la participación y escuche las diferentes opciones de respuesta de los participantes y refuerce con las siguientes ideas:

IDEAS FUERZA



- ✔ ***La comunicación asertiva permite comunicar de manera directa, clara y respetuosa lo que esperamos de los hijos.***
- ✔ ***La asertividad, implica considerar qué batallas ganar y cuales perder; ejemplo la elección de la ropa o la decisión de qué deporte practicar debe recaer en ellos.***
- ✔ ***La asertividad implica estimular a tomar buenas decisiones, no a decidir por ellos.***

Señale que es importante que sigan practicando el estilo asertivo para comunicarse porque eso nos acerca más a nuestros hijos, cuando podemos decir las cosas sin gritar.

Asimismo, explique que uno de los desafíos que tienen los adolescentes es enfrentar la presión de los amigos o la influencia de estos en sus decisiones. Presente en un papelografo o PPT las pautas y estrategias para hacer frente a situaciones de presión de grupo, que se encuentran en la sección de marco teórico. Brinde 2 o 3 ejemplos de cada técnica para una mayor comprensión.

A continuación, invíteles a conocer otras técnicas para mejorar la comunicación con los hijos.

Actividad 3. "Como un témpano de hielo" (15 minutos)

Para ello, divida a los participantes en dos grupos; uno de los grupos continuará en el papel de padres y la otra mitad asumirá el papel de hijo. Invite a "los hijos" a salir del auditorio.

A los padres, explíqueles que cuando los hijos regresen al salón, querrán contarles algo. Pero ellos no los deben escuchar, no deben prestar atención, deben mostrarse distraídos.

Salga del auditorio y diríjase al lugar donde están los hijos, y explíqueles que al regresar al salón deben compartir algo muy importante a "los padres": algún logro o algún problema (P. ej. presión de amigos para beber alcohol)

Luego, el grupo que actúa como hijos ingresa al salón e interactúa con el grupo de padres, después de 5 minutos de interacción, pregunte a quienes desempeñaron el papel de hijos:

- *¿Qué pasó en el ejercicio?*
- *¿Cómo han notado a los padres?*
- *¿Cómo se han sentido?*

A los padres pregunte:

- *¿Qué pasó en el ejercicio?*
- *¿Cómo han notado a los hijos?*
- *¿Cómo se han sentido?*

Dirigiéndose al plenario dirija una reflexión general con las siguientes preguntas:

- *¿En la vida real esta actitud se presenta en los padres/ madres?*
- *¿Cómo creen que se siente un hijo cuando es tratado así?*
- *¿Qué podemos hacer?*

Se recoge las opiniones y se refuerza:

La escucha activa es una forma de atender y responder con atención plena, con empatía y comprensión, mostrando interés y haciéndole saber a la persona que entendemos lo que dijo. Esto transmite respeto y cercanía.

IDEAS FUERZA



- ✔ ***Cuando alguien que queremos no nos escucha, nos sentimos mal, tristes, inseguros, no comprendidos.***
- ✔ ***Cuando no se escucha a un hijo, se lastima su autoestima, porque el mensaje que le damos es que él no es importante y que puede ser ignorado.***
- ✔ ***Escuchemos activamente, es decir de manera consciente, mostrando interés y comprensión.***
- ✔ ***Practicar la escucha activa es muy importante para que nuestros adolescentes confíen y sepan que siempre pueden contar con nuestro apoyo.***

Con ayuda de un papelógrafo o PPT presente las técnicas de escucha activa, que se encuentran en el marco teórico de la sesión.

CIERRE:

Actividad 4. Momento creativo (15 minutos)

- **Compromiso personal:** Cada padre y madre se compromete con un cambio concreto en la comunicación con sus hijos.

Escriben sus compromisos en tarjetas y los colocan en el Mural de los Compromisos.

> *"Cada conversación que tenemos con nuestros hijos es una oportunidad para fortalecer la confianza. Si sembramos diálogo y respeto hoy, recogeremos seguridad y amor mañana"*



Recursos

Recurso 1

¿QUÉ QUISO DECIR MI HIJO?

FRASE ADOLESCENTE	EQUIVALENTE EN "LENGUAJE ADULTO/PADRES"
"Mi **crush** es alguien de mi salón".	"Me gusta alguien de mi salón".
"¡Me encanta tu **outfit**!"	"Me gusta mucho el estilo de ropa que usas".
"Le escribí y me **dejó en visto**".	"Le mandé un mensaje y no me respondió, aunque lo leyó".
"Le escribí y me **ghosteó**"	"Le escribí, pero nunca más me contestó"
"Fuimos en **modo random** al cine".	"Fuimos de manera improvisada al cine".
"No seas **grinch**, ven un rato".	"No seas aguafiestas, acompáñanos un momento".
"Esa canción la **amo**".	"Esa canción me encanta mucho".

Recurso 2

EL PADRE DE MANUEL

Manuel tiene 15 años y quiere mucho a su papá, pero últimamente siente que él no lo entiende. Cuando Manuel se despierta tarde, se escucha decir "eres un flojo Manuel". También cuando le pregunta por qué no le da permiso para salir de paseo con sus amigos, el papá le responde: "porque yo te lo digo", porque "mientras vivas aquí harás lo que te diga" Y cuando Manuel le quiere dar su opinión le dice "Tú no sabes nada de la vida". Manuel ya no se siente con ganas de hablar con su papá de sus cosas.

Preguntas para el análisis

- ¿Cómo crees que se siente Manuel?
- ¿Crees que Manuel siente confianza para hablar con su papá?
- ¿Cómo podría hablarle el papá?

Recurso 3

¿DE QUÉ OTRA FORMA PUEDO DECIR LO MISMO?

Frase común de los padres	Versión asertiva
"Porque yo lo digo y punto".	"Entiendo que no te guste lo que digo, pero hay razones importantes para que tomemos esta decisión. ¿Quieres que te las explique?"
"Eres un irresponsable".	"Me preocupa que olvides tus responsabilidades. ¿Cómo puedes organizarte mejor?"
"Mientras vivas en esta casa, harás lo que yo diga".	"En esta casa tenemos reglas que nos ayudan a convivir mejor, ¿cómo podríamos cumplirlas?"
"No entiendes nada".	"Quizás lo ves de manera distinta. Cuéntame cómo lo entiendes tú".
"No tienes edad para hablar de eso".	"Ese tema es importante y lo hablaremos"
"Siempre estás en el celular, no haces nada".	"He visto que pasas mucho tiempo en el celular, ¿te parece si buscas un equilibrio con otras actividades?"

Sesión 10

Acompañando a nuestros adolescentes para prevenir situaciones que ponen en riesgo su bienestar



I. LO QUE DEBO SABER PARA DESARROLLAR LA SESIÓN

Los adolescentes pueden estar expuestos a situaciones que ponen en riesgo su salud y su futuro, como por ejemplo iniciar relaciones sexuales sin protección, enfrentar un embarazo no planificado o adquirir una infección de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.

1.1 ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE?

De acuerdo al UNFPA[42], las causas del embarazo están vinculadas a varios factores como: la falta de educación sexual, que afecta el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo, la limitada disponibilidad de servicios de salud amigables para adolescentes, el difícil acceso a métodos de protección y, en muchos casos, a patrones socioculturales y relaciones desiguales de poder que afectan sobre todo a las adolescentes.

De acuerdo a OMS las causas se pueden describir por factores.[43]

Factores individuales	Falta de conocimientos que pueden ser impartidos por la educación sexual
	Inicio precoz de la actividad sexual
	Baja percepción del riesgo
Factores familiares	Carencias afectivas y falta de comunicación familiar
	Violencia sexual o coerción
Factores educativos y sociales	Abandono escolar y poco acceso a educación
	Pobreza y desigualdad de género
Factores socio culturales	Normas sociales que favorecen el matrimonio o maternidad temprana; la violencia sexual
	Estigma sobre el uso de anticonceptivos
Factores del sistema de salud	Acceso limitado a servicios de salud amigables para adolescentes

42 UNFPA, 2023 Educación integral en sexualidad: Conceptos, enfoques y competencias
43 OMS. Adolescent pregnancy fact sheet. Actualización 2024.

Entre los patrones socioculturales del embarazo adolescente se encuentran:

- **Normas de género y mitos**

  Las normas de género y ciertos mitos refuerzan la idea de que son las mujeres quienes deben "cuidarse", "poner límites", mientras se justifica que los hombres insistan o presionen. Expresiones como "cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí" o las letras de algunas canciones que alimentan una cultura de la violación, en la que el cuerpo de las mujeres y sus decisiones no son respetadas.

  Además, los mitos sobre los métodos anticonceptivos. Muchas veces se juzga a las mujeres por llevar un condón, mientras al mismo tiempo se le exige a ella ser la responsable de evitar un embarazo. Estos dobles estándares afectan la capacidad de protegerse y limitan el acceso a servicios de planificación familiar.

- **Matrimonio infantil y uniones tempranas**

  En el Perú todavía se registran casos de matrimonio infantil. La mayoría ocurre en zonas rurales y en familias pobres, en donde estas uniones son aceptadas como salida a la violencia familiar o a cambio de algún beneficio económico. El matrimonio infantil y las uniones tempranas limitan la educación, aumentan la exposición a la violencia y al abuso sexual, y generan embarazos no planificados.

  La Ley Nº 31945 (2023) prohíbe el matrimonio con menores de edad en el país. Este avance legal busca proteger a niñas y adolescentes, aunque aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar por completo las uniones forzadas.

- **La violencia sexual**

  Una proporción importante de embarazos adolescentes proviene de situaciones de abuso o coerción sexual, especialmente dentro del entorno familiar o cercano.

  Según UNFPA Perú, la mayoría de los embarazos en niñas de 10 a 14 años ocurre como resultado de abuso o violación sexual.

  El Código Penal peruano considera las relaciones sexuales con menores de 14 años como violación sexual, lo que está directamente vinculado a estos embarazos.

- **Desigualdades socioeconómicas**

  Las niñas de hogares pobres tienen muchas más probabilidades de quedar embarazadas que las de hogares con mayor nivel de ingresos. UNFPA señala que el 85 % de madres menores de edad provienen de estratos de bajos ingresos económicos.

  También hay diferencias geográficas: zonas rurales, regiones amazónicas u otras con menor acceso a servicios presentan peores indicadores.

1.2. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

Las principales consecuencias se listan a continuación[44]:

En la adolescente	En el recién nacido
Mayor riesgo de mortalidad materna por causas como hemorragias, infecciones y preeclampsia.	Mayor riesgo de mortalidad neonatal, especialmente en las primeras semanas de vida.
Complicaciones de salud física: anemia, desnutrición, infecciones urinarias, hipertensión inducida por el embarazo.	Nacimiento prematuro (antes de las 37 semanas) debido a la inmadurez física de la madre.
Mayor probabilidad de parto complicado o cesárea por condiciones biológicas inmaduras.	Bajo peso al nacer, producto de deficiencias nutricionales y de salud materna.
Problemas de salud mental: depresión, ansiedad, sentimientos de culpa o aislamiento.	Débil sistema inmunológico, con mayor vulnerabilidad a infecciones.
Interrupción de la educación y pérdida de oportunidades de desarrollo personal y laboral.	Retrasos en el crecimiento y desarrollo físico y cognitivo si no recibe atención adecuada.
Estigmatización social y discriminación, especialmente si el embarazo es producto de abuso.	Mayor riesgo de abandono o falta de cuidados adecuados debido a la inmadurez de la madre y el entorno.

De acuerdo al UNFPA, cuando una adolescente queda embarazada, muchas veces deja la escuela, lo que reduce sus oportunidades laborales y su independencia económica. Esto genera un círculo de pobreza: la joven madre tiene menos ingresos y sus hijos enfrentan más riesgos de desnutrición, rezago escolar y exclusión social.

Así, el embarazo adolescente perpetúa las desigualdades y limita el desarrollo de las familias y comunidades más vulnerables. Prevenirlo no solo protege la salud, sino que también rompe el ciclo de pobreza y promueve la igualdad de oportunidades.

■ Las Infecciones de Transmisión Sexual

Las ITS representan un riesgo importante en la adolescencia. Muchas veces las ITS no presentan síntomas, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento. Algunas de las más

44 Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Noticias institucionales

frecuentes son sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis B y C, el virus del papiloma humano (VPH) y el VIH. Todas ellas pueden generar complicaciones graves si no se detectan y atienden a tiempo. En el caso del VIH, la etapa avanzada conocida como SIDA puede deteriorar gravemente la salud si no se recibe tratamiento. El MINSA ofrece atención gratuita y tratamiento antirretroviral a toda persona diagnosticada.

Rol de los padres, madres y cuidadores frente a la prevención del EA y las ITS

Los padres y las madres tienen un rol fundamental en la prevención del EA y las ITS:

- Hablar con sus hijos sobre sexualidad de manera abierta y respetuosa.
- Estar atentos a señales de riesgo y acompañarlos en la toma de decisiones saludables.
- Promover con el ejemplo, relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad.
- Hablarles principalmente a las hijas mujeres de la autonomía corporal, es decir nadie puede obligar a estar en una relación afectiva que no haya decidido libremente, ni a sostener relaciones coitales si no lo desea, y mucho menos a embarazarse o formar familia.
- Educar a los varones adolescentes en la importancia de tener en cuenta el consentimiento de las mujeres para las relaciones íntimas.
- Educar a los varones adolescentes para establecer relaciones de respeto y de igualdad con las mujeres y respetar si la mujer dice que no.
- Reconocer los riesgos y estar atentos a señales de violencia o coerción.
- Cuestionar mitos y estereotipos que ponen en riesgo su bienestar.

1.3. ¿DÓNDE ENCONTRAR AYUDA?

En el Perú, los EESS del MINSA cuentan con servicios diferenciados para adolescentes, y servicios de salud sexual y reproductiva donde se brinda orientación, consejería y acceso a métodos anticonceptivos y pruebas de ITS de manera confidencial y gratuita. Para consulta virtual llamar al 113 opción 3.

También existen líneas de ayuda como la Línea 100 para casos de violencia sexual y el Centro de Emergencia Mujer (CEM), además de organizaciones aliadas como UNFPA que trabajan por la salud y derechos de adolescentes.

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN



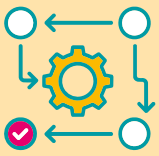
OBJETIVOS:
- Dialogar y orientar a sus hijos en toma de decisiones responsables frente al embarazo y las ITS.
- Reconocer los beneficios de la prevención del embarazo adolescente y las ITS, valorando su rol y en donde encontrar ayuda.



TIEMPO:
90 minutos.



MATERIALES:
- Video: "La Habitación Vacía" https://www.youtube.com/watch?v=0i8IcoL25R4
- Tarjetas con las preguntas del Recurso N° 1 Reflexionando sobre el embarazo y las ITS.
- Recurso N° 2 ¿Si tu fueras... qué dirías?
- Recurso N° 3 Mitos sobre métodos anticonceptivos
- "Mural de los compromisos" Elaborado en Papelógrafo



SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO:

Luego de brindarles una cordial bienvenida, exprese gratitud por su tiempo y mantener la motivación para participar en este taller.

Indique de forma breve el objetivo y los temas que abordarán en la sesión, resaltando que las actividades requieren su participación activa para enriquecer el diálogo y el aprendizaje.

Actividad 1: Motivación: Proyección del video "La habitación vacía" (15 minutos)

Inicie la sesión proyectando un video, luego pregunte:

- *¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del video?*
- *¿Cómo se siente la adolescente? ¿Por qué?*
- *¿Qué le hubiera ayudado a prevenir el embarazo?*

ADAPTACIÓN 1

Puede utilizar algún otro video sobre embarazo adolescente producido en su región.

Tome nota de sus respuestas y complemente señalando que un embarazo no intencionado en la adolescencia, les cambia la vida a las adolescentes particularmente porque son ellas las que finalmente se harán cargo del bebe y su crianza.

Señale que en la sesión continuarán reflexionando sobre el embarazo y las ITS en esta etapa, buscando comprender por qué ocurren y por qué es necesario prevenir y el rol de los padres, madres y cuidadores en la prevención del embarazo.

ADAPTACIÓN 2

Puede usar el testimonio de embarazo adolescente del recurso N° 1. Y adaptar las preguntas al testimonio.

DESARROLLO:

Actividad 2: Reflexionando sobre el embarazo y las ITS (20 minutos)

Invítelos a sentarse formando un gran círculo para realizar una dinámica grupal.

Explique que esta actividad consiste en responder preguntas relacionadas con el embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS), que están escritas en tarjetas (ver recurso Nº 2).

Explique que las tarjetas estarán colocadas en el centro del círculo, y cada participante, de manera voluntaria, se acercará para tomar una de ellas y responder.

Explique que las respuestas deben surgir desde su experiencia y conocimiento personal.

Destaque que no hay respuestas incorrectas, y que, si en algún momento creen que no saben la respuesta, NO deben preocuparse.

Explique que, si prefieren no responder alguna pregunta, tienen la posibilidad de decir "comodín" (el comodín son tarjetas adicionales que contienen acciones a realizar; como cantar, bailar, recitar, decir algo gracioso, etc).

Finalice agradeciendo la participación, reforzando algunas ideas clave sobre las causas y consecuencias del embarazo y las ITS, así como el rol tan importante que madres y padres desempeñan en la orientación y acompañamiento de sus hijos.

ADAPTACIÓN

Una variante para padres y madres no acostumbrados a participar voluntariamente, es colocar las tarjetas con las preguntas, debajo de las sillas.

IDEAS FUERZA



- ✔ ***El embarazo adolescente responde a múltiples factores, como la falta de información, las barreras para acceder a métodos de protección y las dificultades familiares.***
- ✔ ***En algunos casos, ocurre por violencia sexual o por matrimonios o uniones tempranas. En el Perú, el matrimonio antes de los 18 años está prohibido por ley.***
- ✔ ***El embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden afectar el bienestar físico, emocional, académico y social de los adolescentes. Prevenirlos es proteger su presente y su futuro.***
- ✔ ***Conversar con los hijos sobre los beneficios de postergar el inicio sexual es importante y se debe seguir alentando.***
- ✔ ***A los adolescentes que han iniciado relaciones íntimas o lo están pensado, es necesario hablarles de los métodos anticonceptivos modernos y que pueden acceder a ellos en los establecimientos de salud.***

Actividad 3: "Si tú fueras...¿qué dirías?" (25 minutos)

Señale que seguirán dialogando sobre estas situaciones difíciles relacionadas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia y sobre cómo abordarlas.

Para ello, con una dinámica forme cuatro grupos y entregue a cada grupo una copia de un caso de las situaciones "Si tú fueras su padre/ madre que dirías" que se encuentran en el Recurso Nº 3.

En los grupos, cada padre y madre debe responder a las preguntas. Luego de escuchar sus respuestas entre todos llegan a conclusiones.

Proceda a la plenaria para que un representante de cada grupo responda.

Escúchelos con atención, destacando que como padres, madres y cuidadores les corresponde enseñar a sus hijos adolescentes sobre:

- Tomar decisiones basadas en un análisis de los pros y contras y en su plan de vida (objetivos y metas que se hayan propuesto).
- Consentimiento para las relaciones sexuales; de manera libre, sin sentirse comprometida, ni bajo presión.
- Autonomía corporal; libertad para decidir sobre el cuerpo con responsabilidad.

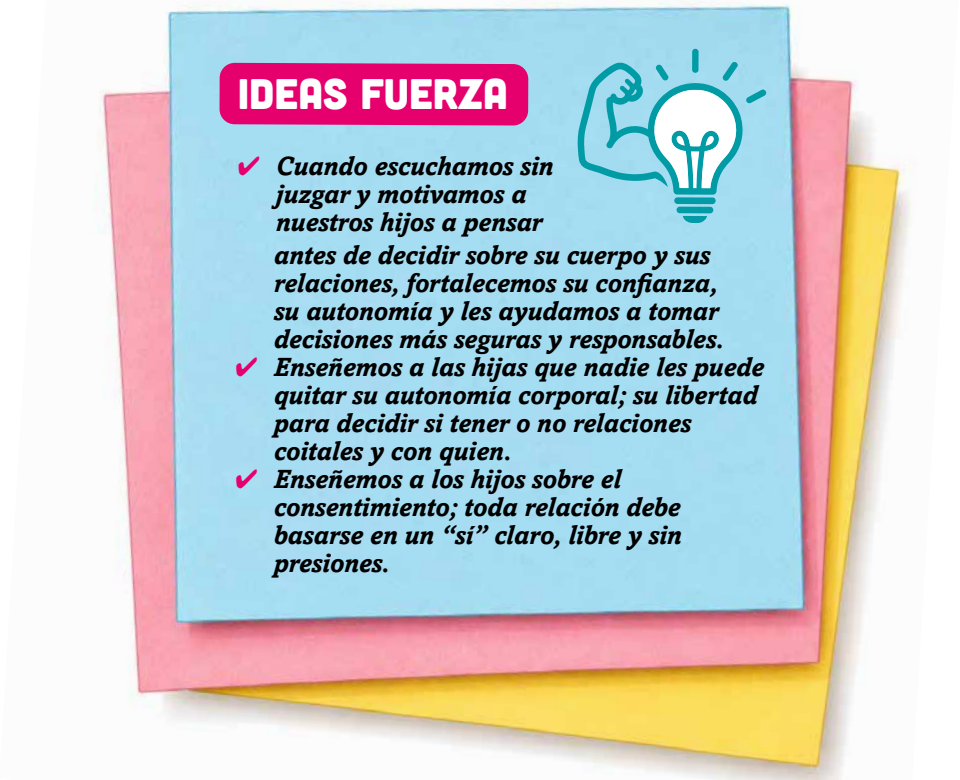
ADAPTACIÓN

Una variante para trabajar con participantes no letrados es trabajar con todo el grupo, e ir leyendo uno a uno los casos y formulando preguntas de análisis para cada uno.

Autonomía corporal consiste en tener poder y la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, sin violencia ni coacciones. Esto incluye decidir si tener o no relaciones sexuales, cuándo o con quién. Decidir si se desea quedar embarazada, cuándo o con quién. Y, tener libertad de acudir a un establecimiento de salud cuando lo requiera.

El consentimiento para las relaciones sexuales es la expresión clara y explícita que se quiere tener una relación sexual. Si no hay consentimiento configura un delito. Menores de 14 años no pueden dar consentimiento.

Complemente con las siguientes ideas:



Invite a la siguiente actividad que permitirá conocer sobre los métodos anticonceptivos

Actividad 4. Nuestros aliados: los métodos anticonceptivos (20 minutos)

Para esta actividad seleccione algunos mitos del recurso 4, según aspectos del contexto local que necesite reforzar.

Solicite al grupo que se ponga de pie y se ubiquen al centro del auditorio.

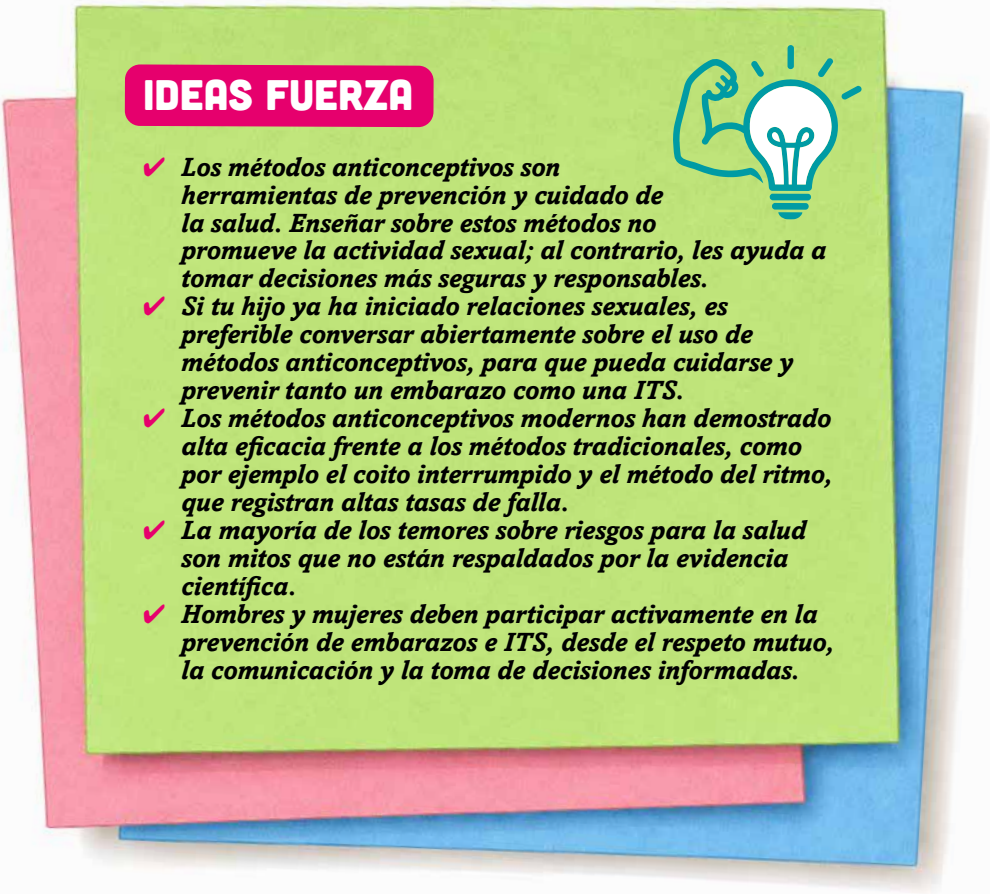
Explique que:

- Leerá unas frases sobre lo que se dice o cree de los métodos anticonceptivos (Recurso Nº 4)
- Luego de escuchar la frase, cada uno debe pensar si está **De acuerdo, en desacuerdo o tiene dudas sobre la frase**.
- Debe dirigirse al cartel correspondiente **De acuerdo, en desacuerdo o tiene dudas**, que previamente estarán pegados en distintas partes del salón.

ADAPTACIÓN

Sentados en circulo el facilitador lee una a una las frases. Cada participante expresa si está de acuerdo o no, mostrando una tarjeta de cualquiera de los siguientes colores: Rosado si están en desacuerdo, Verde si están de a acuerdo, Amarillo: si tienen dudas.

Luego pregunte ¿porqué están de acuerdo? ¿porqué tienen dudas? ¿porqué en desacuerdo? y aclare los mitos haciendo uso del Recurso Nº 4.



Los establecimientos de salud cuentan con servicios para adolescentes tanto en consejería en salud sexual y reproductiva como en acceso a métodos anticonceptivos si así lo requieren. Si desean mayor información también pueden llamar a la línea 113 opción 3 del Ministerio de Salud.

CIERRE:

Actividad 5. Momento creativo (10 minutos)

- **Aplicación práctica:** Forme grupos para que trabajen un lema o mensaje clave, dirigido a adolescentes, sobre tomar decisiones para prevenir el embarazo y las ITS.
- **Compromiso personal:**

  Cada participante redacta en una tarjeta un compromiso sobre los temas abordados. Se colocan las tarjetas en el Muro de los compromisos.

"Transformemos nuestra mirada: el embarazo adolescente no es un error a juzgar, sino una situación que podemos evitar con información, acompañamiento y comprensión"



Recursos

Recurso 1

TESTIMONIO DE EMBARAZO ADOLESCENTE (material en el caso de usar la adaptación).

Lucia, una adolescente de 15 años de Piura, vio cómo su vida cambió completamente cuando a los 14 años confirmó su embarazo. “Recuerdo que mi mamá se puso a llorar. Mi papá no me dirigió la palabra en meses. Yo tenía miedo de que me botaran de mi casa”, confiesa Lucía.

Hoy, con su bebé de cuatro meses en brazos, Lucía enfrenta nuevos desafíos. Su padre comenzó a aceptar la situación después del nacimiento de su nieta y ahora le brinda apoyo dado que el papá de la bebé no se hizo responsable. Lucía planea retomar sus estudios y poder concluir la secundaria, pero tiene temor. “Ha sido muy pesado cuidar a mi bebé y no sé cómo haré con las tareas del colegio”, comparte con voz preocupada. Su madre le ha prometido ayudarla con el cuidado de la niña, pero Lucía sabe que será difícil: “Ella ya tiene que cuidar a mis hermanos y atender su negocio de comida. No quiero ser una carga más”.

Entre los desafíos de la maternidad temprana y su deseo de terminar el colegio, Lucía vive dividida entre la esperanza y el miedo al fracaso. “Quiero estudiar para darle un mejor futuro a mi hija, pero me da miedo no poder con todo”.

Recurso 2

REFLEXIONANDO SOBRE EL EMBARAZO Y LAS ITS

¿Conoces algún caso de un familiar o vecina que se embarazó antes de los 18 años? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué consecuencias tuvo el embarazo a esa edad?	¿Conoces algún caso de un joven que fue padre antes de cumplir los 18 años? ¿cómo la paternidad afectó su vida?	¿Por qué ocurren embarazos durante la adolescencia?
		¿Por qué ocurren las ITS en adolescentes?
¿Quién es responsable de educar para la prevención del embarazo y de las ITS?	¿En una relación de enamorados de quien depende usar métodos para prevenir un embarazo?	¿Quiénes sufren las mayores consecuencias del embarazo?, ¿las mujeres o los varones?
		¿Quiénes adquieren las ITS?, ¿cuál es el peligro de tener ITS?
¿Cómo puede un padre o madre ayudar a su hijo(a) a tomar decisiones para prevenir el embarazo y las ITS?		¿Cómo pueden los adolescentes evitar el embarazo?
¿Cómo pueden los adolescentes evitar las ITS?	¿Qué beneficios tiene postergar el inicio de las relaciones sexuales?	¿Qué deberían decir o enseñar los padres, madres y cuidadores sobre el embarazo y las ITS?
¿Cómo puede un padre o madre enseñar a su hijo(a) a prevenir un embarazo en la adolescencia?	¿A dónde puede recurrir un/a adolescente que quiere aprender a protegerse contra el embarazo y las ITS?	¿Qué deberían enseñar los padres, madres y cuidadores a los hijos sobre el consentimiento?
¿Qué deberían enseñar los padres, madres y cuidadores a las hijas sobre cuidar el cuerpo?	¿En qué lugar pueden los adolescentes mayores de 14 años recibir orientación y consejería y de ser el caso, métodos para prevenir embarazos e ITS?	

Comodín:

Canta una canción	Baila una música de tu tierra	Cuenta un cuento o cuenta un chiste
Grita: “soy la mejor madre del mundo”, “Soy el mejor padre del mundo”	¿Cómo se prepara un plato típico de tu pueblo?	

Recurso 3

Si tu fueras su padre o madre... ¿qué dirías?



Tu hija de 17 años, está enamorada, él tiene 18 años, y es un joven muy correcto y educado, hijo de una pareja de vecinos muy queridos y respetados en Huanta. Tu hija está muy enamorada de él, y se ve que se llevan muy bien. Un día, pensativa, te comenta: "mamá creo que Javier quiere que tengamos relaciones sexuales, dice que pronto nos vamos a casar.

- ¿Qué debo hacer?
- ¿Qué le dirías?
- ¿Cómo la ayudarías a tomar una decisión?



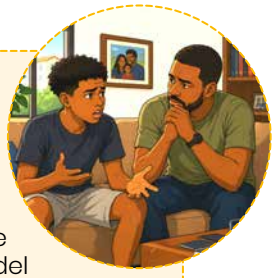
A tu hijo de 17 años lo encontraron inconsciente en un parque, él te cuenta que sus amigos lo invitaron a salir con unas chicas que habían conocido en un festival, el domingo pasado. Ellos planeaban tener relaciones íntimas con ellas. Ese día tomaron unas gaseosas y no se acuerda de nada más.

- ¿Qué harías?
- ¿Qué le dirías sobre sus decisiones?
- ¿Qué le dirías sobre las relaciones sexuales?



A tu hija de 16 años, la invitaron a una fiesta, te cuenta que jugaron a la botella borracha y a ella le tocó ir a un cuarto con un chico. Muy avergonzada te cuenta que estaba asustada, pero tuvo sexo con él. Llorando te dice que tenía que hacerlo porque si no sería "la rara del grupo", ya que sus amigas y amigos dicen que ya lo han hecho.

- ¿Qué harías?
- ¿Qué le dirías de las relaciones sexuales?
- ¿Qué le dirías sobre su derecho a decidir?



Tu hijo te cuenta que, en su grupo de 5 amigos, tres ya tuvieron relaciones con sus enamoradas, que le dicen que se lance con la chica que le gusta, que no sea el bebé del grupo.

- ¿Qué le dirías sobre las relaciones sexuales?
- ¿Qué le dirías sobre por qué sus amigos le dicen que deje de ser el bebe? (Respuesta esperada: creen falsamente que tener relaciones les da el estatus de hombre de verdad)
- ¿Qué le dirías sobre respetar la voluntad de la chica?

Tu sobrina de 13 años vive contigo. Te cuenta que, la última vez que uno de sus tíos llegó a casa de visita, la obligó a tener relaciones. Esto pasó cuando ella le llevó las sábanas para tender la cama. Ella se sintió muy mal, pero no lo contó porque él le dijo que se callara, que no le iban a creer. Ella desea que ya nunca más ese tío regrese a su casa.

- ¿Qué harías?
- ¿Qué piensas de esta situación?
- ¿Qué le dirías?



Recurso 4

MITOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

1. **"Usar condón reduce el placer, por eso no vale la pena".**
   Corrección: El condón puede cambiar en algo la sensación, su uso correcto protege contra embarazos e ITS. Enseñar a elegir talla y a usarlo correctamente mejora la experiencia y la protección.

2. **"Los condones se rompen casi siempre".**
   Corrección: Si se usan correctamente (fecha, almacenamiento, colocación, lubricante compatible), las roturas son raras. La principal causa de fallo es el uso incorrecto.

3. **"Hay 'días seguros' del ciclo menstrual en los que no se puede quedar embarazada".**
   Corrección: Existen días de mayor o menor probabilidad, pero no hay días 100% seguros. Los métodos basados solo en cálculo de 'días seguros' son poco fiables para evitar el embarazo.

4. **"Los anticonceptivos hormonales causan infertilidad permanente".**
   Corrección: La evidencia no respalda que los anticonceptivos causan infertilidad a largo plazo; la fertilidad suele regresar tras suspender el método, según el tipo.

5. **"Los DIU (T de cobre o intrauterinos) no son para adolescentes; causan infertilidad o infecciones graves".**
   Corrección: Los DIU son seguros y efectivos también para jóvenes y adolescentes; la edad no es una contraindicación por sí sola. Requieren evaluación médica, pero no causan infertilidad si se colocan y cuidan adecuadamente.

6. **"La píldora oral de emergencia (AOE) provoca aborto o daña la salud reproductiva".**
   Corrección: La anticoncepción de emergencia evita la implantación o la ovulación y no es abortiva; no causa infertilidad y su uso es seguro [44].

7. **"Si haces sexo oral no puedes contagiarte de ITS (incluido el VIH) ".**
   Corrección: Falso. Algunas ITS (gonorrea, sífilis, herpes, VPH, VIH en menor probabilidad) pueden transmitirse por sexo oral; el uso de barreras reduce el riesgo.

8. **"El método del coitus interruptus (retirar antes de eyacular) protege de un embarazo"**
   Corrección: Es poco fiable: puede haber esperma antes de la eyaculación y los fallos son frecuentes; no protege frente a ITS.

9. **"Los anticonceptivos hormonales provocan cáncer".**
   Corrección: La evidencia es matizada: algunos estudios asocian cambios muy pequeños en riesgo para ciertos cánceres y reducción en otros (por ejemplo, menor riesgo de cáncer de ovario). En general, los beneficios superan los riesgos para la mayoría, y la decisión debe evaluarse con un profesional [45].

---

44 La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda la seguridad de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). Su uso no causa daños graves, permanentes ni infertilidad. Funciona retrasando la ovulación y no es un método abortivo ni interrumpe embarazos en curso. Se puede ingerir hasta 5 días (120 horas) después de la relación sexual sin protección. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception

45 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-contraceptives

10. **"Si estás en tu periodo no puedes quedar embarazada".**
    Corrección: Aunque la probabilidad suele ser menor en ciertos días, existen casos en que la ovulación es irregular y relaciones durante la menstruación pueden llevar a embarazo. No es una protección segura.

11. **"Los métodos modernos (inyección, implante, DIU) son solo para mujeres que ya tuvieron hijos".**
    Corrección: Muchos métodos (implantes, DIU, inyecciones, pastillas) son seguros para personas que no han tenido hijos; la elección debe basarse en salud, preferencias y asesoría profesional.

12. **"Si estás tomando antibióticos la píldora deja de funcionar siempre".**
    Corrección: Solo algunos antibióticos (p. ej. Rifampicina) reducen la eficacia; la mayoría no lo hace. Aun así, ante dudas se recomienda usar método adicional o consultar con un especialista.

13. **"El uso de métodos anticonceptivos vuelve liberales a los adolescentes".**
    Falso: La protección no es sinónimo de libertinaje; es una herramienta de autocuidado y responsabilidad, no de promoción de conductas.

14. **"La responsabilidad de cuidarse es de la mujer".**
    Falso: el cuidado es de **ambas partes**. Tanto hombres como mujeres deben asumir la coresponsabilidad de prevenir embarazos e ITS.

15. **"Si una mujer usa la píldora del día siguiente es porque es promiscua o liberal".**
    Falso: la anticoncepción de emergencia es un recurso válido y responsable para prevenir un embarazo no planificado. Elegir la anticoncepción oral de emergencia no refleja los valores ni la forma de ser de una persona; es una decisión personal.

16. **"Los adolescentes no deberían usar métodos anticonceptivos; solo los adultos".**
    Falso: los adolescentes tienen derecho a protegerse y acceder a métodos modernos de manera segura e informada.

17. **"Las señoritas 'decentes' no usan métodos anticonceptivos".**
    Falso: el uso de anticonceptivos no tiene nada que ver con la decencia o los valores de una persona. Usarlos es un acto de **cuidado de la salud sexual y reproductiva, prevención y responsabilidad.**

18. **"Si una mujer pide usar condón es porque no confía en su pareja".**
    Falso: pedir protección es una muestra de **amor propio, cuidado mutuo y responsabilidad compartida**.

Referencias Bibliográficas

Barragán-Pérez, V., & Fouilloux-Morales, C. (2021). Actitudes hacia la sexualidad en adolescentes: Diferencias generacionales y de género. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 19(3), 121. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2021000300094

Blakemore, S.-J., & Mills, K. (2014). Is adolescence a sensitive period for sociocultural processing? Annual Review of Psychology, 65, 187–207. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115202

Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2019). El poder de decidir: Derechos reproductivos y transición demográfica. UNFPA. https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWOP%202018%20ESP%20WEB_0.pdf

Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2021). Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación. UNFPA. https://peru.unfpa.org/es/publications/brochure-institucional-mi-cuerpo-me-pertenece

Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2023). Educación integral en sexualidad: Conceptos, enfoques y competencias. UNFPA. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/265335spa.pdf

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2019). La adolescencia: una etapa clave. UNICEF.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2021). Herramientas para el diálogo en familia. UNICEF.

González-Quiñones, J. C., Restrepo-Chavarriaga, J. F., & Rojas-Berrio, S. P. (2019). Cambios generacionales en las actitudes sobre sexualidad y relaciones de género. Universidad de Caldas.

Keelin, H., Schoemaker, P., & Spetzler, C. (2009). Decision quality. The fundamentals of making good decisions. Decision Education Foundation. https://www.decisioneducation.org/curriculum

Krauskopf-Roger, D. (2019). Relaciones intergeneracionales, emancipación e independencia de jóvenes estudiantes chilenos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 17(1), 75-87. https://dx.doi.org/10.11600/1692715x.17104

Kroger, J. (2015). Identity in adolescence: The balance between self and other (4th ed.). Routledge.

Luyckx, K., Schwartz, S. J., Goossens, L., Beyers, W., & Missotten, L. (2013). Processes of personal identity formation and evaluation. In Handbook of adolescent psychology (pp. 105–137).

Meeus, W. (2011). The study of adolescent identity formation 2000–2010: A review of longitudinal research. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 75–94. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00716.x

Ministerio de Educación de la Nación (2021) Educación Sexual Integral para charlar en familias / 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2021.

Ministerio de Salud del PERÚ (MINSA) (2022) Módulo educativo Desarrollando capacidades para la promoción de una salud sexual. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Promoción de la Salud.

Ministerio de Salud del Perú (MINSA) (2025) Guía metodológica para el desarrollo de talleres educativos de salud sexual dirigidos a adolescentes en espacios comunitarios / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Promoción de la Salud - Lima: Ministerio de Salud; 2025.

Ministerio de Salud del Perú [MINSA]. (2023). Guía para madres y padres en el acompañamiento de adolescentes. MINSA.

Organización Panamericana de la Salud. (2018). Promoción de la salud mental en la adolescencia: Guía para facilitadores. OPS. https://iris.paho.org/handle/10665.2/49194

Potard, C., Courtois, R., & Rusch, E. (2008). The influence of peers on risky sexual behaviour during adolescence. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 13(3), 264–270. https://doi.org/10.1080/13625180802273530

Ruiz, M. J., & Garrido, R. (2018). Nuevas masculinidades y transformaciones en las relaciones de género. Revista de Estudios Sociales, (65), 92–105. https://doi.org/10.7440/res65.2018.08

Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Luyckx, K., Meca, A., & Ritchie, R. A. (2013). Identity in emerging adulthood: Reviewing the field and looking forward. Emerging Adulthood, 1(2), 96–113. https://doi.org/10.1177/2167696813479781

Sieving, R. E., Eisenberg, M. E., Pettingell, S., & Skay, C. (2006). La influencia de los amigos en la primera relación sexual de los adolescentes. Perspectivas sobre la salud sexual y reproductiva, 38(1), 13–19. https://doi.org/10.1363/3801306

Telzer, E. H., van Hoorn, J., Rogers, C. R., & Do, K. T. (2017). Social influence on positive youth development: A developmental neuroscience perspective. Advances in Child Development and Behavior, 54, 215–258. https://doi.org/10.1016/bs.acdb.2017.10.003

Twenge, J. M., & Wells, B. E. (2005). Changes in young people's sexual behavior and attitudes, 1943–1999: A cross-temporal meta-analysis. Review of General Psychology, 9(3), 249–261. https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.3.249

Twenge, J. M., Sherman, R. A., & Wells, B. E. (2015). Changes in American adults' sexual behavior and attitudes, 1972–2012. Archives of Sexual Behavior, 44(8), 2273–2285. https://doi.org/10.1007/s10508-015-0540-2

UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres, & OMS. (2018). Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: Un enfoque basado en la evidencia (2ª ed. rev.). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335

Van Eldik, A., Kneer, J., & Jansz, J. (2019). Urban & Online: Social Media Use among Adolescents and Sense of Belonging to a Super-Diverse City. Media and Communication, 7(2), 242-253. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1879

Widman, L., Choukas-Bradley, S., Helms, S. W., & Prinstein, M. J. (2016). Adolescent susceptibility to peer influence in sexual situations. Journal of Adolescent Health, 58(3), 323–329. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.10.253

Anexos

Anexo 1 Técnicas de evaluación del nivel de satisfacción de las y los participantes con las sesiones

a. "Una sola palabra"

Al finalizar la sesión solicite a los participantes que, utilizando una sola palabra, califiquen qué les ha parecido la sesión.

El co-facilitador toma nota de las palabras empleadas.

b. Tiro al blanco

Se coloca un papelógrafo con el gráfico de tiro al blanco. Se entregan post its y se les pide que coloquen en el papelógrafo un post it. Cuando más cerca coloquen el post it al centro del tiro al blanco significa mayor satisfacción.

c. Usando emoticones

Se coloca un papelógrafo en blanco y se les solicita que dibujen un emoticón que represente cómo se evalúa la sesión.

d. Tres caritas

Se dibuja en un papelógrafo, tres caritas: Feliz – Indiferente – Triste. Y se pide que marquen con un plumón cualquiera de ellas, que represente cómo se han sentido con la sesión.

e. "Cabeza, corazón y manos"

Si el tiempo lo permite, luego de cada sesión, reparta la hoja del anexo 2 para que respondan.

- ¿Qué nuevo conocimiento aprendió?
- ¿Qué sentimientos le inspiró la sesión?
- ¿Cómo aplicará lo aprendido en su vida diaria?

Anexo 2 "Cabeza, corazón y manos"

TALLER:

SESIÓN:

¿Qué aprendí?

La cabeza: Representa la información, las nuevas ideas, los conceptos.

¿Qué nuevo conocimiento aprendí hoy?

¿Qué Idea fuerza me llevo?

_____

_____

_____



Corazón: Representa los sentimientos, cosas que descubrí sobre mí mismo, cambios en creencias y valores.

¿Qué siento?

_____

_____

_____



Manos: Nuevas habilidades, cosas que haré de una manera diferente, acciones que tomaré.

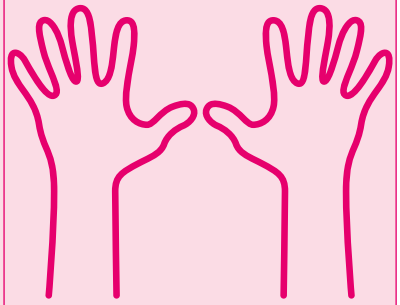
¿Cómo voy a aplicar lo aprendido?

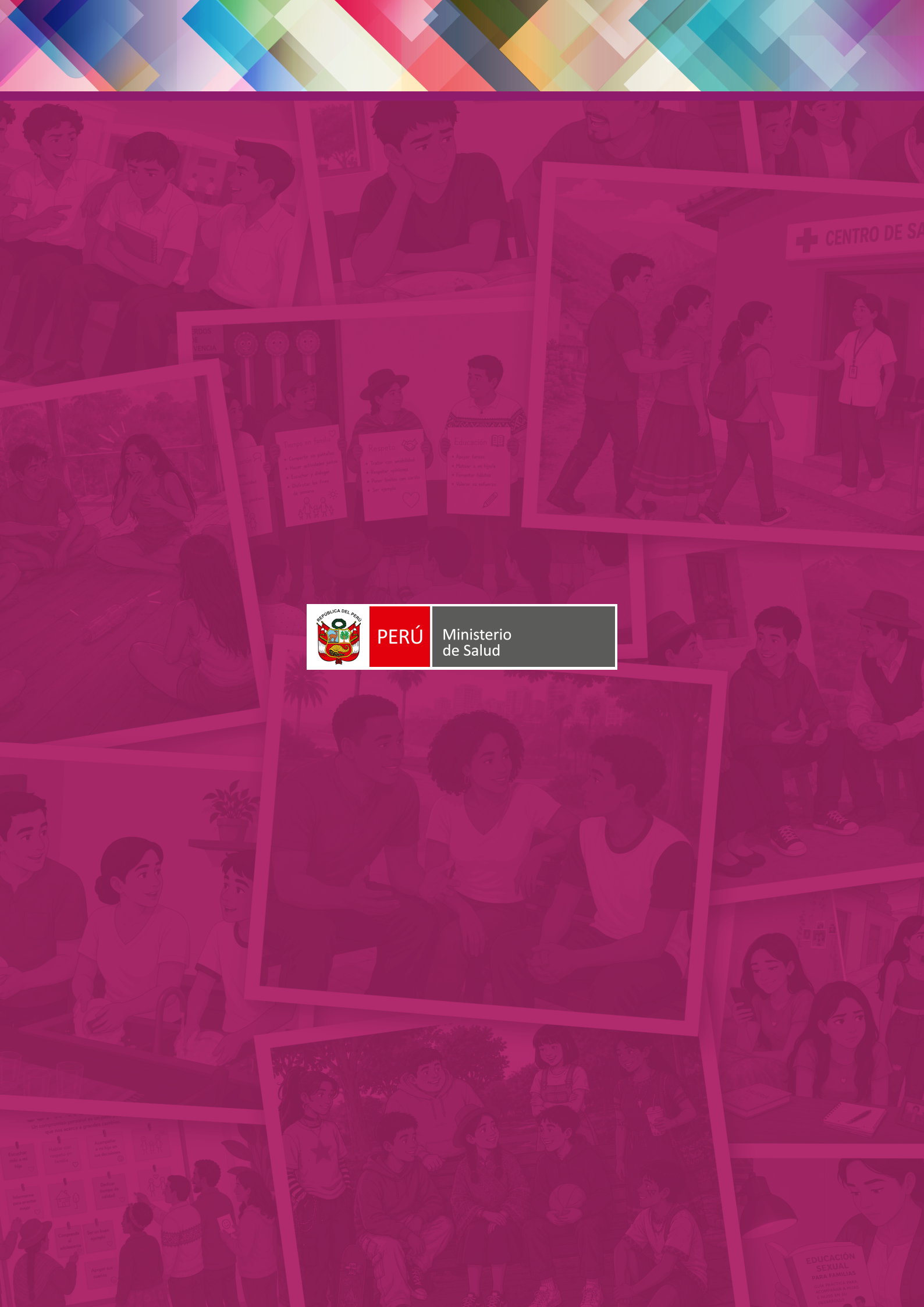
¿A qué me comprometo?

_____

_____

_____





PERÚ | Ministerio de Salud